

Buku Referensi
**MENINGKATKAN KESEHATAN
MENTAL DI KALANGAN
REMAJA**

Nina Rizka Rohmawati
Nur Eni Lestari
Nuniek Setyo Wardani
Ahmad Guntur Alfianto
Syahrul

BUKU REFERENSI MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL DI KALANGAN REMAJA

Nina Rizka Rohmawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An.

Ns. Nuniek Setyo Wardani, S.Kep., M.Kep.

Ahmad Guntur Alfianto, S.Kep., Ns., M.Kep.

H. Syahrul, SKM., M.Kes



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL DI KALANGAN REMAJA

Penulis: Nina Rizka Rohmawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An.

Ns. Nuniek Setyo Wardani, S.Kep., M.Kep.

Ahmad Guntur Alfianto, S.Kep., Ns., M.Kep.

H. Syahrul, SKM., M.Kes

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9396-7

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul "**Meningkatkan Kesehatan Mental di Kalangan Remaja**" ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini didasarkan atas kepedulian yang mendalam terhadap kondisi mental remaja di Indonesia, yang kian menjadi perhatian serius akibat berbagai tekanan dan perubahan yang dialami selama masa pertumbuhan mereka.

Remaja merupakan fase penting dalam kehidupan, di mana berbagai aspek seperti fisik, emosional, dan sosial mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini menjadikan mereka rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, hingga perilaku berisiko yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Buku ini disusun sebagai referensi yang sistematis untuk membantu tenaga pendidik, orang tua, praktisi kesehatan mental, serta para remaja itu sendiri dalam memahami dan mengelola tantangan kesehatan mental yang mereka hadapi. Materi dalam buku ini dikaji dari berbagai hasil penelitian ilmiah terbaru serta pengalaman praktis dalam dunia pendidikan dan kesehatan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk masukan, saran, dan dukungan selama proses penyusunan buku ini. Kami sadar bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan edisi berikutnya.

Semoga buku ini menjadi acuan yang bermanfaat dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat secara mental, sehingga mampu menghadapi masa depan dengan optimisme, percaya diri, dan kesejahteraan mental yang optimal.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I FAKTOR RISIKO PSIKOLOGIS PADA REMAJA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Perubahan Hormonal	2
C. Gangguan Identitas dan Citra Diri	3
D. Isolasi Sosial.....	4
E. Stres Akademik	6
F. Masalah Keluarga	8
G. Pengaruh Teman Sebaya.....	9
H. Bullying atau Perundungan	12
I. Pengalaman Traumatis	14
J. Penggunaan Zat Terlarang	16
K. Peran Media Sosial	18
L. Penutup	20
Referensi.....	22
BAB II PENGARUH POLA ASUH TERHADAP PERKEMBANGAN MENTAL REMAJA	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Perkembangan, Sifat, dan Sikap Remaja	27
1. Perkembangan Remaja	27
2. Sifat dan Sikap Remaja.....	29
C. Konsep Keluarga	29
1. Definisi Keluarga	29
2. Tipe atau Bentuk Keluarga	31
3. Fungsi Keluarga.....	32
D. Pola Asuh Orang Tua.....	33
1. Definisi Pola Asuh Orang Tua	33
2. Jenis-Jenis Pola Asuh Orang Tua	33
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua	34
E. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua pada Remaja.....	36
F. Hubungan Pola Asuh dengan Kesehatan Remaja	36
G. Aspek Perkembangan Remaja yang Dipengaruhi Oleh Pola Asuh Orang Tua	38
H. Penutup	38
Referensi.....	39
BAB III PERAN SEKOLAH DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL.....	41
A. Pendahuluan.....	41
B. Masalah Kesehatan Mental Usia Sekolah.....	42
C. Peran Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Primer.....	45
D. Upaya Sekolah dalam Pencegahan Sekunder	47
E. Upaya Sekolah dalam Pencegahan Tersier	49

F. Upaya Sekolah dalam Kesehatan Mental Pada Situasi Khusus.....	51
G. Penutup	53
Referensi.....	55
BAB IV PEMANFAATAN APLIKASI DIGITAL UNTUK LAYANAN KESEHATAN MENTAL ..	66
A. Pendahuluan.....	66
B. Pentingnya Kesadaran Kesehatan Mental pada Remaja	67
C. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Remaja.....	68
D. Upaya Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Mental	70
E. Terapi Mandiri dan Manajemen Stress pada Remaja.....	71
F. Akses Pelayanan Kesehatan Mental pada Remaja.....	72
G. Kondisi Akses Pelayanan Kesehatan pada Remaja	72
H. Hambatan dalam Akses Layanan Kesehatan Mental pada Remaja	73
I. Upaya untuk Meningkatkan Akses Layanan Digital untuk Kesehatan Mental	75
J. Akses Mudah ke Layanan Kesehatan Mental Melalui Konseling Online Berbasis Aplikasi	77
K. Penutup	77
Referensi.....	79
BAB V STRATEGI BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL	
REMAJA	82
A. Pendahuluan.....	82
B. Konsep dan Teori Kesehatan Mental Remaja	84
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Remaja	87
D. Model Kesehatan Mental Remaja Berbasis Komunitas.....	92
E. Peran dan fungsi komunitas dalam mendukung kesehatan mental remaja:	97
F. Penutup	111
Referensi.....	115
Profil Penulis	116

BAB I

FAKTOR RISIKO PSIKOLOGIS PADA REMAJA

A. Pendahuluan

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Pada tahap ini, individu mulai membangun identitas diri, merasakan kebebasan yang lebih besar, serta menghadapi tantangan-tantangan baru yang memengaruhi kesehatan psikologis mereka. Meskipun masa remaja adalah waktu yang penuh potensi dan peluang untuk pertumbuhan, periode ini juga membawa risiko psikologis yang perlu diwaspadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental remaja sangat beragam dan kompleks, baik berasal dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal yang mengelilinginya.

Faktor risiko psikologis pada remaja dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan perkembangan pribadi individu, seperti perubahan hormonal, kebingungan identitas diri, serta tekanan akademik yang dialami. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh dari lingkungan sosial, keluarga, teman sebaya, dan media sosial, yang memiliki dampak langsung terhadap kondisi psikologis remaja. Masalah keluarga, bullying, serta tekanan sosial dari teman sebaya dan media sosial adalah beberapa contoh faktor eksternal yang dapat memperburuk kesejahteraan mental remaja.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor risiko ini sangat penting, mengingat dampaknya yang bisa berlanjut hingga fase dewasa. Penelitian dalam bidang psikologi remaja menunjukkan bahwa interaksi antara faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi munculnya gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku lainnya. Dengan menelaah faktor-faktor ini secara kritis, diharapkan kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, serta memberikan dukungan yang tepat untuk membantu remaja mengatasi tantangan yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat berkembang dengan sehat dan seimbang dalam menghadapi dinamika kehidupan.

B. Perubahan Hormonal

Perubahan hormonal yang terjadi selama masa remaja merupakan salah satu aspek paling mendasar dalam perkembangan psikologis individu. Masa remaja ditandai dengan perubahan signifikan dalam sistem hormonal, yang dipicu oleh proses pubertas. Proses ini mengarah pada peningkatan produksi hormon-hormon utama seperti estrogen, testosteron, dan kortisol, yang masing-masing memiliki dampak langsung terhadap kondisi fisik dan psikologis remaja (King et al., 2020; Li, 2024). Hormon-hormon ini tidak hanya berperan dalam perkembangan fisik seperti pertumbuhan tubuh dan pembentukan ciri-ciri seks sekunder, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mengatur suasana hati, emosi, dan perilaku.

Salah satu dampak utama dari perubahan hormonal adalah fluktuasi suasana hati yang sering dialami oleh remaja. Perubahan kadar hormon estrogen dan testosteron dapat menyebabkan perubahan emosi yang cepat, mulai dari perasaan euforia hingga depresi. Hormon ini mempengaruhi otak, khususnya area yang bertanggung jawab atas regulasi emosi dan pengambilan keputusan, seperti sistem limbik dan korteks prefrontal (King et al., 2020; Li, 2024). Akibatnya, remaja cenderung lebih sensitif terhadap perasaan cemas, marah, atau bahkan bahagia yang berlebihan, sering kali tanpa alasan yang jelas. Fluktuasi emosi ini, yang sering kali disebut "mood swings", adalah bagian normal dari perkembangan pubertas, namun dapat menimbulkan tantangan dalam interaksi sosial dan hubungan dengan orang lain.

Selain itu, perubahan hormonal juga dapat mempengaruhi persepsi diri dan citra tubuh pada remaja. Peningkatan hormon seks berkontribusi pada perubahan fisik yang signifikan, seperti perkembangan payudara pada perempuan dan peningkatan massa otot pada laki-laki (Del Ciampo & Del Ciampo, 2024; Toselli et al., 2022). Meskipun perubahan ini adalah bagian dari proses alami, mereka dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau kebingungan terkait citra tubuh, yang sering kali dipengaruhi oleh standar kecantikan atau maskulinitas yang ada dalam masyarakat. Beberapa remaja mungkin merasa kurang percaya diri dengan perubahan tubuh mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka, termasuk peningkatan risiko gangguan makan atau gangguan kecemasan.

Perubahan hormon juga berdampak pada pola tidur remaja (Yang, 2024). Fluktuasi hormon, terutama dalam produksi melatonin yang mengatur siklus tidur, dapat menyebabkan remaja kesulitan tidur atau mengalami gangguan tidur. Kualitas tidur yang buruk ini dapat memperburuk suasana hati dan meningkatkan

kecemasan atau depresi. Kurang tidur juga berpengaruh pada daya konsentrasi dan kinerja akademik, yang pada gilirannya dapat memperburuk perasaan stres.

C. Gangguan Identitas dan Citra Diri

Masa remaja adalah fase perkembangan yang penuh dengan pencarian identitas diri, di mana individu berusaha memahami siapa diri mereka sebenarnya, apa nilai-nilai yang mereka anut, serta bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain (Izzani et al., 2024). Pada periode ini, remaja mengalami berbagai perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Proses pencarian identitas ini sering kali disertai dengan kebingungan, terutama ketika remaja dihadapkan pada tekanan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman sebaya, dan media sosial.

Salah satu aspek yang paling terpengaruh selama masa pencarian identitas adalah citra diri—gambaran diri yang dimiliki individu tentang penampilan, kemampuan, dan nilai diri mereka. Remaja sering kali merasa terpecah antara apa yang mereka rasakan tentang diri mereka dan bagaimana mereka ingin dikenali atau diterima oleh orang lain (Juli & Juli, 2020). Proses ini bisa menjadi sumber kebingungan, terutama jika remaja merasa tidak memenuhi ekspektasi diri atau orang lain tentang siapa mereka seharusnya menjadi. Ketidakpuasan terhadap citra tubuh atau penampilan fisik merupakan hal yang umum pada masa ini. Remaja mungkin merasa tidak sesuai dengan standar kecantikan atau maskulinitas yang sering dipromosikan oleh media, sehingga perasaan kurang percaya diri atau rendah diri mulai muncul.

Bagi sebagian remaja, ketidakpuasan terhadap citra diri ini bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, seperti gangguan makan (misalnya anoreksia atau bulimia), yang muncul sebagai upaya untuk mengendalikan penampilan fisik. Gangguan-gangguan ini tidak hanya terkait dengan masalah fisik, tetapi juga menggambarkan ketidaksesuaian antara cara pandang remaja terhadap tubuh mereka dan kenyataan yang ada. Selain itu, ketidakpuasan terhadap citra diri juga dapat berhubungan dengan gangguan kecemasan sosial atau depresi, di mana perasaan tidak cukup baik atau tidak diterima oleh orang lain dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja secara keseluruhan.

Pencarian identitas diri remaja juga sering kali terhambat oleh perubahan peran sosial yang terjadi seiring bertambahnya usia. Remaja mulai berinteraksi dengan dunia sosial yang lebih luas, yang meliputi teman sebaya, masyarakat, dan dunia digital. Dalam lingkungan ini, mereka sering terpapar pada berbagai norma

sosial yang menuntut untuk tampil dengan cara tertentu (Avci et al., 2024; Paleczna, 2024). Tuntutan ini bisa mengarah pada konflik identitas, di mana remaja merasa terjepit antara keinginan untuk menjadi diri mereka sendiri dan tekanan untuk mengikuti norma-norma yang berlaku di sekitar mereka. Tekanan ini dapat menambah kebingungan tentang siapa mereka sebenarnya dan apa yang seharusnya mereka capai.

Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan dominasi media sosial, remaja saat ini sering kali menghadapi tantangan tambahan dalam pencarian identitas mereka. Media sosial, dengan segala keberagaman konten dan standar kecantikan yang sering kali tidak realistis, sering kali memperburuk perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Perbandingan sosial yang terus-menerus dapat meningkatkan kecemasan dan perasaan ketidakmampuan, karena remaja cenderung membandingkan diri mereka dengan teman-teman atau selebritas yang tampaknya memiliki kehidupan yang lebih sempurna. Fenomena ini disebut sebagai *social comparison theory*, yang mengacu pada kebiasaan individu untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain sebagai cara untuk menilai keberhasilan atau kualitas diri mereka (Buunk, 2024; Matthews & Kelemen, 2024).

D. Isolasi Sosial

Isolasi sosial adalah pengalaman di mana individu merasa terputus atau terpisah dari lingkungan sosialnya, baik itu teman sebaya, keluarga, atau komunitas yang lebih besar. Pada masa remaja, perasaan kesepian atau terisolasi dapat muncul akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang berpotensi mengganggu perkembangan psikologis mereka. Fase ini merupakan waktu di mana remaja mulai mencari jati diri mereka dalam konteks hubungan sosial, dan ketika mereka merasa tidak diterima atau tidak memiliki tempat untuk berinteraksi, perasaan terisolasi ini bisa sangat berdampak pada kesehatan mental mereka (Hilliard et al., 2024; Khairina, 2024; Thompson et al., 2024).

Remaja yang merasa terisolasi sering kali mengalami penurunan harga diri. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa diterima dan dihargai oleh orang lain, dan selama masa remaja, penerimaan sosial dari teman-teman sebaya sangat penting. Ketika seorang remaja merasa diabaikan atau tidak terhubung dengan teman-teman mereka, mereka bisa merasa tidak cukup baik atau tidak layak untuk diterima (Angelina et al., 2024; Pascoal et al., 2024; Shah et al., 2024). Perasaan ini, jika tidak ditangani dengan baik, bisa mengarah pada rendahnya harga diri, yang pada gilirannya meningkatkan risiko masalah psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan, atau gangguan perilaku.

Selain itu, isolasi sosial juga berhubungan dengan perasaan kesepian yang sering kali dialami oleh remaja, meskipun mereka mungkin berada di sekitar banyak orang. Kesepian yang dimaksud di sini tidak hanya berarti kurangnya interaksi fisik, tetapi juga kurangnya kedekatan emosional atau rasa koneksi yang mendalam dengan orang lain. Meskipun mereka memiliki teman sebaya, perasaan terasing atau tidak dimengerti dapat memperburuk keadaan. Remaja yang kesepian sering merasa seperti mereka tidak memiliki tempat untuk berbagi pikiran dan perasaan, yang dapat menyebabkan perasaan tertekan dan cemas. Dalam kasus yang lebih ekstrem, kesepian yang berkepanjangan bisa berkontribusi pada munculnya gangguan mental yang lebih serius, termasuk depresi berat atau bahkan ide bunuh diri.

Faktor lain yang dapat memperburuk isolasi sosial adalah pengaruh dari media sosial (Horan, 2024). Pada era digital saat ini, banyak remaja yang terpapar pada dunia maya sebagai sarana untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka. Namun, meskipun media sosial memberikan kesempatan untuk terhubung, penggunaan yang berlebihan atau tidak sehat dapat meningkatkan perasaan terisolasi. Misalnya, perbandingan diri yang terus-menerus dengan orang lain di platform sosial dapat membuat remaja merasa lebih terasing atau tidak cukup baik. Fenomena ini dikenal sebagai "social media fatigue", di mana remaja merasa cemas atau bahkan kesepian meskipun berada di dunia yang sangat terhubung secara digital. Media sosial, yang sering kali menampilkan kehidupan yang sempurna atau ideal, dapat memicu perasaan kesepian yang lebih dalam, karena remaja merasa bahwa pengalaman mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka lihat secara online.

Keterbatasan dukungan sosial juga menjadi faktor penyebab isolasi sosial. (Arcidiacono et al., 2023). Beberapa remaja mungkin tidak memiliki akses ke jaringan sosial yang mendukung, baik itu dalam keluarga, sekolah, atau komunitas. Ketika remaja tidak merasa didukung atau tidak memiliki orang-orang yang mereka percayai untuk berbicara, isolasi sosial bisa menjadi semakin parah. Dalam beberapa kasus, konflik keluarga atau pengalaman trauma emosional di masa lalu dapat membuat remaja lebih tertutup dan enggan untuk menjalin hubungan sosial yang sehat. Hal ini bisa membuat mereka lebih rentan terhadap perasaan kesepian dan terisolasi.

Isolasi sosial juga berpotensi memperburuk kondisi fisik dan psikologis lainnya. Kurangnya interaksi sosial dapat mengganggu perkembangan keterampilan sosial yang penting bagi remaja, seperti komunikasi efektif, empati, dan resolusi konflik. Selain itu, rasa terisolasi dapat menyebabkan remaja lebih cenderung menghindari interaksi sosial atau menarik diri dari aktivitas yang biasanya mereka nikmati, seperti

olahraga atau kegiatan ekstrakurikuler. Pola perilaku seperti ini dapat memperburuk kecemasan sosial dan memperbesar rasa tidak percaya diri mereka.

E. Stres Akademik

Stres akademik merupakan salah satu bentuk tekanan psikologis yang umum dialami oleh remaja, yang sering kali berkaitan dengan tuntutan untuk mencapai standar akademik tertentu atau memenuhi ekspektasi tinggi yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pada masa remaja, pencapaian akademik sering kali dianggap sebagai indikator utama kesuksesan di masa depan. Hal ini membuat banyak remaja merasa tertekan untuk tampil sempurna di sekolah, mendapatkan nilai tinggi, dan memenuhi harapan orang tua, guru, serta diri mereka sendiri. Meskipun dorongan untuk belajar dan berkembang adalah hal yang positif, tekanan yang berlebihan terhadap prestasi akademik dapat membawa dampak buruk terhadap kesehatan mental remaja, termasuk munculnya kecemasan, stres, dan depresi (Monzonís-Carda et al., 2025; Pienyu et al., 2024; Wang et al., 2025).

Salah satu faktor utama yang memicu stres akademik pada remaja adalah perasaan takut gagal. Remaja yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap diri mereka sering kali merasa cemas jika mereka tidak dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. Kecemasan ini sering kali berakar pada ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain, terutama orang tua dan guru, yang bisa membuat mereka merasa bahwa kegagalan dalam hal akademik adalah suatu hal yang tidak dapat diterima. Ketidakmampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau kesulitan dalam memenuhi tuntutan tugas-tugas yang menumpuk dapat menyebabkan perasaan tidak kompeten, yang semakin memperburuk stres yang mereka alami. Perasaan cemas ini sering kali berkembang menjadi gangguan kecemasan, yang ditandai dengan kekhawatiran berlebihan dan ketegangan yang berlangsung lama.

Selain itu, tekanan akademik sering kali disertai dengan perbandingan sosial yang tidak sehat antara remaja dengan teman-teman sebaya mereka. Ketika seorang remaja merasa bahwa teman-temannya memiliki prestasi lebih baik atau lebih mudah dalam mencapai tujuan akademik, mereka dapat mulai meragukan kemampuan mereka sendiri. Hal ini sering kali memunculkan perasaan rendah diri, ketidakmampuan, dan bahkan perasaan terisolasi. Dalam kasus yang lebih ekstrem, perbandingan ini dapat menyebabkan depresi atau keputusan jika remaja merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai level yang diinginkan atau memenuhi harapan yang ada.

Perasaan tertekan akibat stres akademik juga dapat mengganggu keseimbangan kehidupan remaja secara keseluruhan. Banyak remaja yang merasa

terjebak dalam rutinitas yang penuh dengan tugas, ujian, dan pekerjaan rumah tanpa memiliki waktu untuk bersosialisasi atau beristirahat. Kurangnya waktu luang ini dapat memengaruhi kesehatan fisik mereka, karena stres yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan energi, dan masalah kesehatan lainnya. Pola tidur yang buruk, misalnya, dapat memperburuk kemampuan remaja untuk berkonsentrasi dan memecahkan masalah secara efektif, yang pada gilirannya dapat memperburuk stres akademik yang mereka rasakan (Ye et al., 2025; Wang et al., 2024).

Faktor eksternal, seperti harapan orang tua yang tinggi atau sistem pendidikan yang sangat kompetitif, juga memainkan peran penting dalam stres akademik. Di banyak budaya, prestasi akademik dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mencapai kesuksesan dan status sosial. Oleh karena itu, remaja sering merasa terjebak antara keinginan untuk memenuhi harapan orang tua atau masyarakat dan keinginan mereka untuk mengejar minat atau tujuan pribadi mereka. Ketika ekspektasi ini tidak sejalan dengan kemampuan atau minat remaja, mereka bisa merasa tertekan dan terperangkap dalam dilema yang memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.

Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang banyak dilakukan remaja juga bisa menjadi sumber stres. Banyak sekolah yang menuntut siswa untuk aktif dalam berbagai organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang portofolio mereka. Meskipun kegiatan ini penting untuk pengembangan diri, bagi sebagian remaja, tuntutan untuk berprestasi di banyak bidang sekaligus dapat menjadi beban yang menambah tingkat stres yang sudah mereka rasakan dalam urusan akademik. Remaja yang merasa terbebani oleh banyaknya tuntutan ini dapat mengalami burnout, di mana mereka merasa kelelahan fisik dan mental yang mengganggu fungsi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak stres akademik yang tidak ditangani dengan baik bisa sangat besar dan bertahan lama. Selain meningkatkan risiko gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi, stres akademik yang berkelanjutan juga dapat memengaruhi perkembangan keterampilan sosial, menghambat kreativitas, dan mengurangi motivasi belajar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja, di mana mereka dapat berkembang sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, tanpa merasa tertekan untuk mencapai tujuan akademik yang terlalu tinggi. Pendekatan yang lebih holistik terhadap pendidikan yang mengedepankan kesejahteraan mental, pemahaman yang realistis tentang prestasi, serta dukungan dari orang tua dan guru akan sangat membantu dalam mengurangi dampak negatif dari stres akademik pada remaja.

F. Masalah Keluarga

Konflik keluarga, perceraian orang tua, dan ketidakstabilan dalam rumah tangga adalah faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja. Keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama dalam kehidupan seseorang, dan bagi remaja, lingkungan keluarga adalah tempat di mana mereka membentuk dasar untuk pemahaman diri mereka dan belajar bagaimana berinteraksi dengan dunia luar. Ketika terjadi masalah dalam struktur keluarga, dampaknya bisa sangat besar bagi perkembangan emosional dan psikologis seorang remaja (Tang, 2025; Xu, 2024).

Konflik Keluarga yang berlangsung dalam rumah tangga dapat menciptakan ketegangan yang mendalam bagi remaja. Ketika orang tua terlibat dalam perselisihan yang terbuka atau terpendam, anak-anak, khususnya remaja, sering kali merasakan beban emosional yang besar. Remaja yang berada dalam situasi ini cenderung merasa terjebak di antara pihak-pihak yang berkonflik, yang dapat meningkatkan perasaan cemas, stres, dan kebingungan. Mereka sering kali merasa tidak mampu mempengaruhi situasi yang terjadi di rumah, namun tekanan untuk memilih pihak atau menyelesaikan konflik dapat memperburuk keadaan. Konflik yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan remaja merasa tidak aman atau tidak stabil, mengganggu rasa percaya diri mereka dan mengarah pada kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat di luar rumah (Borecka-Biernat, 2024; Tang, 2025).

Selain itu, perceraian orang tua dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan pada remaja. Meskipun perceraian sering kali menjadi solusi terbaik dalam beberapa situasi, dampaknya terhadap anak-anak, terutama remaja, bisa cukup berat. Perasaan kehilangan yang mendalam dan kebingungan mengenai dinamika keluarga yang berubah drastis bisa memicu perasaan tidak stabil emosional pada remaja. Mereka mungkin merasa terasing dari salah satu orang tua atau merasa terabaikan oleh kedua orang tua, terutama jika mereka harus beradaptasi dengan rutinitas atau pola pengasuhan yang baru. Remaja yang mengalami perceraian sering kali mengalami perasaan terabaikan atau bahkan berpikir bahwa mereka tidak cukup baik untuk menjaga kelangsungan hubungan orang tua mereka. Ketidakmampuan untuk memahami atau menerima perubahan ini bisa menyebabkan perasaan kesepian, dan dalam beberapa kasus, rasa bersalah atau penyesalan yang tidak semestinya.

Ketidakstabilan dalam rumah tangga juga bisa memperburuk kondisi kesehatan mental remaja. Ketika orang tua atau anggota keluarga lainnya menghadapi masalah serius seperti masalah ekonomi, ketergantungan pada alkohol

atau obat-obatan, atau perilaku agresif dalam rumah tangga, remaja sering kali terpapar pada ketegangan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Ketidakpastian mengenai situasi rumah tangga ini dapat mengganggu rasa aman yang sangat penting bagi remaja dalam proses perkembangan mereka. Remaja mungkin merasa tidak memiliki kontrol atas situasi tersebut, yang dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan akan masa depan. Ketidakstabilan emosional atau fisik dalam keluarga juga meningkatkan risiko remaja untuk mengembangkan gangguan kecemasan atau depresi.

Salah satu dampak terbesar dari masalah keluarga adalah dampaknya terhadap perasaan harga diri dan keterikatan sosial remaja. Ketika seorang remaja tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik atau ketidakstabilan, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain (Bilal, 2024; Krauss & Orth, 2024).

Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan contoh hubungan yang stabil dan penuh kasih sayang dapat mengarah pada ketidakmampuan remaja untuk memahami dan mengelola hubungan interpersonal mereka sendiri. Ini bisa mengarah pada kesulitan emosional, di mana remaja merasa tidak layak dicintai atau tidak bisa mempercayai orang lain. Pada tingkat yang lebih parah, remaja yang menghadapi masalah keluarga yang terus-menerus mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat untuk mencari dukungan, yang memperburuk rasa kesepian dan keterasingan mereka.

Dalam jangka panjang, masalah keluarga yang berkelanjutan dapat menyebabkan remaja lebih rentan terhadap perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan zat, perilaku delinkuen, atau perilaku sosial yang menyimpang. Remaja mungkin mencari pelarian atau cara untuk mengatasi tekanan keluarga dengan cara yang tidak sehat. Ketidakhadiran atau ketidakmampuan orang tua untuk memberikan perhatian emosional yang memadai dapat membuat remaja merasa terabaikan, dan mereka mungkin mencari pengakuan atau kenyamanan melalui hubungan yang tidak sehat atau kegiatan yang merugikan.

G. Pengaruh Teman Sebaya

Pengaruh teman sebaya merupakan faktor eksternal yang sangat kuat dalam kehidupan remaja dan sering kali menjadi salah satu pendorong utama dalam pembentukan perilaku, nilai, dan identitas mereka (Kumudha, 2025; Yulisna et al., 2024). Pada masa remaja, individu berada dalam tahap perkembangan yang sangat sensitif terhadap pengaruh sosial, di mana mereka mulai mencari penerimaan dan pengakuan dari kelompok teman sebaya mereka. Teman sebaya menjadi sangat

penting, karena mereka dapat mempengaruhi cara remaja berpikir, merasa, dan bertindak, baik dalam aspek positif maupun negatif.

Tekanan Teman Sebaya atau yang sering dikenal dengan istilah peer pressure, sering kali mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku yang mereka mungkin tidak lakukan jika tidak ada dorongan dari kelompok mereka. Salah satu bentuk tekanan ini dapat berupa dorongan untuk mengikuti tren atau kebiasaan tertentu yang ada dalam kelompok sosial mereka, seperti merokok, minum alkohol, atau bahkan menggunakan narkoba. Remaja, yang berada pada tahap pencarian identitas, sering kali merasa bahwa untuk diterima dalam kelompok sosial mereka, mereka harus menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan atau diinginkan oleh teman-temannya. Hal ini terutama berlaku di kalangan remaja yang memiliki kecenderungan untuk menghindari konflik atau merasa tidak ingin menjadi "pengecualian" dalam kelompok (Roberts et al., 2025; Wenzel & Woodyatt, 2024).

Selain itu, norma sosial yang berkembang di dalam kelompok teman sebaya sering kali berperan besar dalam membentuk perilaku remaja. Dalam banyak kasus, perilaku yang dianggap "keren" atau "populer" di mata teman-teman sebaya, seperti merokok atau mengonsumsi alkohol, sering kali dianggap sebagai simbol status sosial atau cara untuk menunjukkan kedewasaan. Remaja yang ingin mendapatkan pengakuan atau diterima dalam kelompok ini mungkin merasa terpaksa untuk terlibat dalam perilaku berisiko ini meskipun mereka tahu itu berbahaya bagi kesehatan mereka. Dalam kondisi ini, penurunan kemampuan pengambilan keputusan yang sehat sangat berisiko karena dorongan untuk menghindari pengucilan sosial dapat menggantikan penilaian rasional tentang konsekuensi dari perilaku tersebut.

Tekanan sosial juga bisa bersifat lebih halus, misalnya dalam bentuk perbandingan sosial. Remaja sering kali membandingkan diri mereka dengan teman sebaya untuk menilai keberhasilan atau kesuksesan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu prestasi akademik, penampilan fisik, atau hubungan sosial. Ketika seorang remaja merasa bahwa mereka tidak dapat memenuhi standar atau ekspektasi yang ada dalam kelompok sosial mereka, perasaan rendah diri atau ketidakamanan dapat muncul. Hal ini bisa berujung pada pengambilan keputusan impulsif atau berisiko, seperti mencoba tindakan yang bertentangan dengan nilai pribadi mereka, demi memenuhi harapan atau mendapatkan penerimaan dari teman-teman mereka.

Konformitas kelompok yang tinggi juga dapat memperburuk situasi ini. Remaja cenderung mencari identitas yang stabil selama masa ini, dan kelompok teman sebaya yang memberikan rasa kebersamaan atau identitas bersama sering kali menjadi sumber utama dari kebutuhan emosional ini. Namun, ketika nilai-nilai

atau perilaku kelompok teman sebaya tersebut tidak sejalan dengan norma atau nilai yang sehat, remaja lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku yang tidak sehat atau berisiko. Hal ini bisa melibatkan kegiatan seperti mengonsumsi alkohol, mencoba obat terlarang, atau terlibat dalam perilaku seksual yang tidak aman, yang sering kali dilakukan demi mendapatkan penerimaan atau status dalam kelompok tersebut.

Selain pengaruh yang langsung melalui tekanan untuk berperilaku tertentu, teman sebaya juga dapat mempengaruhi remaja secara tidak langsung melalui perilaku dan kebiasaan yang mereka tunjukkan. Ketika teman-teman remaja mulai mengonsumsi alkohol atau merokok, misalnya, hal ini dapat menciptakan normalisasi perilaku berisiko di dalam kelompok tersebut. Teman sebaya yang terlibat dalam perilaku berisiko dapat menjadi model peran yang secara tidak langsung memberikan contoh kepada remaja lainnya, yang kemudian cenderung meniru perilaku tersebut tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Dengan kata lain, kebiasaan atau gaya hidup teman sebaya dapat dengan cepat menyebar ke seluruh kelompok, meningkatkan peluang terjadinya perilaku berisiko yang lebih luas di antara remaja.

Pada sisi lain, teman sebaya juga memiliki potensi untuk memberikan dukungan positif yang sangat penting bagi kesejahteraan psikologis remaja. Kelompok teman yang mendukung, terbuka, dan saling peduli dapat menjadi pelindung terhadap tekanan negatif yang datang dari kelompok sosial lain. Teman yang memberikan dukungan emosional yang positif dapat membantu remaja mengatasi perasaan cemas, kesepian, atau frustrasi, serta memberikan alternatif yang lebih sehat dalam mengatasi stres atau masalah pribadi. Teman sebaya yang baik juga bisa mengingatkan dan mengarahkan remaja untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari perilaku berisiko (Kumudha, 2025).

Namun demikian, meskipun teman sebaya bisa memberikan dukungan, pengaruh negatif yang datang dari teman-teman yang tidak sehat dapat berdampak serius pada kesejahteraan psikologis remaja. Ketika lingkungan sosial remaja dipenuhi dengan norma-norma yang merugikan atau membahayakan, mereka lebih rentan untuk terjebak dalam siklus perilaku berisiko yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, penting untuk mendidik remaja tentang pengambilan keputusan yang sehat, kemampuan untuk menyaring pengaruh sosial, serta pentingnya membangun relasi yang positif dan mendukung dengan teman sebaya. Dengan cara ini, meskipun pengaruh teman sebaya dapat memberikan tantangan tersendiri, mereka juga dapat menjadi faktor yang mendukung perkembangan yang sehat dan positif bagi remaja.

H. Bullying atau Perundungan

Bullying atau perundungan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat berdampak sangat besar terhadap kesehatan mental remaja, baik ketika mereka menjadi korban maupun pelaku. Perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang terhadap individu yang dianggap lebih lemah atau berbeda. Pada masa remaja, ketika identitas dan harga diri masih dalam tahap perkembangan, perundungan bisa sangat merusak, baik secara fisik maupun emosional. Perundungan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga dapat melibatkan media sosial, yang membuat dampaknya semakin luas dan mendalam (Hwang, 2025; Lestari & Herliana, 2024; Paramita et al., 2024).

Sebagai korban, remaja yang mengalami perundungan sering kali merasa terisolasi, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman (Peras et al., 2024). Bullying yang dilakukan dengan cara menghina, merendahkan, atau mengejek dapat merusak harga diri remaja, mengarah pada perasaan cemas, depresi, bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Ketika remaja diperlakukan dengan buruk secara terus-menerus oleh teman sebaya mereka, rasa percaya diri mereka bisa terkikis, dan mereka mungkin mulai mempertanyakan nilai diri mereka sendiri. Perundungan juga sering kali membuat remaja merasa terisolasi dan enggan untuk berbicara dengan orang lain, termasuk orang tua atau guru, karena mereka merasa tidak ada yang bisa membantu atau bahwa mereka akan dianggap lemah jika mengungkapkan pengalaman mereka.

Dampak psikologis dari perundungan bisa sangat beragam. Salah satu efek jangka panjang yang sering terlihat pada korban bullying adalah penurunan kualitas hubungan sosial. Remaja yang menjadi korban perundungan mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya mereka, karena mereka merasa tidak layak atau tidak dapat dipercaya. Mereka juga mungkin mengembangkan kecemasan sosial yang parah, merasa cemas atau takut berada dalam situasi sosial tertentu, terutama ketika mereka merasa rentan terhadap evaluasi atau penilaian negatif dari orang lain. Selain itu, beberapa korban bullying bisa berkembang menjadi perasaan tidak berharga yang mendalam, yang dapat mengarah pada masalah psikologis yang lebih serius, seperti depresi berat atau bahkan ide untuk menyakiti diri sendiri (Cheng et al., 2025; Hwang, 2025; Lestari, 2023).

Sebagai pelaku, remaja yang terlibat dalam perundungan terhadap orang lain juga dapat menghadapi konsekuensi psikologis yang merugikan. Meskipun perundungan sering kali dilihat dari sudut pandang korban, pelaku perundungan juga tidak luput dari dampak negative (Peras et al., 2024). Remaja yang terlibat

dalam perilaku perundungan mungkin menunjukkan kurangnya empati terhadap orang lain, serta kecenderungan untuk menggunakan kekuasaan atau kekerasan untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Perundungan sering kali berakar dari ketidakmampuan untuk mengelola perasaan, seperti frustrasi, cemas, atau rendah diri. Beberapa remaja yang menjadi pelaku perundungan mungkin telah mengalami tekanan atau kekerasan di rumah, yang membuat mereka mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang destruktif. Jika tidak ditangani dengan baik, perilaku bullying ini dapat berkembang menjadi pola kekerasan atau agresi yang lebih serius, yang bisa mempengaruhi hubungan interpersonal mereka di masa depan.

Selain itu, pelaku bullying juga dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial yang sehat. Mereka mungkin cenderung mengisolasi diri dari teman-teman yang tidak mendukung perilaku mereka atau merasa sulit untuk membangun hubungan yang berbasis pada rasa saling menghormati. Tanpa adanya pemahaman yang benar mengenai empati dan pengelolaan emosi, remaja pelaku bullying dapat tumbuh menjadi individu yang tidak mampu membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Dalam jangka panjang, ini bisa mengarah pada kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal yang sehat, baik di sekolah, dalam keluarga, maupun di dunia kerja nantinya.

Cyberbullying atau perundungan daring juga menjadi masalah yang semakin besar dalam era digital ini. Melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya, perundungan bisa terjadi dengan cara yang lebih tersembunyi namun sangat merusak. Cyberbullying memungkinkan perundungan terjadi 24 jam sehari, tanpa ada batasan waktu atau ruang. Korban cyberbullying tidak dapat melarikan diri dari pelecehan ini, yang membuatnya semakin sulit untuk menghindari atau mengatasi. Selain itu, karena perundungan ini sering kali terjadi tanpa wajah yang terlihat, para pelaku merasa tidak terikat oleh konsekuensi moral yang biasanya muncul dalam interaksi tatap muka. Perundungan yang dilakukan secara daring juga sering kali bersifat lebih luas, dengan potensi untuk disebarkan ke audiens yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat memperburuk perasaan malu dan kesepian yang dialami oleh korban, bahkan menyebabkan mereka merasa terhina di hadapan banyak orang.

Dampak dari bullying atau perundungan tidak hanya terbatas pada waktu atau konteks tertentu, melainkan bisa memiliki efek jangka panjang yang membekas hingga dewasa. Remaja yang mengalami perundungan dapat membawa luka emosional ini sepanjang hidup mereka, memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan pandangan mereka terhadap diri sendiri. Mereka lebih rentan terhadap gangguan kecemasan, depresi, atau bahkan perasaan tidak layak yang

mungkin muncul kembali pada masa dewasa, terutama jika pengalaman perundungan mereka tidak ditangani dengan baik atau didukung secara psikologis (Lestari, 2023).

I. Pengalaman Traumatis

Pengalaman traumatis merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat berisiko memengaruhi kesehatan mental remaja, terutama ketika kejadian tersebut melibatkan peristiwa yang sangat mengganggu, seperti pelecehan fisik, emosional, atau seksual, serta kehilangan orang yang dekat. Masa remaja adalah periode perkembangan yang sangat sensitif, di mana individu sedang membangun dasar-dasar identitas mereka dan belajar cara mengelola emosi serta hubungan sosial. Ketika remaja mengalami peristiwa traumatis, hal itu tidak hanya mengganggu proses perkembangan tersebut, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi (Lyu, 2025; Sethi et al., 2025).

Pelecehan fisik atau seksual adalah salah satu bentuk pengalaman traumatis yang paling merusak dan sering kali memengaruhi remaja dalam jangka panjang. Ketika seorang remaja menjadi korban pelecehan, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, atau tempat lain, pengalaman tersebut dapat merusak rasa aman dan kepercayaan mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Pelecehan ini sering kali menyebabkan rasa malu, kebingungan, dan perasaan tidak berharga yang mendalam, yang bisa mengarah pada penurunan harga diri dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Dalam banyak kasus, korban pelecehan merasa terperangkap dalam perasaan bersalah, seolah-olah mereka yang menyebabkan peristiwa traumatis tersebut terjadi. Perasaan ini dapat memengaruhi cara mereka melihat diri mereka sendiri, bahkan bertahan lama setelah peristiwa tersebut berakhir (Alves et al., 2024; Paek & Choi, 2025).

Selain itu, kehilangan orang yang dekat juga dapat memicu trauma yang mendalam. Kehilangan orang tua, saudara, atau teman dekat—baik melalui kematian, perceraian, atau perpisahan—dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam pada remaja. Pada masa ini, remaja sedang membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar mereka dan sering kali mengandalkan figur-figur tertentu untuk memberikan dukungan emosional dan rasa aman. Kehilangan orang yang mereka cintai, apalagi dalam cara yang mendalam dan mendadak, dapat mengguncang pondasi emosional mereka dan menimbulkan perasaan cemas atau tidak berdaya. Selain itu, kehilangan orang yang dekat dapat menyebabkan remaja

merasakan kesepian yang mendalam dan ketidakpastian tentang masa depan, yang bisa berujung pada masalah psikologis yang lebih serius, seperti depresi atau gangguan kecemasan (Egan et al., 2024; Soetioso & Fithriyah, 2024).

Peristiwa traumatis, baik itu kekerasan, pelecehan, maupun kehilangan, dapat menyebabkan gangguan stres pascatrauma (PTSD) pada remaja. PTSD adalah kondisi psikologis yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengancam jiwa atau keselamatan mereka. Pada remaja, gejala PTSD bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti kilas balik (flashback), mimpi buruk, kecemasan yang berlebihan, atau bahkan perasaan terisolasi dari dunia sekitarnya. Ketika remaja yang mengalami trauma merasa terancam kembali, baik itu melalui kejadian nyata atau hanya dalam bayangan mereka, tubuh dan pikiran mereka sering kali bereaksi dengan cara yang ekstrem—seperti serangan panik atau perilaku menghindar—yang membuat mereka sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Hal ini sering kali membuat remaja menghindari tempat-tempat atau situasi yang mengingatkan mereka pada trauma, dan dapat menurunkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka.

Trauma emosional yang diakibatkan oleh pengalaman buruk seperti perceraian orang tua, kekerasan rumah tangga, atau bahkan perundungan di sekolah, juga dapat merusak perkembangan emosi dan mental remaja. Perasaan tidak aman, rasa takut berlebihan, atau bahkan kebingungan tentang dunia di sekitar mereka bisa berkembang sebagai akibat dari pengalaman traumatis tersebut. Remaja yang mengalami trauma emosional mungkin menunjukkan perubahan perilaku yang drastis, seperti menjadi lebih tertutup, cemas, atau bahkan agresif. Mereka juga bisa mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, merasa tidak mampu membangun kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar mereka, atau merasa cemas mengenai hubungan mereka di masa depan.

Trauma yang dialami oleh remaja juga dapat memengaruhi perkembangan kognitif dan sosial mereka. Ketika seorang remaja terpapar pada peristiwa yang sangat mengganggu atau menyakitkan, mereka mungkin merasa kesulitan untuk memproses pengalaman tersebut atau berbicara tentang perasaan mereka. Hal ini bisa mengarah pada penurunan kemampuan akademik, karena mereka kesulitan untuk fokus, mengingat, atau memahami materi pelajaran dengan baik. Mereka juga mungkin merasa terisolasi dari teman-teman sebaya mereka, karena mereka merasa tidak bisa berbagi pengalaman mereka atau takut akan dihakimi. Pada akhirnya, ini dapat memperburuk perasaan kesepian atau depresi yang mereka alami.

Pengalaman traumatis tidak selalu berakhir dengan remaja hanya merasakan dampak emosional jangka pendek. Dalam banyak kasus, trauma yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi masalah psikologis kronis yang lebih serius.

Remaja yang tidak mendapatkan dukungan yang tepat untuk mengatasi trauma mereka berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, depresi, perilaku berisiko, atau bahkan penyalahgunaan zat di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan emosional yang cukup dan terapi psikologis yang tepat untuk remaja yang mengalami trauma, guna membantu mereka mengatasi perasaan dan membangun mekanisme koping yang lebih sehat.

Pentingnya pendampingan psikologis bagi remaja yang mengalami trauma sangat besar. Dengan adanya intervensi yang tepat, seperti terapi kognitif perilaku (CBT) atau terapi berbasis dukungan sosial, remaja dapat belajar untuk mengelola dampak dari pengalaman traumatis mereka. Melalui proses ini, mereka tidak hanya belajar untuk memproses trauma mereka, tetapi juga mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan ketahanan emosional dan mental yang lebih kuat di masa depan. Selain itu, penting juga bagi lingkungan keluarga dan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana remaja merasa cukup nyaman untuk berbicara tentang perasaan mereka dan mendapatkan bantuan yang diperlukan tanpa rasa takut akan penolakan atau penghakiman.

J. Penggunaan Zat Terlarang

Penggunaan zat terlarang, seperti narkoba dan alkohol, merupakan faktor eksternal yang dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan individu, di mana sistem saraf dan otak masih dalam tahap pembentukan dan pematangan. Dalam periode ini, remaja lebih rentan terhadap pengaruh eksternal yang dapat mengubah pola pikir, perilaku, dan bahkan kesejahteraan emosional mereka. Salah satu pengaruh eksternal yang paling merusak adalah keterlibatan dalam penggunaan zat terlarang. Tidak hanya dapat memperburuk kondisi fisik remaja, tetapi juga sangat berisiko memperburuk gangguan psikologis yang sudah ada atau bahkan memicu munculnya gangguan mental yang lebih serius (Anona et al., 2024; Suryadi & Novtalya, 2024).

Penyalahgunaan narkoba dan alkohol di kalangan remaja sering kali terjadi sebagai bentuk pelarian dari masalah yang mereka hadapi, seperti stres akademik, konflik keluarga, atau masalah emosional lainnya. Banyak remaja yang terjebak dalam penggunaan zat terlarang karena pengaruh teman sebaya atau karena mereka ingin mencari rasa percaya diri yang mereka anggap hilang. Pada tahap ini, penggunaan narkoba atau alkohol tidak hanya bertujuan untuk "bersenang-senang"

atau mengikuti tren, tetapi juga bisa menjadi cara untuk mengatasi rasa sakit emosional atau ketidakmampuan dalam menghadapi tekanan hidup (Choi et al., 2024; Suryadi & Novtalya, 2024).

Namun, penggunaan zat terlarang ini dapat mengganggu perkembangan otak yang sedang berlangsung pada remaja. Alkohol dan narkoba memengaruhi sistem saraf pusat, mengubah cara otak berfungsi dalam merespons rangsangan emosional dan sosial. Ketika remaja menggunakan zat terlarang, otak mereka lebih sulit untuk mengelola stres, emosi negatif, atau kecemasan, yang akhirnya dapat memperburuk gangguan mental yang mereka alami. Misalnya, penggunaan alkohol atau narkoba sering kali terkait dengan peningkatan gejala gangguan kecemasan dan depresi. Dalam banyak kasus, remaja yang mengandalkan zat terlarang sebagai mekanisme koping cenderung mengalami penurunan fungsi kognitif dan gangguan suasana hati yang lebih parah.

Selain itu, penggunaan narkoba atau alkohol dapat memicu atau memperburuk kondisi psikologis yang lebih serius, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), gangguan bipolar, atau skizofrenia pada remaja yang sudah memiliki riwayat gangguan mental. Bagi remaja yang memiliki kecenderungan genetik terhadap gangguan mental, penggunaan zat terlarang dapat menjadi faktor pemicu yang mempercepat perkembangan gangguan tersebut, bahkan di usia muda. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan menyebabkan masalah jangka panjang yang sulit diatasi tanpa intervensi medis dan psikologis yang tepat.

Penggunaan zat terlarang juga dapat mengganggu perkembangan kemampuan sosial dan emosional remaja. Zat-zat ini sering kali merusak kemampuan remaja untuk berhubungan dengan orang lain, karena mereka cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sementara yang ditawarkan oleh narkoba atau alkohol, ketimbang membangun hubungan sosial yang sehat. Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba atau alkohol mungkin mulai mengisolasi diri dari teman-teman yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, atau bahkan mengembangkan hubungan yang lebih destruktif dengan kelompok teman yang sama-sama terlibat dalam penggunaan zat terlarang. Ini dapat memperburuk perasaan kesepian dan isolasi yang mereka rasakan, serta meningkatkan potensi untuk mengalami gangguan kecemasan sosial atau depresi.

Tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, penggunaan narkoba dan alkohol juga dapat memengaruhi kemampuan akademik dan kognitif remaja. Penggunaan zat terlarang secara teratur mengganggu daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan belajar mereka. Ketika remaja terjebak dalam penyalahgunaan zat, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas sekolah atau

mengikuti pembelajaran di kelas, yang pada gilirannya dapat merusak rasa percaya diri mereka. Penurunan kinerja akademik ini dapat menyebabkan stres akademik yang lebih besar dan meningkatkan kecemasan terkait dengan pencapaian pribadi mereka. Selain itu, dampak jangka panjang dari penggunaan narkoba dan alkohol pada perkembangan otak bisa berakibat pada gangguan pengambilan keputusan, penurunan kemampuan berpikir kritis, dan kerusakan memori.

K. Peran Media Sosial

Di era digital yang terus berkembang pesat, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Meskipun media sosial dapat menawarkan banyak manfaat, seperti kesempatan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan terhubung dengan teman-teman sebaya, pengaruh eksternal dari media sosial juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Tekanan sosial yang ditimbulkan dari media sosial, termasuk bullying digital, standar kecantikan yang tidak realistis, serta perasaan terisolasi akibat kurangnya interaksi sosial yang nyata, dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis di kalangan remaja (Balamurali, 2025; Carias et al., 2024).

Bullying digital atau perundungan online merupakan salah satu bentuk tekanan eksternal yang semakin marak di kalangan remaja yang aktif di media sosial. Dengan kemudahan berkomunikasi dan berbagi informasi secara instan melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, remaja sering kali menjadi sasaran perundungan yang lebih luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bullying digital dapat berupa penghinaan, penyebaran rumor, pelecehan verbal, atau bahkan ancaman fisik yang dilakukan secara anonim. Keberadaan bullying online ini sering kali lebih sulit dihindari karena remaja tidak hanya menghadapi perundungan di lingkungan sekolah atau rumah, tetapi juga di dunia maya yang mereka akses setiap hari. Perasaan tidak aman, rasa malu, dan keputusasaan yang ditimbulkan akibat bullying digital dapat menyebabkan remaja mengalami depresi, gangguan kecemasan, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri (Balamurali, 2025; Carias et al., 2024).

Selain bullying, standar kecantikan yang tidak realistis yang sering kali ditampilkan di media sosial juga dapat berkontribusi besar terhadap masalah kesehatan mental remaja. Platform seperti Instagram dan TikTok memperlihatkan gambaran ideal tentang tubuh dan penampilan, yang sering kali disunting atau diolah sedemikian rupa, menciptakan standar kecantikan yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan orang. Hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidakpuasan diri,

rendah diri, atau bahkan disforia tubuh, di mana remaja merasa bahwa tubuh mereka tidak cukup baik atau sesuai dengan apa yang dipamerkan di media sosial. Remaja yang terpapar pada gambar-gambar yang menonjolkan kecantikan fisik yang sempurna ini sering kali merasa tertekan untuk meniru penampilan tersebut, yang berujung pada perbandingan sosial yang tidak sehat dan dapat memicu gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Perasaan tidak cukup baik atau merasa diri mereka tidak sesuai dengan standar kecantikan ini dapat memengaruhi harga diri remaja dan memperburuk kesejahteraan psikologis mereka.

Selain itu, meskipun media sosial memungkinkan remaja untuk tetap terhubung dengan teman-teman mereka, fenomena perasaan terisolasi dapat meningkat, terutama ketika mereka merasa kesulitan untuk membangun hubungan sosial yang mendalam atau otentik. Media sosial sering kali menyajikan kehidupan yang tampak sempurna dan penuh kebahagiaan, yang dapat memicu perasaan kesepian dan keterasingan pada remaja yang merasa bahwa kehidupan mereka tidak seindah atau semenarik yang terlihat di layar. Kurangnya interaksi sosial nyata atau tatap muka juga dapat mengurangi keterampilan sosial remaja dan kemampuan mereka untuk berempati atau memahami perasaan orang lain secara lebih mendalam. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan perasaan isolasi emosional dan memperburuk kecemasan sosial mereka.

Dampak psikologis jangka panjang dari media sosial tidak dapat dianggap remeh. Remaja yang terpapar secara berlebihan pada media sosial, terutama yang terlibat dalam perundungan digital atau terobsesi dengan standar kecantikan yang tidak realistis, lebih berisiko mengalami gangguan psikologis yang lebih serius, termasuk depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, atau gangguan tidur. Remaja yang merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi yang ditampilkan di media sosial mungkin mengembangkan perasaan ketidakberdayaan dan kekosongan, yang bisa menyebabkan mereka menarik diri dari dunia nyata dan semakin bergantung pada dunia maya untuk mendapatkan pengakuan atau validasi.

Namun, meskipun media sosial memiliki dampak negatif yang signifikan, hal ini bukan berarti bahwa media sosial harus sepenuhnya dihindari. Yang lebih penting adalah bagaimana remaja dapat diberi pengetahuan yang tepat tentang dampak negatif media sosial dan bagaimana mereka bisa mengelola interaksi mereka di platform digital dengan lebih sehat. Edukasi tentang penggunaan media sosial yang bijak, serta pendampingan dari orang tua, guru, dan profesional kesehatan mental, sangat penting untuk membantu remaja menghindari dampak buruk dari media sosial dan membangun rasa percaya diri yang lebih kuat tanpa harus mengorbankan kesejahteraan psikologis mereka.

Pendekatan pencegahan seperti mengajarkan remaja tentang kritik terhadap media dan cara untuk mengenali gambar-gambar yang dimanipulasi secara digital atau standar kecantikan yang tidak realistis dapat membantu mereka memiliki perspektif yang lebih sehat mengenai penampilan fisik. Selain itu, penting juga untuk mendorong remaja untuk membangun hubungan sosial yang otentik di dunia nyata, dan memberi mereka dukungan emosional yang kuat untuk membantu mereka mengatasi tekanan dari media sosial. Melalui pendekatan yang bijaksana dan terbuka, kita dapat membantu remaja untuk menggunakan media sosial dengan cara yang lebih positif dan tidak merusak kesehatan mental mereka.

L. Penutup

Faktor risiko psikologis pada remaja, baik yang bersifat internal maupun eksternal, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosional dan mental mereka. Masa remaja adalah periode transisi yang penuh tantangan, di mana berbagai faktor termasuk perubahan hormonal, pencarian identitas diri, tekanan sosial, dan pengaruh media sosial dapat berperan besar dalam membentuk kondisi psikologis seorang individu. Proses pencarian jati diri yang dialami remaja, ditambah dengan tantangan untuk memenuhi harapan eksternal seperti prestasi akademik dan tekanan dari teman sebaya, menciptakan ketegangan emosional yang dapat mengarah pada gangguan mental jika tidak dikelola dengan baik. Dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut, peran keluarga, lingkungan sosial, serta dukungan yang tepat dari para profesional menjadi kunci penting untuk membantu remaja mengelola tantangan yang mereka hadapi. Sebuah pendekatan yang bersifat preventif, di mana kita mengedukasi remaja tentang cara-cara yang sehat untuk mengatasi stres dan masalah emosional, sangat diperlukan agar mereka dapat berkembang dengan lebih seimbang dan stabil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan mental remaja, memberikan edukasi yang mendalam tentang dampak faktor-faktor eksternal dan internal, serta menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Dengan pendekatan yang holistik dan perhatian yang lebih, kita dapat meminimalkan dampak negatif dari faktor risiko psikologis ini dan mendukung remaja untuk meraih potensi terbaik mereka, sehingga mereka dapat menjalani masa transisi menuju kedewasaan dengan percaya diri, resilien, dan sehat secara mental. Hanya dengan upaya kolektif dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi remaja untuk mengatasi tantangan tersebut dan berkembang menjadi individu yang sejahtera secara psikologis.

Referensi

- Alves, A. C., Leitão, M., Sani, A., & Moreira, D. (2024). Impact of Sexual Abuse on Post-Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents: A Systematic Review. *The Social Science*. <https://doi.org/10.3390/socsci13040189>
- Angelina, A., Shausan, A., & Wijaya, E. (2024). The Role of Loneliness on Subjective Well-Being in Adolescents. *Edunity*, 3(12), 1269–1275. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i12.352>
- Anona, K., Onigu-Otite, E., Conner, C., & Saxena, K. (2024). Trauma, Resilience, and Substance Use in Adolescents: A Review Article. *Adolescent Psychiatry*, 15. <https://doi.org/10.2174/0122106766318176241024065029>
- Arcidiacono, D. M., Machia, L. V., Lefferts, W. K., Wolf, D. A., & Heffernan, K. S. (2023). Social isolation and subclinical vascular pathways to cerebrovascular disease. *Biodemography and Social Biology*, 68, 14–31. <https://doi.org/10.1080/19485565.2023.2182274>
- Avci, H., Baams, L., & Kretschmer, T. (2024). A Systematic Review of Social Media Use and Adolescent Identity Development. *Adolescent Research Review*. <https://doi.org/10.1007/s40894-024-00251-1>
- Balamurali, R. (2025). The Role of Social Media in Shaping Adolescent Mental Well-being: A Comprehensive Review on Its Pros and Cons. *Adolescent Psychiatry*, 15. <https://doi.org/10.2174/0122106766339175241202105325>
- Bilal, S. (2024). *Family Relationships and Self-Esteem in Adolescents*. 5(1), 71–79. <https://doi.org/10.69648/oysl7174>
- Borecka-Biernat, D. (2024). Parental influence on Coping Strategies in Youth in Situations of Interpersonal Conflict. *Family Forum*, 14, 409–433. <https://doi.org/10.25167/ff/5238>
- Buunk, A. P. (2024). *Individual Differences in Social Comparison in Organizations* (pp. 107–121). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192897114.013.17>
- Carias, P. M., Nascimento, E. J. M., Cabral dos Santos Lugão, M. A., Morozini, J. P. R., Bicalho, R. L., Lima, C. L. S., Braga, P., Rodrigues dos Santos, E. A., Dutra, A. C. A., Lima, J. B. M. P., Pignaton, M. C., Varejão, A. S. de S., Giurizatto, C. V., Moraes, I. A., & Gomes, M. C. de O. (2024). Impact of the use of social networks on the development of anxiety and depression disorders in young adults. *Health and Society*, 4(06), 157–165. <https://doi.org/10.51249/hs.v4i06.2343>

- Cheng, Q., Mills-Webb, K., Marquez, J., & Humphrey, N. (2025). Longitudinal Relationships Across Bullying Victimization, Friendship and Social Support, and Internalizing Symptoms in Early-to-Middle Adolescence: A Developmental Cascades Investigation. *Journal of Youth and Adolescence*. <https://doi.org/10.1007/s10964-024-02131-2>
- Choi, M., Aliev, F., Barr, P. B., Cooke, M., Kuo, S. I., Salvatore, J. E., Dick, D. M., & Brislin, S. J. (2024). *Genetic, neural, psychological, and environmental factors are uniquely associated with onset of alcohol use in the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) study*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/wrks9>
- Del Ciampo, L. A., & Del Ciampo, I. R. L. (2024). The Changing Body: Importance of Adequate Adolescent Development. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. <https://doi.org/10.9734/jammr/2024/v36i55441>
- Egan, S. J., Pauley-Gadd, S. B., Callgahan, T., O'Brien, A., Greene, D., Bills, E., Raghav, S., Payne, N. C., Myers, B., Hall, C., Wilson, H., Eisma, M. C., Boelen, P. A., Smith, K. S., Wild, J., Duffy, M., Trickey, D., & Breen, L. J. (2024). *Co-designed unguided internet cognitive behaviour therapy for grief in adolescence: A pilot randomised controlled trial*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/r3abf>
- Hilliard, D. D., Wootton, R. E., Sallis, H., van de Weijer, M. P., Treur, J. L., Qualter, P., Dixon, P., Sanderson, E., Carslake, D., Richmond, R. C., Beloe, P., Turner-Harris, L., Byatt, L. B., Munafò, M. R., & Reed, Z. E. (2024). *Investigating causal relationships between loneliness, social isolation and health*. <https://doi.org/10.1101/2024.11.26.24317985>
- Horan, T. J. (2024). The effects of urbanization and social media use on individuals' perceived social isolation. *Online Journal of Communication and Media Technologies*. <https://doi.org/10.30935/ojcmr/14171>
- Hwang, J. H. (2025). The effects of childhood trauma on bullying - mental health. *International Journal of Multidisciplinary Research Updates*, 9(1), 001–012. <https://doi.org/10.53430/ijmru.2025.9.1.0018>
- Izzani, T. A., Octaria, S., & Linda, L. (2024). Perkembangan Masa Remaja. *JISPENDIORA : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 259–273. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1578>
- Juli, M. R., & Juli, L. (2020). Body Identity Search: The Suspended Body. *Psychiatria Danubina*, 32, 83–87. <https://hrcak.srce.hr/file/381742>

- Khairina, I. Y. (2024). The Link between Loneliness, Social Isolation, and Cardiovascular Disease. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 13(S1), 110–118. <https://doi.org/10.20473/jps.v13is1.62664>
- King, L. S., Graber, M. G., Colich, N. L., & Gotlib, I. H. (2020). Associations of waking cortisol with DHEA and testosterone across the pubertal transition: Effects of threat-related early life stress. *bioRxiv*, 691279. <https://doi.org/10.1101/691279>
- Krauss, S., & Orth, U. (2024). Family environment and self-esteem development in adolescence: A replication and extension. *Journal of Research in Personality*, 104511. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2024.104511>
- Kumudha, R. (2025). Study on Challenges of Peer Influence Among Adolescents. *Deleted Journal*, 3(01), 13–15. <https://doi.org/10.47392/irjaem.2025.0004>
- Lestari, N. E. (2023). Analysis Of The Incidents Of Bullying And Its Relation To Health-Related Quality Of Life In Indonesian Adolescents. In *Proceedings of the International Conference on Nursing and Health Sciences* (Vol. 4, No. 2, pp. 551-558).
- Lestari, N. E. & Herliana, I. (2023). Determinant Factors of Quality of Life at School in Early Adolescents: A Multivariate Analysis. In *Proceedings of the International Conference on Nursing and Health Sciences* (Vol. 5, No. 1, pp. 193-202).
- Li, Y. (2024). Effects of Hormonal Changes During Puberty on Cognition and Mood. *Transactions on Materials, Biotechnology and Life Sciences*, 7, 868–873. <https://doi.org/10.62051/cwnnrc05>
- Lyu, M. (2025). *The impact of childhood trauma on mental health*. 341–344. <https://doi.org/10.1201/9781003591511-56>
- Matthews, M., & Kelemen, T. K. (2024). To Compare Is Human: A Review of Social Comparison Theory in Organizational Settings. *Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/01492063241266157>
- Monzonís-Carda, I., Adelantado-Renau, M., Beltran-Valls, M. R., & Moliner-Urdiales, D. (2025). Mental Health and Academic Performance in Adolescents: Elucidating the Role of Psychological Well-Being and Psychological Distress. DADOS Study. *Psychology in the Schools*. <https://doi.org/10.1002/pits.23382>
- Paek, S. A., & Choi, W. S. (2025). A Study on The Relationship between Childhood and Adolescent Maltreatment Experiences and Depression and Anxiety, Aggression, and Self-Esteem. *Korean Association For Learner-Centered Curriculum And Instruction*, 25(1), 917–930. <https://doi.org/10.22251/jlcci.2025.25.1.917>

- Paleczna, M. (2024). Adolescent identity styles and avatar perception: examining the link between identity formation and virtual representation. *Fides et Ratio*, 60(4), 34–49. <https://doi.org/10.34766/fer.v60i4.1311>
- Paramita, S., Palipung, R. Y., & Ni'matuzahroh, N. (2024). The Impact of Bullying on Adolescent : A Systematic Review. *International Journal of Scientific Research and Management*, 12(12), 2092–2100. <https://doi.org/10.18535/ijserm/v12i12.sh01>
- Pascoal, C. E. B., Carraro, B., Meira, G. de F., Castilho, A. V. S. S., Mendes, R. G. F., Trench, L. de A., Castro, M. S., Euzébio, M. J., Foggiano, L. A. R., & Peres, S. H. de C. S. (2024). *Perceived social support among adolescents in public schools in areas of social vulnerability*. <https://doi.org/10.56238/sevened2024.026-056>
- Peras, I., Pivec, T., Kališnik, A., & Košir, K. (2024). Identifying adolescents' victimization experiences: a latent profile analysis approach. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-07152-5>
- Pienyu, K., Margaret, B., & D'Souza, A. (2024). Academic stress, perceived parental pressure, and anxiety related to competitive entrance examinations and the general well-being among adolescents – A cross-sectional survey from Karnataka, India. *Journal of Education and Health Promotion*, 13(1). https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_2094_23
- Roberts, E., Odumodu, C., & Emmanuel, U. (2025). Substance Abuse Behaviour Among Youths: The Predictive Effects of Social Media and Peer Pressure. *Happiness*, 8(2), 113–124. <https://doi.org/10.30762/happiness.v8i2.2614>
- Sethi, S., Quershi, N. A., & Di Lorenzo, G. (2025). Editorial: Developmental trajectories of early life trauma. *Frontiers in Psychiatry*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1548431>
- Shah, E. N., Szwedo, D. E., & Allen, J. P. (2024). Adolescent close friendships, self-perceived social acceptance, and peer-rated likeability as predictors of wellbeing in young adulthood. *Frontiers in Developmental Psychology*, 2. <https://doi.org/10.3389/fdpys.2024.1435727>
- Soetioso, V. B., & Fithriyah, I. (2024). Loneliness in Bereaved Children and Adolescents. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 13(S1), 46–53. <https://doi.org/10.20473/jps.v13is1.62655>
- Suryadi, S., & Novtalya, N. (2024). Dampak Kesehatan Fisik, Mental dan Sosial pada Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan Remaja (Studi kasus di Kabupaten Mamasa). *Mando Care Jurnal*, 3(2), 30–35. <https://doi.org/10.55110/mcj.v3i2.171>

- Tang, J. (2025). The Impact of Parental Conflict on Adolescents' Negative Emotions and Aggressive Behaviors. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 78(1), 62–69. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.19177>
- Thompson, K., Oginni, O., Wertz, J., Danese, A., Okundi, M., Arseneault, L., & Matthews, T. (2024). Social isolation and poor mental health in young people: testing genetic and environmental influences in a longitudinal cohort study. *European Child & Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1007/s00787-024-02573-w>
- Toselli, S., Rinaldo, N., Mauro, M., Grigoletto, A., & Zaccagni, L. (2022). Body Image Perception in Adolescents: The Role of Sports Practice and Sex. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), 15119. <https://doi.org/10.3390/ijerph192215119>
- Wang, J., Wang, Z., Yang, Y., Wang, T., Lin, H., Zhang, W., Chen, X., & Fu, C. (2025). Academic Burden and Emotional Problems Among Adolescents: A Longitudinal Mediation Analysis. *Journal of Adolescence*. <https://doi.org/10.1002/jad.12471>
- Wang, J., Wang, Z., Yang, Y., Wang, T., Lin, H., Zhang, W., Chen, X., & Fu, C. (2024). *Academic burden and emotional problems among adolescents in China: a longitudinal mediation analysis*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4435974/v1>
- Wenzel, M., & Woodyatt, L. (2024). The Power and Pitfalls of Social Norms. *Annual Review of Psychology*. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020124-120310>
- Xu, J. (2024). The Influence of Family Environment on Children's Mental Health. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 45, 123–128. <https://doi.org/10.54097/66dhcw36>
- Yang, X. (2024). *Adolescents' Hormone Level and Circadian Rhythm: A Literature Review*. <https://doi.org/10.61173/84cmcn50>
- Ye, Y., Zhang, Z., Tao, Z., Cui, L., Wang, Y., Chen, H., Li, S., Chen, X., Tang, H., Zhou, J., & Zhou, J. (2025). Academic Pressure and Psychological Imbalance in High School Students: Predictors of Depression via Polynomial Regression and Response Surface Analysis. *Psychology Research and Behavior Management*, 18, 15–23. <https://doi.org/10.2147/prbm.s498606>
- Yulisna, G., Angela, L., & Pranata, O. (2024). Analisis Peer Influence Dalam Pembelajaran dan Korelasinya Dengan Kinerja dan Motivasi. *Biosfer: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi*, 9(2), 126–135. <https://doi.org/10.23969/biosfer.v9i2.19155>

BAB II

PENGARUH POLA ASUH TERHADAP PERKEMBANGAN MENTAL REMAJA

A. Pendahuluan

Remaja yang melakukan tindakan kejahatan atau kriminal cenderung kurang memiliki kontrol diri dan tindakan yang dilakukan umumnya disertai unsur-unsur mental yang bersifat subyektif dimana dalam pencapaian tujuannya disertai kekerasan atau agresi. Pada dasarnya kenakalan remaja terbentuk karena adanya penyimpangan perkembangan mental remaja.

Salah satu aspek terpenting dalam perkembangan mental remaja adalah pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dalam sebuah keluarga. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan tindakan remaja baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tidak tepatnya pola asuh yang diberikan oleh orang tua dapat menimbulkan masalah kesehatan mental remaja yang akan mempengaruhi aktifitas kehidupan remaja tersebut. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi perkembangan jiwa remaja.

Pola asuh orang tua dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Apabila remaja dibesarkan dengan rasa aman, mendapatkan dukungan, dan mendapatkan kasih sayang serta persahabatan, maka remaja akan belajar mempercayai, menyenangkan dirinya sendiri, dan belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Pola asuh yang baik dan sikap positif lingkungan serta penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap keberadaan remaja akan menumbuhkan konsep diri positif remaja dalam menilai diri sendiri.

B. Perkembangan, Sifat, dan Sikap Remaja

Masa remaja merupakan masa dimana individu akan mengalami perkembangan diri, dimana pada masa ini remaja bertransisi dari anak-anak menuju dewasa (Hurlock, 2002; Diananda, 2019).

1. Perkembangan Remaja

Pada masa perkembangan remaja ada beberapa aspek yang menonjol diantaranya adalah:

a. Perkembangan Fisik

Pada masa perkembangan fisik ini, remaja akan merasakan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan disebabkan karena anggota

badan dan otot-otot yang tumbuh belum secara seimbang. Pertumbuhan ini terjadi pada usia 12-13 dan 17-18 tahun. Untuk pertumbuhan otak pada wanita biasanya meningkat 1 tahun lebih cepat daripada pada laki-laki (wanita 10 tahun, pria 11 tahun). Namun pada laki-laki meningkat 2x lebih cepat daripada wanita di usia 15 tahun (Hurlock, 2002).

b. Perubahan Eksternal

Anak perempuan dapat mencapai tinggi yang matang di usia 17-18 tahun, sedangkan laki-laki 1 tahun lebih lambat. Perubahan berat badan biasanya terjadi mengikuti perubahan tinggi badan. Untuk organ seks, kematangan organ seks pada perempuan akan terjadi lebih cepat daripada laki-laki (Hurlock, 2002).

c. Perubahan Internal

1) Sistem Pencernaan

- a) Perut menjadi lebih panjang sehingga tidak menyerupai bentuk pipa
- b) Hati bertambah berat dan kerongkongan bertambah Panjang
- c) Otot-otot di perut dan dinding-dinding usus menjadi lebih tebal dan kuat
- d) Usus bertambah panjang dan besar (Diananda, 2019).

2) Sistem Peredaran Darah

Berat jantung bertambah 12 kali daripada saat lahir. Panjang dan tebal dinding pembuluh darah meningkat dan mencapai kematangan bilamana jantung telah matang (Desmita, 2010).

3) Jaringan Tubuh

Perkembangan kerangka berhenti rata-rata pada usia 18 tahun, sedangkan jaringan selain tulang terus berkembang sampai tulang mencapai ukuran matang (Gunarsa, 2004).

4) Sistem Pernapasan

Kapasitas paru-paru remaja perempuan hampir mencapai tingkat kematangan pada usia 17 tahun, sedangkan pada remaja laki-laki menyusul beberapa tahun kemudian (Hurlock, 2002).

d. Perkembangan Emosi

Pada masa remaja, perkembangan emosi cenderung lebih tinggi daripada masa anak-anak. Hal ini dapat terjadi disebabkan mereka berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi serta situasi yang baru. Kematangan emosi dapat diperlihatkan dengan bagaimana melakukan penilaian masalah

secara kritis terlebih dahulu dibandingkan dengan emosional, bukan sebaliknya.

e. **Perkembangan Kognisi**

Otak yang telah mencapai kematangan pada usia 12 tahun dapat memproses informasi yang berkembang secara cepat dan telah terjadi reorganisasi lingkaran syaraf lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi. Lobe frontal ini akan terus berkembang hingga mencapai usia 20 tahun, dimana perkembangan lobe frontal ini sangat mempengaruhi kemampuan intelektual remaja (Diananda, 2019).

f. **Perkembangan Sosial**

Kemampuan sosial sangat penting pada perkembangan remaja. Kemampuan ini akan membantu remaja dalam memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Pemahaman ini yang akan mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan orang lain, terutama dengan teman sebaya.

2. Sifat dan Sikap Remaja

Pada masa pubertas, remaja akan mulai secara aktif mencari jati dirinya dengan penuh semangat, namun terkadang masih belum memahami hakekat dari sesuatu yang dicarinya. Ahmadi dan Sholeh (1991) mengatakan terdapat tiga tanda yang dapat ditemui pada remaja dalam pencarian jati dirinya, yaitu :

- a. Biasanya remaja akan cenderung bersikap introvert atau tertutup.
- b. Cenderung bersikap menerima norma-norma susila dan agama, serta mulai timbul perasaan "mengagumi dan mengidolakan" seseorang.
- c. Mulai mengenal macam corak kehidupan meski belum dapat membedakan dan menyeleksi secara sempurna.

C. Konsep Keluarga

1. Definisi Keluarga

Keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki sifat abadi, dimana keluarga dapat terbentuk disebabkan dari adanya pernikahan, proses adopsi, ataupun tinggal dan hidup ditempat atau rumah yang sama. Istilah keluarga sendiri dapat didefinisikan dalam banyak arti. Pengertian keluarga tidak terlepas dari cara pandang seseorang mengenai keluarga. Berikut adalah pengertian keluarga menurut beberapa ahli :

- a. Murdock (1949)

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat, terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan dan berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak.

b. Bussard & Ball (1966)

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang mempunyai hubungan sangat erat dengan seseorang.

c. WHO (1969)

Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan.

d. Duval (1972)

Keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan dengan ikatan perkawinan, adopsi atau kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap-tiap anggota keluarganya.

e. Helvie (1981)

Keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat.

f. Goldenberg & Goldenberg (1985)

Keluarga adalah sistem sosial alami yang memiliki serangkaian aturan, peran, bentuk komunikasi yang dapat melakukan usaha untuk mengatur diri sebagai kelompok yang berfungsi, dimana semua anggota berbagi dan berusaha untuk terlibat dalam perilaku kerjasama untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan/ tugas perkembangannya.

g. Depkes RI (1988)

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal.

h. Bailon & Maglaya (1989)

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi, dalam satu rumah tangga dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam perannya masing-masing dan mempertahankan suatu budaya.

i. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

j. BKKBN (1999)

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

k. Friedman (2003)

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan terikat secara emosional.

l. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015)

Keluarga adalah orang seisi rumah yang menjadi tanggungan bagi ibu dan bapak beserta anak-anaknya.

2. Tipe atau Bentuk Keluarga

Tipe-tipe atau bentuk keluarga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Tipe Keluarga Tradisional (Friedman, 2003; Setiadi, 2008)

1) Keluarga Inti (*Nuclear Family*)

Keluarga ini adalah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunannya atau adopsi atau keduanya.

2) Keluarga Besar (*Extended Family*)

Tipe keluarga ini hampir sama dengan keluarga inti, namun yang membedakan adalah adanya tambahan anggota keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sebagainya.

b. Tipe Keluarga Modern (Nybell, Shook, & Finn, 2009; Sahar & Setiadi, 2023)

Perkembangan peran individu dan adanya peningkatan rasa individualism sangat mempengaruhi tipe keluarga, yang akhirnya membentuk tipe keluarga modern, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) *Traditional Nuclear*

2) *Middle Age/ Aging Couple*

3) *Dyadic Nuclear*

4) *Single Parent*

5) *Dual Carrier*

6) *Three Generation*

7) *Communal*

8) *Cohibing Couple/ Cahabitation*

9) *Composite*

3. Fungsi Keluarga

Beberapa ahli mengungkapkan ada beberapa fungsi keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja dalam keluarga, diantaranya adalah :

a. Friedmann (1998)

1) Fungsi Afektif

Fungsi ini adalah fungsi internal keluarga yang berkaitan dengan kasih sayang, dukungan, dan penghargaan anggota keluarga. Fungsi afektif sangat berpengaruh kepada remaja dalam keluarga untuk dapat melakukan hubungan dengan orang lain.

2) Fungsi Sosialisasi

Maksud dari fungsi sosialisasi adalah sebagai tempat mengembangkan dan melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah.

3) Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi adalah salah satu fungsi keluarga yang dijalankan untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Sebagaimana halnya seperti yang disebutkan oleh Friedmann mengenai fungsi reproduksi dalam keluarga yaitu untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.

4) Fungsi Ekonomi

Pada fungsi ini, keluarga memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

5) Fungsi Pemeliharaan Kesehatan

Fungsi ini adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktifitas tinggi.

b. Effendy (1998)

1) Asih

Keluarga sebagai pemberi kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan kebutuhannya.

2) Asuh

Fungsi keluarga disini adalah sebagai pemenuh kebutuhan akan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara,

sehingga mampu menjadi anak-anak yang sehat, baik fisik maupun mental, sosial, dan spiritual.

3) Asah

Adalah sebagai pemenuh kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya.

D. Pola Asuh Orang Tua

1. Definisi Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua anak adalah pola, sikap, perlakuan, gaya, model ataupun cara orang tua dalam menjalin hubungan dengan anak-anaknya dalam upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja. Pola asuh keluarga merupakan serangkaian perilaku yang diterapkan oleh orang tua dalam membimbing dan mendidik anak. Menurut Raharjo dan Ambarini (2021), persepsi anak terhadap pola asuh orang tua dapat memengaruhi status mental mereka, terutama dalam konteks risiko gangguan psikosis. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh tidak hanya berdampak pada perkembangan psikososial anak, tetapi juga pada kesehatan mental mereka secara keseluruhan.

Indirayanti, Maulina dan Tobing (2021) menyebutkan bahwa pola asuh keluarga mengacu pada serangkaian perilaku orang tua yang digunakan untuk membimbing, mendidik, dan memengaruhi perkembangan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pola asuh keluarga mencakup pendekatan, perilaku, dan strategi yang digunakan oleh orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka.

Dalam konteks keperawatan jiwa, pola asuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan psikologis anak. Berdasarkan studi terbaru (*Current Psychology*, 2024), pola asuh tidak dapat dipisahkan dari temperamen orang tua, yang memainkan peran penting dalam menentukan interaksi orang tua-anak serta bagaimana anak memersepsi pola asuh tersebut.

2. Jenis-Jenis Pola Asuh Orang Tua

Berdasarkan teori Baumrind (1991) yang sering dijadikan acuan dalam keperawatan jiwa, pola asuh keluarga dapat dibedakan menjadi empat kategori utama, yaitu:

a. Pola Asuh Otoritatif (*Authoritative*)

Pola asuh ini ditandai dengan kombinasi antara kontrol yang tinggi dan kehangatan emosional yang tinggi. Orang tua yang otoritatif memberikan

batasan yang jelas kepada anak, tetapi tetap responsif terhadap kebutuhan mereka. Pola asuh ini terbukti mendukung kesehatan mental anak, seperti meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan sosial, dan regulasi emosi.

b. Pola Asuh Otoriter (*Authoritarian*)

Pada pola asuh ini, orang tua menunjukkan kontrol yang tinggi tetapi rendah dalam kehangatan emosional. Anak cenderung diarahkan secara ketat tanpa diberi kesempatan untuk berdiskusi atau mengungkapkan pendapat. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa tertekan dan berisiko mengalami gangguan kecemasan atau harga diri rendah.

c. Pola Asuh Permisif (*Permissive*)

Pola asuh permisif ditandai dengan kontrol yang rendah tetapi kehangatan emosional yang tinggi. Orang tua cenderung tidak menetapkan aturan yang tegas, sehingga anak dapat kesulitan dalam mengembangkan disiplin diri. Anak dari pola asuh ini berisiko mengalami masalah perilaku atau kurangnya kontrol emosional.

d. Pola Asuh Tidak Terlibat (*Uninvolved*)

Pola asuh ini menunjukkan rendahnya kontrol dan kehangatan emosional dari orang tua. Anak yang diasuh dengan pola ini sering merasa diabaikan, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, termasuk risiko depresi atau isolasi sosial.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua

Berdasarkan dari *Current Psychology* (2024), berikut adalah faktor-faktor penting yang memengaruhi pola asuh:

a. Temperamen Orang Tua

Sebuah variabel kunci yang memengaruhi bagaimana pola asuh diterapkan. Orang tua yang lebih sabar dan stabil secara emosional lebih cenderung menerapkan pola asuh yang otoritatif.

b. Keseimbangan Peran dalam Keluarga

Ketidakseimbangan tanggung jawab dalam keluarga dapat menciptakan stres tambahan yang mengubah pola asuh.

c. Konteks Budaya dan Sosial

Budaya kolektif atau individualis memengaruhi gaya asuh yang dipilih oleh orang tua.

d. Perkembangan Temperamen Anak

Sebagai hasil dari interaksi pola asuh dan temperamen orang tua, temperamen anak dapat berubah seiring waktu, yang kemudian memengaruhi hubungan orang tua-anak.

Berbeda dengan Raharjo dan Ambarini (2021) yang menekankan bahwa persepsi anak terhadap pola asuh orang tua dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:

- a. Kondisi Psikologis Orang Tua
Orang tua dengan gangguan psikologis cenderung kurang mampu memberikan pola asuh yang optimal, yang dapat memengaruhi persepsi anak terhadap pola asuh tersebut.
- b. Lingkungan Sosial
Dukungan sosial dari komunitas atau keluarga besar dapat memengaruhi cara orang tua mengasuh anak.
- c. Pengalaman Masa Lalu Orang Tua
Pola asuh yang diterapkan sering kali dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil orang tua sendiri.

Indirayanti, Maulina dan Tobing (2021) menuturkan bahwa pola asuh keluarga pada remaja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain:

- a. Budaya dan Tradisi
Nilai-nilai budaya menentukan cara orang tua membimbing anak. Misalnya, dalam budaya kolektif, orang tua lebih cenderung menggunakan pola asuh yang menekankan kepatuhan.
- b. Status Sosial Ekonomi
Keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin lebih tertekan, sehingga memengaruhi cara mereka mengasuh anak.
- c. Pendidikan Orang Tua
Tingkat pendidikan orang tua dapat memengaruhi pengetahuan mereka tentang pentingnya pola asuh yang mendukung kesehatan mental anak.
- d. Kesehatan Mental Orang Tua
Orang tua dengan gangguan kesehatan mental cenderung kurang mampu memberikan pola asuh yang optimal.

E. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua pada Remaja

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang penuh dinamika, seperti yang dijelaskan oleh Gunarsa (2004). Periode ini melibatkan perubahan besar pada aspek fisik, psikologis, dan sosial, yang menuntut peran aktif keluarga, khususnya orang tua. Dalam pandangan Gunarsa, pola asuh menjadi landasan penting dalam membentuk karakter dan kesehatan mental remaja. Pola asuh yang adaptif mampu menjadi panduan bagi remaja dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang kompleks.

Gunarsa (2004) juga menyoroti bahwa hubungan antara remaja dan orang tua sering kali menjadi sumber konflik jika komunikasi tidak berjalan efektif. Sebanding dengan yang disampaikan oleh Indirayanti, Maulina, dan Tobing (2021), pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan pengelolaan stres, stabilitas emosional, dan harga diri.

Raharjo dan Ambarini (2021) menambahkan bahwa persepsi remaja terhadap pola asuh orang tua dapat menjadi faktor penentu risiko gangguan psikosis. Persepsi yang negatif terhadap pola asuh, terutama yang terkait dengan kontrol berlebihan atau kurangnya kehangatan emosional, meningkatkan kemungkinan remaja mengalami stres psikologis yang berkepanjangan.

Studi *Current Psychology* (2024) menyebutkan bahwa keberhasilan pola asuh juga dipengaruhi oleh temperamen orang tua. Temperamen seperti kesabaran, fleksibilitas, atau tingkat stres memengaruhi cara orang tua berinteraksi dengan anak dan bagaimana anak memersepsi pola asuh tersebut. Hubungan harmonis antara pola asuh dan temperamen orang tua menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan mental remaja.

F. Hubungan Pola Asuh dengan Kesehatan Remaja

Studi *Current Psychology* (2024) menekankan pentingnya harmoni antara pola asuh dan temperamen orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Hubungan pola asuh dengan kesehatan remaja dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, seperti:

1. *Pola Asuh Otoritatif* (Authoritative)

Menggabungkan kontrol yang tinggi dengan kehangatan emosional yang tinggi. Orang tua otoritatif, yang memiliki temperamen yang stabil, lebih mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan sosial anak.

2. *Pola Asuh Otoriter* (Authoritarian)

Pola ini dicirikan oleh kontrol yang tinggi dan kehangatan emosional yang rendah. Dalam penelitian terbaru (*Current Psychology*, 2024), pola ini sering

diperburuk oleh temperamen orang tua yang cenderung tegang atau mudah marah, sehingga meningkatkan risiko stres dan ansietas pada anak.

3. *Pola Asuh Permisif (Permissive)*

Pola permisif memberikan kehangatan emosional yang tinggi tetapi kontrol yang rendah. Penelitian menyebutkan bahwa orang tua dengan temperamen sangat fleksibel sering kali jatuh ke dalam kategori permisif karena keinginan untuk selalu memenuhi kebutuhan anak tanpa batas yang jelas.

4. *Pola Asuh Tidak Terlibat (Uninvolved)*

Kurangnya kontrol maupun kehangatan emosional merupakan ciri utama dari pola ini. Temuan *Current Psychology* (2024) menunjukkan bahwa temperamen orang tua yang cenderung apatis atau terlalu sibuk dengan stres pribadi dapat memperburuk dampak negatif pola ini terhadap kesehatan mental anak.

Berdasarkan teori yang relevan dan temuan Raharjo dan Ambarini (2021), pola asuh dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Pola Asuh Otoritatif (Authoritative)*

Pola asuh ini ditandai dengan kombinasi kontrol yang tinggi dan kehangatan emosional yang tinggi. Raharjo dan Ambarini (2021) mencatat bahwa pola asuh otoritatif dapat membantu mencegah risiko gangguan mental pada remaja dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh perhatian.

2. *Pola Asuh Otoriter (Authoritarian)*

Pola asuh ini menunjukkan kontrol yang tinggi tetapi rendah dalam kehangatan emosional. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung memiliki persepsi negatif terhadap orang tua, yang dapat meningkatkan risiko gangguan psikosis, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Raharjo dan Ambarini (2021).

3. *Pola Asuh Permisif (Permissive)*

Pola asuh ini menunjukkan kontrol yang tinggi tetapi rendah dalam kehangatan emosional. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung memiliki persepsi negatif terhadap orang tua, yang dapat meningkatkan risiko gangguan psikosis, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Raharjo dan Ambarini (2021).

4. *Pola Asuh Tidak Terlibat (Uninvolved)*

Pola asuh ini menunjukkan rendahnya kontrol dan kehangatan emosional. Raharjo dan Ambarini (2021) menyoroti bahwa pola asuh tidak terlibat dapat meningkatkan risiko gangguan mental pada remaja, termasuk isolasi sosial dan kecenderungan psikosis.

G. Aspek Perkembangan Remaja yang Dipengaruhi Oleh Pola Asuh Orang Tua

Ada beberapa aspek perkembangan remaja yang dapat terpengaruh oleh pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, yaitu :

1. Perkembangan Emosional:

Pola asuh memengaruhi kemampuan remaja untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Orang tua yang responsif terhadap kebutuhan emosional remaja membantu menciptakan stabilitas emosional.

2. Perkembangan Sosial:

Pola asuh yang sehat membentuk kemampuan remaja untuk membangun hubungan sosial yang positif dengan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, pola asuh yang kurang mendukung dapat menyebabkan isolasi sosial.

3. Perkembangan Kognitif:

Remaja yang didukung dengan pola asuh otoritatif cenderung memiliki kemampuan kognitif yang baik, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

H. Penutup

Pola asuh orang tua sangat memberikan peranan penting dalam perkembangan mental, khususnya pada remaja. Dimana pola asuh dapat memiliki efek positif dan negatif. Pola asuh orang tua yang mendukung dapat meningkatkan Kesehatan mental remaja, seperti meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri. Sebaliknya, pola yang otoriter atau permisif berlebihan dapat memicu masalah seperti ansietas, depresi, atau gangguan perilaku.

Referensi

- Afiatin, T., et. al. (2018).** *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Yogyakarta : PT Kanisius.
- Aprilyani, R., Patodo, M. S., Pranajaya, S. A., et. al. (2023).** *Psikologi Keluarga*. Padang : Get Press Indonesia
- Azzahra, A. A., Shamhah, H., Kowara, N. P., & Santoso, M. B. (2021).** Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Mental Remaja. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 123-134
- Baumrind, D. (1991).** Parenting styles and adolescent development. In J. Brooks-Gunn, R. M. Lerner, & A. C. Petersen (Eds.), *The encyclopedia on adolescence* (pp. 746-758). New York: Garland Publishing
- Baumrind's Parenting Styles.** SpringerLink. This reference work entry provides a comprehensive overview of Baumrind's parenting styles and their impact on child development. First Online: 29 March 2024
- Diananda, A. (2019).** *Psikologi Remaja Dan Permasalahannya*. *Journal ISTIGHNA*, 1(1), 116–133.
- Desmita. (2010).** *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Friedman, M. M. (2003).** *Family Nursing: Research, Theory & Practice* (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Friedman, M. M. (2003).** *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*. Jakarta: EGC
- Gunarsa, S. D. (2004).** *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hurlock, E. B. (2002).** *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga
- Indirayanti, I. G. A. T., Maulina, N., & Tobing, G. Y. (2021).** Pengaruh Pola Asuh Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 236-245.
- Jani, S., & Wahlberg, V. (2020).** The Influence of Family Dynamics on Child Development. *Journal of Family Studies*, 26(3), 345-361.
- Munro, B. H. (2003).** *Statistical Methods for Health Care Research* (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Notoatmodjo, S. (2012).** *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nunzairina, M. A. (2023).** *Psikologi Pendidikan (Pengantar dan Konsep Dasar)*. In

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.

Nybell, L. M., Shook, J. J., & Finn, J. L. (2009). *Child Welfare for the Twenty-first Century: A Handbook of Practices, Policies, and Programs*. Columbia University Press.

Parenting of Adolescents Programming Guidance. UNICEF. Published: 08 November 2021

Parenting Styles and Development. SpringerLink. This article provides a structured overview of existing parenting literature and explores the impact of different parental styles on the development of children and adolescents. First Online: 29 March 2024

Parenting Styles and Their Effect on Child Development and Outcome. Journal of Student Research. Published: 2022

Raharjo, N. I., & Ambarini, T. K. (2021). Hubungan Persepsi Pola Asuh Orang Tua dengan Status Mental Beresiko Gangguan Psikosis pada Remaja. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 4(2), 73-85.

Sahar, J., & Setiadi, R. (2023). Konsep Keluarga dan Fungsi Keluarga dalam Konteks Keperawatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 236-245.

Setiadi, R. (2008). *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Trans Info Media.

Setiadi, R. (2023). Definisi dan Fungsi Keluarga dalam Konteks Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 17(1), 37-48.

The roles of parent temperament and parenting styles in adolescent temperament development. Current Psychology. Published: 24 April 2024

Umami, I. (2019). *Psikologi Remaja*. IDEA Press Yogyakarta.

BAB III

PERAN SEKOLAH DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL

A. Pendahuluan

Usia anak sekolah berada di rentang 5-19 tahun. Usia tersebut terbagi menjadi 6-12 tahun merupakan usia sekolah dasar, sedangkan usia 12-19 tahun merupakan usia sekolah menengah atau usia remaja (Vandell & Gülseven, 2023). Pada rentang usia tersebut anak akan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang secara spesifik. Pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anak usia sekolah akan menjadikan indikator sehat jiwa/mental (Zadeh & Jadvā, 2024). Perkembangan kesehatan mental pada anak usia sekolah menjadi penting karena pada usia tersebut mental emosional anak masih belum labil, sehingga mereka akan rentan terhadap masalah kesehatan mental (Nurjannah et al., 2023). Faktor lingkungan, terutama lingkungan sekolah dengan tingkat sosialisasi dan berkumpulnya orang banyak dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya (Khamida et al., 2020).

Gangguan mental pada anak usia sekolah dapat menjadikan masalah di lingkungan sekolahnya. Gangguan mental tersebut dapat menjadikan anak susah konsentrasi, anak menjadi malas belajar, suasana pembelajaran yang tidak kondusif atau menyenangkan, anak kelelahan atau tertidur karena gangguan pola tidur, dan kasus-kasus perilaku berisiko seperti risiko bunuh diri hingga kasus bullying atau perundungan (Long et al., 2021). Masalah kesehatan mental pada anak usia sekolah perlu mendapatkan perhatian khusus bagi semua aspek. Guru merupakan salah satu orang yang berperan di lingkungan sekolah dalam mencegah masalah-masalah kesehatan mental pada siswanya. Selain itu juga, peran orang tua di rumah juga menjadi penting dalam mencegah masalah kesehatan mental bagi anak-anaknya (Liu et al., 2023).

Sekolah menjadi tempat sosialisasi terbesar bagi anak. Sekolah juga dapat menyebabkan risiko masalah kesehatan mental atau psikososial pada anak-anak. Beberapa alasan sekolah menjadi sangat penting terutama tempat untuk menjaga kesehatan mental pada anak (Yang et al., 2022). Sekolah sebagai tempat hubungan sosial sehingga perlu adanya kontribusi guru kepada siswa dalam menjaga masalah kesehatan mentalnya. Lingkungan fisik sekolah seperti ruang kelas yang nyaman dan bersih, kantin yang sehat, tempat istirahat yang sejuk dan nyaman akan dapat mengkondisikan suasana mental anak saat disekolah. Selain itu juga, kualitas

sumber daya manusia yang baik juga akan memberikan dukungan kesehatan jiwa yang baik juga (Enos, 2020). Guru dan kepala sekolah dapat menjadikan sumber dukungan emosional pada siswanya. Perlunya kompetensi guru dalam memahami dan pemberian dukungan emosional di sekolah menjadi salah satu upaya memfasilitasi siswa dalam perilaku mencari bantuan kesehatan jiwa di sekolah (Jia & Cheng, 2024).

Tantangan yang ada di sekolah tersebut menjadikan kesehatan mental pada anak-anak yang sedang belajar di sekolah harus diprioritaskan. Dampak yang terjadi sangat besar tidak hanya pada masalah mental namun juga dapat berdampak pada masalah fisik. Isu yang berkembang saat ini di lingkungan pendidikan terkait perilaku menyimpang dan berisiko menjadi perlunya intervensi spesifik. Intervensi spesifik pada anak usia sekolah khususnya kesehatan mental harus dikerjakan oleh semua tingkatan (Kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, hingga tenaga kesehatan di sekolah tersebut). Oleh karena itu, perlu adanya peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental di sekolah bagi semuanya. Berikut dalam topik bahasan akan dijelaskan intervensi spesifik dan peran sekolah dalam menciptakan suasana lingkungan sehat mental bagi anak usia sekolah.

B. Masalah Kesehatan Mental Usia Sekolah

Usia sekolah atau remaja merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan generasi yang akan datang dengan sehat dan tangguh. Indonesia saat ini memiliki cita-cita besar dalam menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Visi lengkap Indonesia emas 2045 adalah negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia tersebut perlu adanya kontribusi nyata yang dapat berdampak untuk menuju Indonesia emas 2045 (Maisaroh & Untari, 2024).

Indonesia emas 2045 dapat disiapkan mulai saat ini. Terutama pada kelompok usia anak sekolah 5-19 tahun. Karena mulai saat ini, terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan generasi saat ini dapat berkontribusi nyata dalam menyambut Indonesia emas 2045. Faktor penting salah satunya adalah kesehatan. Tidak dapat dipungkiri masalah kesehatan menjadi prioritas dan agenda tersebut. Salah satu yang sering diabaikan masalah kesehatan adalah kesehatan mental (Khamida et al., 2020). Kesehatan mental menjadi tolak ukur dan modal penting dalam membentuk karakter bangsa. Sehingga dengan pembentukan karakter yang baik dimulai saat ini akan dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia dimasa mendatang.

Organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kesehatan mental memiliki tujuan bagi setiap manusia. Setiap tumbuh kembang manusia pasti memiliki tujuan sehat baik secara fisik dan mental. Namun, semua tahapan tumbuh kembang tersebut pasti memiliki tujuan sehat yang sama yaitu keadaan sejahtera dan sehat mental selama hidup. Seorang siswa yang dapat memiliki perilaku sehat jiwa maka dia dapat mengatasi tekanan hidup baik di rumah atau di sekolah, siswa akan dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya, belajar dengan baik, bersosialisasi dengan baik, hingga mampu berkontribusi di lingkungan sekitarnya (Eyuboglu et al., 2021).

Permasalahan kesehatan mental pada anak usia sekolah harus diperhatikan dengan baik. Masalah yang sering terjadi pada anak usia sekolah terkait kesehatan mentalnya adalah masalah psikososial. WHO menyebutkan bahwa 1 dari 7 anak usia 10-19 tahun akan mengalami masalah kesehatan mental. Bentuk masalah psikososial pada anak usia sekolah seperti gangguan psikologis anak sulit untuk beradaptasi (Ong et al., 2021). Pada kasus tersebut anak akan memiliki perilaku diam di suatu tempat. Kondisi tersebut menjadikan anak pendiam, namun jika berada di rumah atau luar lingkungan sekolah mereka akan aktif secara verbal. Gangguan tersebut adalah *selective mutism* (Ragusa et al., 2024).

Gangguan kesehatan mental lainnya adalah gangguan makan yang sering dijumpai pada anak-anak usia sekolah. Gangguan makan pada anak memiliki beberapa jenis mulai dari anoreksia, bulimia, hingga perilaku gangguan makan anak akan menjauhi makanan. Gangguan makan tersebut dapat menjadikan masalah kesehatan mental pada anak. Selain gangguan makan, anak juga akan mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur ini juga dapat berdampak kepada kondisi anak seperti gangguan perilaku, perkembangan, gangguan sosial, hingga gangguan dengan masalah belajar. Jenis-jenis gangguan tidur seperti *Obstructive sleep apnea*, *sleepwalking*, dan sindrom kaki gelisah yang sering terjadi pada usia anak sekolah (Toigo et al., 2024).

Gangguan lainnya adalah kecemasan pada anak usia sekolah. Gangguan ini akan nampak terlihat pada anak usia sekolah seperti anak akan sering mengamuk, anak akan sering tantrum, hingga anak sering melamun sendiri. Gangguan kecemasan ini dapat bersumber dari ketakutan atau kekhawatiran terhadap objek yang tidak jelas. Seperti takut kepada orang tertentu, takut dalam menghadapi ujian kenaikan, hingga benda-benda tertentu. Selain gangguan kecemasan, usia sekolah juga dapat mengalami depresi. Gangguan mental ini timbul dengan perasaan sedih dan kehilangan minat secara terus menerus, hal tersebut menjadikan gangguan pada anak seperti gangguan tidur, gangguan belajar, hingga sosialisasi dengan teman sebayanya atau orang lain (Wei et al., 2023).

Masalah psikososial lainnya adalah risiko bunuh diri. Risiko bunuh diri pada anak saat ini menjadi isu dan tren dikalangan kesehatan mental remaja. Risiko bunuh diri diakibatkan oleh masalah-masalah dilingkungan sekitar. Contoh korban perundungan, korban kekerasan di lingkungan pendidikan, korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak, hingga tekanan belajar. Dampak dari masalah tersebut juga bisa menyebabkan Skizofrenia (Schonfeld et al., 2023). Kasus Skizofrenia pada anak akan muncul dengan sebutan psikosis awal. Psikosis awal ini muncul pada usia 13-18 tahun hingga sampai 40 tahun. Pada kasus ini akan muncul gejala seperti halusinasi, delusi, gangguan sosial, hingga gangguan tidur dan mencederai diri. Psikosis awal atau Skizofrenia muncul kelainan seperti bicaranya kacau, wajah ekspresi datar, mudah emosi, menarik diri dilingkungan sekolah dan keluarga. Kasus berat psikosis ini dimasyarakat juga berdampak pada kasus pemasungan (Veni. et al., 2023).

Juvenile Delinquency (JD) juga masalah kesehatan mental pada anak. Kasus-kasus tersebut sering juga dinamakan kenakalan remaja yang cukup parah. Contoh kasus anak melanggar norma seperti mencuri, sering berbohong, merusak atau tawuran yang dilakukan secara terus menerus. Pada kasus tersebut dapat merusak seluruh lingkungan sosialnya dan berdampak kepada masalah psikologisnya. Selain JD masalah pada anak usia sekolah adalah *Conduct Disorder* (CD). Gangguan ini termasuk dalam gangguan perilaku. Perbedaannya dengan JD adalah anak dengan CD berfokus kepada perilaku anak yang sering melanggar hak-hak orang lain dan norma-norma sosial yang ada. Sehingga perlu adanya kewaspadaan bagi guru dan orang tua (Abhishek & Balamurugan, 2024).

Gangguan mental lainnya pada anak usia sekolah adalah psikopat. Psikopat menjadi suatu gangguan mental pada anak karena tidak memiliki perasaan, tidak peduli, dan suka berbohong atau menipu orang. Gejala anak dengan psikopat ini harus dideteksi sedini mungkin. Gejala yang muncul pada gangguan tersebut seperti anak kurang empati, anak tidak memiliki belas kasihan, anak mudah marah, hingga anak tidak menunjukkan perilaku dan emosional penyesalan (Ribeiro et al., 2020). Selain gangguan mental tersebut terdapat gangguan retardasi mental pada anak. Gangguan retardasi mental disebut juga dengan gangguan intelektual anak. Anak biasanya memiliki kecerdasan di bawah rata-rata sehingga menyebabkan terganggunya perkembangan otak. Gejala yang timbul seperti anak kesulitan berbicara, kesulitan mengingat, keterlambatan berbicara, hingga lambat menguasai hal-hal tertentu (Mediani et al., 2022).

Gangguan mental selanjutnya adalah gangguan identitas disosiatif atau kepribadian ganda pada anak. Kondisi tersebut muncul karena perasaan tidak nyaman pada anak. Perasaan tersebut menjadikan perasaan tidak nyata, mudah

gelisah seolah-olah anak berada di luar tubuhnya dan kehilangan ingatannya ketika kepribadian lainnya yang muncul. Penyebabnya biasanya karena pengalaman tidak menyenangkan seperti kecelakaan, bencana alam, situasi yang tidak mengenakan dan mencekam, korban tindakan kriminal, hingga korban pelecehan seksual, fisik, maupun mental yang dapat menyebabkan stres dan trauma. Tanda gejala yang muncul seperti kehilangan, merasa sulit bergaul, mencederai diri, hingga cemas dan depresi (Lee et al., 2022).

Permasalahan yang muncul terkait kesehatan mental pada anak usia sekolah tersebut dapat dicegah melalui upaya pendekatan peran sekolah. Tujuan peran sekolah dalam mencegah atau mengatasi masalah kesehatan mental agar siswa mencapai kesejahteraan kesehatan mentalnya (Richter et al., 2022). Upaya mencegah dan menghindari beberapa faktor penyebab maka anak akan dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Selain itu juga, kemampuan SDM yang dimiliki sekolah juga dapat mempengaruhi keberhasilan sekolah dalam berproses menjadi sekolah sehat jiwa.

C. Peran Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Primer

Sekolah sebagai satuan pendidikan harus mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Salah satu bentuk indikator dari pelayanan pendidikan berkualitas adalah keikutsertaan dalam upaya peningkatan kesehatan bagi siswa-siswinya. Jika suasana pendidikan yang aman dan nyaman, maka perlu adanya model dalam pencegahan kesehatan. Kesehatan mental di sekolah menjadi program yang berkembang saat ini. Isu dan trend tentang sekolah sehat jiwa menjadikan pentingnya dalam sekolah terbentuk lingkungan yang aman dan nyaman saat pembelajaran (Alfianto & Ferdianto, 2018).

Peran sekolah salah satunya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang ada di sekolah melalui upaya pencegahan primer. Upaya pencegahan primer memiliki definisi terkait upaya pencegahan sebelum terjadinya sakit baik pada individu, keluarga, ataupun komunitas. Pencegahan primer sebagai upaya menjaga kesehatan baik secara fisik dan mental melalui identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit, aktivitas seperti promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan di individu, keluarga, ataupun komunitas. Konsep pencegahan primer ini berfokus kepada peningkatan kesehatan dan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit seperti di sekolah dapat melakukan tindakan simulasi pendidikan kesehatan, penyuluhan gizi, pencegahan kecelakaan di lingkungan sekolah, pencegahan gigi berlubang, dan lain sebagainya (Tulangow, 2019).

Sekolah sangat perlu menerapkan upaya pencegahan primer terutama dalam masalah kesehatan mental saat ini. Strategi yang dapat dilakukan sekolah dalam mengembangkan dan mencegah masalah kesehatan mental di sekolah antara lain dengan pendekatan pendidikan kesehatan dan pemberdayaan kesehatan. Contoh-contoh dalam upaya pencegahan primer kesehatan mental di sekolah adalah dengan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan saat ini dapat dikembangkan melalui berbagai media. Contoh aplikasi pendidikan kesehatan melalui psikoedukasi. Psikoedukasi merupakan bentuk pendidikan kesehatan melalui pendekatan psikologis. Pendidikan kesehatan ini juga berfokus kepada keterampilan hidup seseorang dalam mencegah masalah kesehatan. Sebagai contoh psikoedukasi pada orang dalam menurunkan stigma gangguan jiwa, kecemasan, depresi, hingga masalah psikososial lainnya di masyarakat (Alfianto et al., 2019).

Pendekatan melalui psikoterapi/psikoedukasi di sekolah juga dapat dilakukan dengan strategi dukungan lingkungan. Strategi ini dapat digunakan sebagai upaya sekolah meningkatkan kenyamanan saat belajar. Kasus perundungan salah satu bentuk masalah yang ada di sekolah. sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah inisiatif dalam mencegah anti perundungan. Model pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan berkolaborasi melalui beberapa ekstrakurikuler di sekolah seperti pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kader Kesehatan Remaja (KKR). Pramuka salah satu bentuk organisasi di sekolah yang bagus dapat dijadikan contoh dalam upaya aktivitas mencegah perundungan di sekolah. melalui pembentukan kader agen perubahan, modul pembelajaran tentang pencegahan perundungan, hingga pendampingan dengan guru sebagai model perubahan dalam mencegah masalah kesehatan mental di sekolah (Ngoranubun et al., 2024).

Strategi lainnya adalah dengan pendekatan digitalisasi dalam upaya pencegahan primer di sekolah. digitalisasi saat ini sangat digemari oleh generasi anak usia sekolah. anak usia sekolah yang masuk dalam generasi Z dan alfa menjadikan mereka terbiasa dengan teknologi (Alfianto & Jayanti, 2020). Saat ini, banyak pengembangan teknologi dalam mencegah masalah kesehatan jiwa. Bentuk pencegahan primer melalui teknologi saat ini dapat berupa aplikasi yang dapat digunakan oleh anak dan orang tua dalam mencegah masalah kesehatan mental. Seperti, aplikasi terkait manajemen stres melalui hipnotis sebagai upaya penurunan kecemasan (Nastiti et al., 2021).

Strategi lainnya adalah membangun hubungan sosial antara teman di sekolah. aktivitas tersebut mampu sebagai upaya pencegahan primer di sekolah. organisasi di sekolah seperti pramuka, kegiatan relawan juga dapat sebagai bentuk peningkatan kesehatan mental. Salah satu contoh yang dapat digunakan sebagai bentuk hubungan sosial tim dari relawan sekolah seperti Palang Merah Remaja

(PMR) atau sejenisnya dapat sebagai media untuk mencegah masalah kesehatan mental di komunitas (Choirulloh et al., 2024). Bentuk pelayanan seperti peningkatan keterampilan dalam mengurangi masalah akibat masalah kejiwaan seperti terapi Aktivitas kelompok (Choirulloh et al., 2023).

Kampanye kesehatan tentang pencegahan masalah kesehatan mental melalui media film. Media filem dapat digunakan sebagai kampanye dalam pencegahan kesehatan mental. Salah satu isu kesehatan mental seperti pernikahan muda yang dapat berdampak kepada masalah kesehatan mental dan reproduksi siswa ketika mereka akan melakukan praktik pernikahan muda (Alfianto et al., 2023). Film sebagai kampanye dapat dimodifikasi melalui pendekatan psikoterapi. Pendekatan psikoterapi ini juga memberikan dampak terutama memudahkan siswa-siswi agar dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari dalam mencegah masalah kesehatan mental (Wati et al., 2024).

Selain kampanye melalui filem dengan pendekatan psikoterapi. Inovasi pencegahan kesehatan mental melalui upaya pencegahan primer dapat dilakukan dengan kampanye atau pendidikan kesehatan melalui film animasi. Film animasi sangat cocok dengan sasaran anak usia sekolah namun pada sekolah menengah dasar (Putri et al, 2023). Film animasi menjadikan siswa-siswi akan berimajinasi melalui filem tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwanya. Salah satu contoh film animasi dengan pendekatan teman sebaya dan konsep dukungan sebaya dapat memberikan dampak kepada siswa akan kepedulian teman sebaya dalam mencegah masalah kesehatan mental (Alfianto & Putri, 2023a).

D. Upaya Sekolah dalam Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder di sekolah juga memiliki peranan penting. Peranan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia (SDM) di suatu sekolah. pencegahan sekunder di lingkungan sekolah harus memiliki strategi dan implementasi yang tepat. Karena setiap sekolah memiliki perbedaan dalam menilai kesehatan mental peserta didiknya. Kearifan lokal saat ini menjadikan tantangan dalam pencegahan sekunder di lingkungan sekolah. oleh karena itu, sangat penting seluruh elemen yang ada di lingkungan sekolah peduli terhadap kesehatan mental peserta didiknya dan gurunya (Morgado et al., 2021).

Contoh yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan mental di sekolah melalui pencegahan sekunder adalah melakukan skrining kesehatan jiwa. Skrining kesehatan mental di sekolah melalui beberapa penemuan masalah. deteksi dini kesehatan mental di sekolah dapat melalui kasus-kasus penemuan seperti stres

negatif pada siswa-siswi akibat tekanan pembelajaran atau di lingkungan sekolah, siswa-siswi mengalami kecemasan saat pembelajaran, perilaku berisiko seperti seks bebas hingga penggunaan NAPZA (salah satunya merokok) (Rahmadanty et al., 2022).

Selain deteksi dini dengan masalah kesehatan mental di sekolah, sekolah dapat melakukan deteksi dini melalui tumbuh kembang anak. Beberapa tahapan tumbuh kembang anak usia prasekolah hingga sekolah saat ini digunakan sebagai upaya pencegahan sekunder di sekolah (Ismawati et al., 2023). maraknya kasus-kasus kesehatan fisik yang dapat berdampak pada kesehatan mental menjadikan perlunya intervensi kolaborasi dalam upaya pencegahan sekunder. Kasus seperti tumbuh kembang siswa kurang gizi, kelebihan gizi, hingga stunting menjadi isu yang dapat berdampak kepada masalah kesehatan mental. Upaya seperti tambahan makanan bergizi hingga pengolahan produk unggulan suatu daerah sebagai intervensi gizi spesifik dapat digunakan sebagai upaya sekunder di lingkungan sekolah atau komunitas (Wicaksono & Alfianto, 2020).

Upaya pencegahan sekunder lainnya adalah membiasakan berfikir positif dan perilaku positif di lingkungan sekolah. perilaku positif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan kebiasaan hidup sehat jiwa yang baik. Contoh perilaku positif sehat jiwa adalah siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, tari, pramuka, dan pengembangan lainnya. Selain perilaku positif, siswa juga dituntut agar mampu berfikir positif (Choirullah et al., 2023). Salah satu penyebab dari orang mengalami gangguan jiwa atau masalah kejiwaan adalah adanya pikiran negatif kepada diri dan orang lain, sehingga menyebabkan kekhawatiran yang berlebih pada diri seseorang. Jika, koping tidak baik maka orang tersebut dapat mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan (Yuniarta et al., 2023a).

Upaya lainnya adalah dengan pencegahan sekunder peningkatan kesehatan dan kesejahteraan siswa. Peningkatan kesejahteraan siswa dapat melalui aktivitas seperti praktik membuat daur ulang sampah menjadi bahan atau media yang bermanfaat, pelatihan-pelatihan terkait perawatan diri kesehatan jiwa. Upaya peningkatan kesehatan mental melalui aktivitas positif perawatan diri juga dapat meningkatkan kesejahteraan siswa (Kurniyanti et al., 2023). Contoh pelatihan yang dapat dilakukan adalah dengan membiasakan siswa makan bergizi setiap hari. Dengan makan bergizi dapat menjadikan siswa-siswi akan lebih nyaman belajar di sekolah. siswa-siswi tidak mengantuk dan terdapat energi baru dalam memulai pembelajaran (Rahmawati et al., 2024).

Selain makan bergizi, perawatan kesehatan jiwa juga dapat dilakukan dengan olahraga teratur. Olahraga banyak sekali cara yang bisa dilakukan, seperti jalan kaki, lari, bersepeda, berenang, sepak bola, hingga badminton. Namun, kegiatan di

sekolah dalam perawatan diri yang dapat dilakukan dengan pendekatan yang baik seperti olahraga pencak silat. Olahraga ini hampir diseluruh sekolah di Indonesia memiliki olahraga tersebut. Saat ini juga, olahraga pencak silat menjadi pilihan sebagai bentuk perawatan diri kesehatan jiwa. Antusias dalam olahraga ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, namun juga di luar lingkungan sekolah (Sukmawati et al., 2023).

Dukungan sosial juga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan sekunder yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Salah satu bentuk spesifiknya adalah memberikan dukungan dalam setiap lomba melalui dukungan sosial oleh guru. Dengan adanya dukungan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam mengikuti lomba. Contoh lainnya adalah siswa yang aktif dalam kegiatan karya ilmiah remaja dapat digunakan sebagai bentuk dukungan sosial agar mereka dapat berfikir kritis dan percaya diri. Selain itu juga dengan adanya program karya ilmiah remaja di sekolah dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi suatu masalah. Sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai upaya pencegahan sekunder di lingkungan sekolah (Alfianto & Putri, 2023b).

Dukungan sosial lainnya adalah dari keluarga. Keluarga menjadi pemberi intervensi spesifik kesehatan mental yang dapat menjadi upaya pencegahan sekunder. Melalui kebiasaan-kebiasan di rumah yang baik dapat menjadikan aktivitas positif di rumah. Terutama orang tua yang mampu memberikan layanan kesehatan mental melalui upaya akses kesehatan mental di komunitas yang baik. Selain itu juga, keluarga juga dapat menjadi contoh dalam mencegah masalah kesehatan mental melalui manajemen stres. Sehingga masalah kesehatan jiwa pada anak-anaknya tidak sampai menjadi gangguan jiwa (Putri, Alfianto, & Ramdhani, 2023).

E. Upaya Sekolah dalam Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier merupakan upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi resistensi pengobatan atau kasus penggunaan obat-obatan, meningkatkan kesejahteraan siswa-siswi dan fungsi psikososialnya, hingga mencegah kekambuhan pada siswa saat di lingkungan sekolah. upaya tersier kasus kesehatan mental di sekolah akan bekerjasama dengan layanan fasilitas kesehatan primer yaitu puskesmas atau klinik. Rata-rata rujukan dilakukan oleh pihak puskesmas melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). UKS ini merupakan bentuk pelayanan kesehatan di sekolah secara holistik. Program-program UKS salah satunya adalah pengobatan (Hidayat & Argantos, 2020).

UKS sebagai layanan kesehatan juga dapat diintegrasikan menjadi layanan sekolah dalam pencegahan tersier. Salah satu yang dapat dilakukan di sekolah melalui inovasi kesehatan mental dalam mencegah masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah Jiwa (UKSJ) merupakan bentuk upaya pencegahan tersier. UKSJ memiliki beberapa program seperti tindakan skrining kesehatan mental, memberikan terapi pada kasus-kasus masalah kesehatan mental di sekolah, hingga sistem rujukan ke fasilitas kesehatan (Alfianto & Safitri, 2019).

Selain itu juga, terdapat beberapa intervensi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mencegah tersier terutama masalah kesehatan mental. Contoh tindakan mengelola emosi yang dapat dilakukan oleh siswa-siswi. Mengelola emosi dapat dilakukan dengan tindakan nafas dalam. Nafas dalam adalah tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh individu atau siswa di waktu kapanpun. Teknik nafas dalam dilakukan dengan suasana rileks seperti duduk dan mendengarkan musik instrumental. Kemudian melakukan tarik nafas melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut dengan perlahan. Tindakan tersebut dapat dilakukan sebelum tidur, agar kualitas tidur menjadi lebih baik (Behuku et al., 2023).

Mengelola emosi yang lain dapat dilakukan oleh individu atau siswa adalah dengan menggambar perasaan. Menggambar perasaan emosi ini merupakan aktivitas positif dalam mengekspresikan perasaannya. Menggambar memberikan kebebasan bagi individu atau siswa dan tidak ketergantungan dalam tata bahasa atau keterbatasan bahasa. Beda dengan menuliskan dalam bentuk aktivitas sehari-hari individu dalam mengungkapkan perasaannya. Jika dengan emosi dilakukan dengan tulisan maka mereka akan terbatas dalam kata-kata atau tidak semua orang dapat menuliskan dengan baik terkait perasaannya/emosinya. Siswa atau individu dalam merespon suatu masalah dengan menggambar akan lebih ekspresif dan mudah (Yuniarta et al., 2023b).

Tindakan lainnya adalah upaya mencari bantuan kesehatan mental. Bantuan kesehatan mental ini sangat penting dilakukan. Perilaku mencari bantuan kesehatan mental pada siswa-siswi dapat mengurangi beban perasaan yang dialaminya. Bentuk tindakan mencari bantuan kesehatan mental dapat berupa formal dan informal. Salah satu bentuk formal dengan pergi ke pelayanan kesehatan profesional seperti psikiater, perawat, psikolog, atau konselor. Sedangkan untuk tindakan mencari bantuan kesehatan secara nonformal dapat melalui teman sebaya atau keluarga (Alfianto & Putri, 2023c).

Fenomena mencari bantuan kesehatan profesional saat ini masih menjadi hal yang negatif. Sebagian besar siswa-siswi masih belum mampu untuk mencari bantuan kesehatan mental baik secara formal dan informal. Stigma di masyarakat tentang gangguan jiwa masih tinggi, hal tersebut menjadikan kekhawatiran

seseorang dalam mencari perilaku bantuan kesehatan mental. Sebagai contoh seorang siswa mengalami masalah kesehatan mental atau psikososial akibat perundungan maka siswa tersebut akan merasa takut untuk bercerita kepada temannya. Akhirnya fenomena kesehatan jiwa pada generasi Z atau alfa saat ini tinggi. Kasus seperti bunuh diri, kecemasan, depresi, hingga kasus *self diagnosis* sering dijumpai (Kartika et al., 2020a).

Oleh karena itu, perlu adanya integrasi layanan dukungan kesehatan mental baik di sekolah dan di keluarga. Dukungan tersebut merupakan bentuk upaya pencegahan tersier. Seluruh komponen dapat bersatu agar masalah kesehatan mental pada anak usia sekolah dapat dicegah dengan baik. Seorang ibu dan ayah yang peduli dengan menanyakan aktivitas sehari-hari di sekolah dapat digunakan atau kebiasaan keluarga dalam memberikan dukungan kesehatan mental pada anaknya. Pemberian penghargaan kepada anak-anaknya yang mampu berperilaku positif dengan baik dapat menjadikan motivasi anak untuk meningkatkan perilaku baik atau positif setiap hari. Dukungan sekolah dengan membiasakan siswa-siswi untuk berperilaku positif setiap hari, seperti mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang disenangi oleh siswa, mengajak kearah kebaikan seperti aktivitas ibadah di sekolah, guru memberikan contoh baik kepada siswa-siswinya dalam perilaku baik atau perilaku hidup bersih dan sehatn (PHBS) (Dodok et al., 2022).

Pelayanan sekolah lainnya adalah dapat berupa manajemen krisis dan intervensi. Manajemen krisis yang dapat dilakukan adalah dengan pelatihan kepada guru dan siswa. Seperti pelatihan pertolongan pertama psikologis. Pelatihan pertolongan pertama psikologis merupakan intervensi awal yang dapat dilakukan guru dalam menangani masalah psikososial di sekolah. Penanganan awal ini sangat mudah sekali dan digunakan oleh orang awam (Kartika et al., 2020b). Tindak ini tidak sama dengan tindakan konseling. Melainkan tindakan awal untuk melihat kondisi awal siswa dengan masalah psikososial, Kemudian tindakan berikutnya adalah dengan mendengarkan masalah yang dialami oleh siswa dengan masalah psikososial, dan yang terakhir adalah melalui tindakan menghubungkan atau merujuk ke pelayanan kesehatan terhadap siswa dengan masalah psikososial tersebut (Alfianto et al., 2023).

F. Upaya Sekolah dalam Kesehatan Mental Pada Situasi Khusus

Upaya kesehatan mental lainnya di lingkungan sekolah adalah masalah kebencanaan. Saat ini di beberapa sekolah pendidikan sudah membuat aturan terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). SPAB ini juga diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 33 tahun 2019 tentang

penyelenggaraan program SPAB. SPAB ini memiliki tiga pilar dalam program tersebut. Pilar pertama berfokus kepada fasilitas belajar yang lebih aman, pilar kedua adalah manajemen penanggulangan bencana dan kesinambungan pendidikan, pilar ketiga adalah pendidikan pengurangan risiko bencana dan resiliensi. Ketiga pilar tersebut sangat erat kaitanya dengan peran sekolah dalam mengupayakan kesehatan mental pada situasi bencana (Qodir et al., 2023).

Salah satu yang disiapkan sekolah dalam masalah kebencanaan adalah meningkatkan secara psikologis siswa-siswi dalam menghadapi bencana. Bentuk kesiapan tersebut dapat dalam kesiapsiagaan psikologis siswa dalam menghadapi bencana di sekolah. Kesiapsiagaan psikologis siswa di sekolah meliputi kesadaran siswa dalam pencegahan bencana, pengetahuan siswa terkait bencana dan risiko di lingkungan sekolah, antisipasi siswa dalam mencegah terjadinya bencana, mengelola stres sebelum dan saat terjadinya bencana, hingga kemampuan mengambil keputusan yang tepat terhadap risiko dan ancaman bencana (Jamali et al., 2022).

Pilar dan indikator kesiapsiagaan psikologis tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk aktivitas positif dalam mengurangi masalah kesehatan mental akibat bencana. Beberapa tindakan sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier untuk menghadapi masalah kesehatan mental akibat bencana. Salah satu contoh pencegahan primer melalui pendidikan kesehatan tentang kebencanaan. Melalui pendidikan kesehatan seperti media film dapat menjadikan gambaran penanganan kesehatan mental akibat bencana. Film merupakan visualisasi dan dapat dijadikan sebagai pandangan untuk mencegah bencana. Dengan melihat film orang akan berimajinasi tentang gambaran sesungguhnya dalam menghadapi suatu masalah. Sehingga sangat efektif pendekatan melalui film dalam upaya pencegahan primer di sekolah (Wijayanti et al., 2022).

Model lainnya adalah pemberdayaan di sekolah melalui kegiatan tanggap bencana. Program-program tanggap bencana sebagai upaya sekolah dalam mencegah terjadinya korban ketika bencana di lingkungan sekolah. Bentuk pemberdayaan melalui keikutsertaan seluruh elemen sekolah dalam mendukung pencegahan bencana di lingkungan sekolah. Contoh pemberdayaan dalam lingkungan sekolah adalah memberikan pendidikan kebencanaan, pelatihan kepada siswa dan guru tentang tanggap bencana, pelatihan mitigasi dan pertolongan pertama saat situasi bencana di lingkungan sekolah. Hingga sekolah dapat memberikan kebijakan dalam penanggulangan bencana di sekolah (Alfianto et al., 2024).

Upaya tersebut sebagai bentuk layanan dan peran sekolah terutama dalam masalah kesehatan mental pada situasi tertentu yaitu bencana. Pada situasi bencana

tidak bisa lepas dengan masalah psikologis atau mental. Dampak yang dapat dirasakan ketika seseorang tidak siap dalam menghadapi bencana adalah perasaan cemas dan takut. Sebaliknya dampak setelah bencana dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti trauma, gangguan mental, *Post-traumatic stress disorder (PTSD)*. Oleh karena itu, sangat penting peran sekolah dalam menyiapkan kesiapsiagaan psikologis siswa dan guru dalam menghadapi risiko dan ancaman bencana di lingkungan sekolah(Rahmawati et al., 2022).

G. Penutup

Sekolah sebagai tempat untuk bersosialisasi terbesar dan waktu terlama menjadikan perlu adanya bentuk kepedulian dalam pelayanan kesehatan mental. Kesehatan mental dan masalah yang sering dialami oleh siswa-siswi menjadikan suasana pembelajaran tidak nyaman dan tidak kondusif. Hal tersebut, menjadikan dampak berbagai elemen seperti guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Masalah kesehatan mental pada siswa seperti kecemasan, depresi, risiko bunuh diri, perundungan, kekerasan fisik, gangguan mental emosional dan perilaku lainnya, serta psikosis (Skizofrenia) perlu dicegah sedini mungkin pada anak usia sekolah/remaja.

Upaya dan peran sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan mental di sekolah melalui upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Melalui upaya pencegahan masalah kesehatan mental tersebut dapat mengurangi masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah. upaya tersebut secara berkesinambungan harus mendapatkan dukungan dari semua elemen. Guru memberikan dukungan melalui pembelajaran yang kondusif dan aman, kepala sekolah memberikan kebijakan terkait upaya dan peran sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah, orang tua memberikan dukungan dan motivasi positif kepada anaknya selama aktivitas di sekolah, dan siswa harus melakukan kegiatan positif dan baik selama di sekolah.

Selain upaya dan peran tersebut, sekolah juga harus dapat memberikan peran baik terhadap lingkungan sekolah yang sehat mental melalui situasi khusus. Contoh situasi khusus adalah menyiapkan siswa secara psikologis dalam menghadapi risiko dan ancaman bahaya bencana di lingkungan sekolah. kesiapsiagaan psikologis salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyiapkan seluruh elemen sekolah dalam menghadapi situasi sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana.

Melalui upaya kesehatan mental disekolah, sekolah harus mampu memberikan peran yang baik terhadap masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah.

berbagai inovasi dapat digunakan sebagai rujukan untuk menjadikan sekolah sehat mental dan sekolah ramah anak. Melalui program tersebut diharapkan sekolah-sekolah di Indonesia mampu menerapkan perilaku positif, pencegahan masalah kesehatan mental, dan penanganan kesehatan mental dengan baik. Sehingga visi Indonesia emas 2045 akan bisa tercapai, karena disiapkan mulai dari saat ini melalui Peran Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan yang Mendukung Kesehatan mental.

Referensi

- Abhishek, R., & Balamurugan, J. (2024). Impact of social factors responsible for Juvenile delinquency - A literature review. *Journal of Education and Health Promotion*, 13, 102. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_786_23
- Alfianto, A. G., Apriyanto, F., & Diana, M. (2019). Pengaruh psikoedukasi terhadap tingkat pengetahuan tentang stigma gangguan jiwa. *Jl-KES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(2), 37–41. <https://doi.org/10.33006/ji-kes.v2i2.117>
- Alfianto, A. G., & Jayanti, N. D. (2020). Pisang gen alfa: a smartphone application to reduce parenting stress for parents with alpha generations. *Media Keperawatan Indonesia*, 3(3), 121. <https://doi.org/10.26714/mki.3.3.2020.121-128>
- Alfianto, A. G., Kurniyanti, M. A., Ulfa, M., & Sulaksono, A. D. (2023). Pengembangan dan kelayakan film seri psikoedukasi berbasis kesehatan jiwa dan reproduksi dalam mencegah pernikahan muda. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 14(2), 151–161. <https://doi.org/10.58185/jkr.v14i2.111>
- Alfianto, A. G., & Putri, L. T. K. (2023a). The role of the animation film “kanca cilik” in increasing student’s in relation to mental health help-seeking behaviour. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(1), 72–79. <https://doi.org/10.1007/BF01811613>
- Alfianto, A. G., & Putri, L. T. K. (2023b). The role of the animation film “kanca cilik” in increasing student’s in relation to mental health help-seeking behaviour. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(1), 72–79. <https://doi.org/10.1007/BF01811613>
- Alfianto, A. G., & Putri, L. T. K. (2023c). The role of the animation film “kanca cilik” in increasing student’s in relation to mental health help-seeking behaviour. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(1), 72–79. <https://doi.org/10.1007/BF01811613>
- Alfianto, A. G., & Safitri, A. (2019). Efikasi diri siswa dengan tanda gejala psikosis awal dalam mencari bantuan melalui usaha kesehatan sekolah jiwa. *Jl-KES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.33006/ji-kes.v3i1.123>
- Alfianto, A. G., et al. (2023). Pengembangan budaya perawatan diri kesehatan jiwa melalui program ritual sial. *Community Development Journal*, 4(4), 9038–9047. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.20233>
- Alfianto, A. G., Wijayanti, D. P., Sulaksono, A. D., & Choirullah, A. H. (2024). Disaster-safe-school based program for the psychological preparedness of elementary school students. *Nurse and Health: Jurnal Keperawatan*, 13(1), 148–155. <https://doi.org/10.36720/nhjk.v13i1.657>
- Alfianto A. G., & Ferdianto. (2018). Unit Kesehatan Sekolah Sehat Jiwa. *Prosiding Seminar Nasional: Peran dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Kesehatan Nasional*, 44–52.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32528/psn.v0i0.1729>

- Behuku, F. M., Alfianto, A. G., & Amalia, W. (2023). Self care of mental health generation z of melanesia race in Indonesia. *Journal of Rural Community Nursing Practice*, 1(1), 89–101. <https://doi.org/10.58545/jrcnp.v1i1.92>
- Choirullah, A. H., et al. (2023). Volunteer camp: first aid training program and positive behavior of youth students in plantation schools area, malang district. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AgroNurse*, 1(1), 44–53. <https://journal.unej.ac.id/ANK/article/view/322%0Ahttps://journal.unej.ac.id/ANK/article/download/322/178>
- Choirulloh, A. H, Alfianto, A. G., Muntaha, & Ulfah, M. (2024). Test of the Validity and Reliability of Mental Health in Preventing Bullying Through Positive Behavior in Adolescents. *Nursing and Health Sciences Journal (NHSJ)*, 4(1), 103–109. <https://doi.org/10.53713/nhsj.v4i1.341>
- Choirullah, A. H., Hidayantia, V. E. S., Tyasaa, M. Y. S., & Alfianto, A. G., (2023). Implementasi merdeka belajar kampus merdeka melalui pendampingan orang dengan gangguan jiwa dalam terapi aktivitas kelompok membatik oleh mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. *Satwika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 79-89. <https://doi.org/10.21009/satwika.030108>
- Dodok, Y., Alfianto, A. G., Indriyawati, & Wicaksono, K. E. (2022). Behavioral Differences In Seeking Help For Mental Health Among Generation Z From The Kodi People Group And The Madurese Ethnic Group. *Journal of Applied Nursing and Health*, 4(1), 78–85. <https://doi.org/10.55018/janh.v4i1.57>
- Enos, G. (2020). Millennials, Generation Z targeted in new mental health initiative. *Mental Health Weekly*, 30(39), 1–5. <https://doi.org/10.1002/mhw.32536>
- Eyuboglu, M., Eyuboglu, D., Pala, S. C., Oktar, D., Demirtas, Z., Arslantas, D., & Unsal, A. (2021). Traditional school bullying and cyberbullying: prevalence, the effect on mental health problems and self-harm behavior. *Psychiatry Research*, 297, 113730. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113730>
- Ismawati, Y. C, Alfianto, A. G., & Kurniyanti, M. A. (2023). Studi kasus kesiapan peningkatan perkembangan dan kesehatan jiwa anak usai prasekolah. *Jurnal El-Audi*, 4(2), 65–70. <https://doi.org/10.56223/elaudi.v4i2.116>
- Hidayat, K., & Argantos. (2020). Peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai proses prilaku hidup bersih dan sehat peserta didik. *Jurnal Patriot*, 2(2), 627–639. <https://doi.org/10.24036/patriot.v2i2.642>
- Jamali, Alfianto, A. G., & Zunaidi, R. (2022). Intervensi kesiapsiagaan psikologis bencana banjir pada siswa-siswi di lingkungan sekolah. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 6(2), 98–105. <https://doi.org/10.33366/nn.v6i2.2506>
- Jia, M., & Cheng, J. (2024). Effect of teacher social support on students' emotions and learning engagement: a u.s.-Chinese classroom investigation. *Humanities and*

Social Sciences Communications, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02634-0>

- Kartika, C. A., Alfianto, A. G., & Kurniyanti, M. A. (2020a). Pertolongan pertama kesehatan jiwa pada siswa dengan masalah psikososial yang berisiko bunuh diri. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(2), 161–172. <https://doi.org/10.32584/jikj.v3i2>
- Kartika, C. A., Alfianto, A. G., & Kurniyanti, M. A. (2020b). Pertolongan pertama kesehatan jiwa pada siswa dengan masalah psikososial yang berisiko bunuh diri. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(2), 161–172. <https://doi.org/10.32584/jikj.v3i2>
- Khamida, K., Budury, S., Rohmawati, R., Fitriyari, A. F., & Zahroh, C. (2020). A lifestyle management of mental health decreasing the stress level of student. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 826–830. <https://doi.org/10.30994/sjik.v9i2.292>
- Kurniyanti, M. A., Alfianto, A. G., Ulfa, M., & Sulaksono, A. D. (2023). Gempa Perekat : The movement to process garbage becomes an educational game tool for early childhood through self-help groups for family welfare development. *Journal of Community Empowerment for Health (JCOEMPH)*, 6(1), 58–63. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.v6i1.161>
- Lee, S. H., Kang, N. R., & Moon, D. S. (2022). Dissociative identity disorder in an adolescent with nine alternate personality traits: a case study. *Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 33(3), 73–81. <https://doi.org/10.5765/jkacap.220005>
- Liu, Y., Yu, X., An, F., & Wang, Y. (2023). School bullying and self-efficacy in adolescence: A meta-analysis. *Journal of Adolescence*, 95(8), 1541–1552. <https://doi.org/10.1002/jad.12245>
- Long, E., Zucca, C., & Sweeting, H. (2021). School Climate, Peer Relationships, and Adolescent Mental Health: A Social Ecological Perspective. *Youth and Society*, 53(8), 1400–1415. <https://doi.org/10.1177/0044118X20970232>
- Maisaroh, A., & Untari, S. (2024). Transformasi pendidikan karakter melalui kebijakan pemerintah di Indonesia menuju generasi emas 2045. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(1), 18–30. <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4347>
- Mediani, H. S., Hendrawati, S., & Fatimah, S. (2022). Kualitas hidup anak dengan retardasi mental. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 2626–2641. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2086>
- Morgado, T., Loureiro, L., Botelho, M. A. R., Marques, M. I., Martínez-Riera, J. R., & Melo, P. (2021). Adolescents' empowerment for mental health literacy in school: A pilot study on prolismental psychoeducational intervention. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15). <https://doi.org/10.3390/ijerph18158022>
- Nastiti, E. M., Alfianto, A. G., & Ekaprasetya, F. (2021). H5J (Hypnotic 5 Fingers) Mobile Application For Reduce Anxiety Problems Chemotherapy Patient. *Jurnal*

- Kesehatan Dr. Soebandi*, 9(2), 87–91. <https://doi.org/10.36858/jkds.v9i2.327>
- Ngoranubun, S. V., Alfianto, A. G., Rahmadhani, R., & Kurniyanti, M. A. (2024). Development of a scout movement-based mental health literacy module to prevent bullying. *Health and Technology Journal (HTechJ)*, 2(2), 101–109. <https://doi.org/10.53713/htechj.v2i2.167>
- Nurjannah, S., Nauli, F. A., & Karim, D. (2023). Perbandingan karakteristik lingkungan sosial sekolah dan kesehatan mental anak usia sekolah. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 11(1), 150–164. <https://doi.org/10.33650/jkp.v11i1.5544>
- Ong, S. H., Tan, Y. R., Khong, J. Z. N., Elliott, J. M., Sourander, A., & Fung, D. S. S. (2021). Psychosocial Difficulties and Help-Seeking Behaviors in Singapore Adolescents Involved in Cyberbullying. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 24(11), 737–744. <https://doi.org/10.1089/cyber.2020.0630>
- Putri, L. T. K., Alfianto, A. G., & Ramdhani, R. (2023). Film animasi “Kanca Cilik” sebagai intervensi dalam perilaku mencari bantuan kesehatan jiwa pada usia remaja. *Jurnal Kesehatan Medika Udayana*, 09(01), 32–43. <https://doi.org/10.47859/jmu.v9i01.301>
- Qodir, A., Alfianto, A. G., Wulandari, A. T., & Prastyo, D. (2023). Peningkatan pengetahuan kebencanaan siswa sekolah dasar bekerjasama dengan badan penanggulangan bencana daerah jawa timur. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 2051–2057. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3510>
- Ragusa, A., Núñez-Rodríguez, S., Vaz, P., Silva, J., Caliciotti, V., González-Bernal, J. J., López-Rivero, A. J., Petrillo, E., Gatto, M., Obregón-Cuesta, A. I., & González-Santos, J. (2024). Impact of cyberbullying on academic performance and psychosocial well-being of Italian students. *Children (Basel, Switzerland)*, 11(8), 943. <https://doi.org/10.3390/children11080943>
- Rahmadanty, I. P., Alfianto, A. G., & Ulfa, M. (. (2022). Sress, kecemasan dan perilaku merokok merupakan masalah psikososial yang dialami generasi z. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 6(1), 19–26. <https://doi.org/10.33366/nn.v6i1.2443>
- Rahmawati, I., et al. (2022). Peran mahasiswa siaga bencana indonesia dalam upaya penanganan bencana area komunitas melalui zoominar. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(12), 4302–4310. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i12.7882>
- Rahmawati, M., Bete, D., Susanto, H., De deus Araujo, N. A., Alfianto, A. G., & Soelaksono, A. D. (2024). Pengolahan pangan unggulan pisang sebagai produk makanan tambahan pada balita stunting. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 121. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v7i1.1876>
- Ribeiro da Silva, D., Rijo, D., & Salekin, R. T. (2020). Psychopathic traits in children and youth: The state-of-the-art after 30 years of research. *Aggression and Violent Behavior*, 55(March), 101454. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101454>

- Richter, A., Sjunnestrand, M., Strandh, M. R., & Hasson, H. (2022). Implementing school-based mental health services: a scoping review of the literature summarizing the factors that affect implementation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6). <https://doi.org/10.3390/ijerph19063489>
- Schonfeld, A., McNiel, D., Toyoshima, T., & Binder, R. (2023). Cyberbullying and adolescent suicide. *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 51(1), 112–119. <https://doi.org/10.29158/JAAPL.220078-22>
- Sukmawati, I., Alfianto, A. G., & Soelaksono, A. D. (2023). The relationship between socio-cultural and self-care for mental health generation z a cross-sectional study on Mataraman ethnicity, East Java, Indonesia. *Jurnal Keperawatan Malang*, 8(1), 269–282. <https://doi.org/10.36916/jkm.v8i1.203>
- Toigo, S., Katzman, D. K., Vyver, E., McFaull, S. R., Iynkkaran, I., & Thompson, W. (2024). Eating disorder hospitalizations among children and youth in Canada from 2010 to 2022: a population-based surveillance study using administrative data. *Journal of Eating Disorders*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s40337-023-00957-y>
- Tulangow, R. R. (2019). Gambaran pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah (uks) bagi peserta didik kelas XI SMA Negeri 2 Dumoga. *EBiomedik*, 7(2), 143–149. <https://doi.org/10.35790/ebm.7.2.2019.25583>
- Vandell, D. L., & Gülseven, Z. (2023). The study of early child care and youth development (SECCYD): studying development from infancy to adulthood. *Annual Review of Developmental Psychology*, 5(1), 331–354. <https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-120621-035345>
- Veni, H., Alfianto, A. G., Kurniyanti, M., A., & Soebagijono. (2023). Case study: people with severe mental disorders with physical mobility barriers after in pasung. *Journal of Health Research and Technology*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.58439/jhrt.v1i1.44>
- Wati, E., Alfianto, A. G., & Ulfa, M. (2024). Psychoeducational film series based on premature marriage prevention on mental health prevention in adolescent girls. *Journal of Maternity Care and Reproductive Health*, 7(2), 106–117. <https://doi.org/10.36780/jmcrh.v7i2.12272>
- Wei, X., Chu, X., Wang, H., Geng, J., Zeng, P., Ren, L., Liu, C., & Lei, L. (2023). Does positive coping style alleviate anxiety symptoms after appearing problematic smartphone use for generation Z adolescents? The mediating role of state core self-evaluation. *Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*, 43(8), 6783–6795. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04776-x>
- Wicaksono, K. E., & Alfianto, A. G. (2020). Dampak positif pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan keluarga dalam manajemen nutrisi balita stunting. *Conference on Innovation and Application Of Science and Technology*, 981–986.
- Wijayanti, D. P., Alfianto, A. G., Rahmawati, I., & Yusniawati, Y. N. P. (2022). Fire management: A virtual treatment towards psychological preparedness among

- health college volunteers in Indonesia. *The Journal of Palembang Nursing Studies*, 2(1), 12-19. <https://doi.org/10.55048/jpns.v2i1.54>
- Yang, W., Liang, X., & Sit, C. H.-P. (2022). Physical activity and mental health in children and adolescents with intellectual disabilities: a meta-analysis using the RE-AIM framework. *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 19(1), 80. <https://doi.org/10.1186/s12966-022-01312-1>
- Yuniarta, D. V., Alfianto, A. G., & Kusbandiyah, J. (2023a). Self-care of mental health generation z ethnic Arek East Java. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.58545/jkki.v3i1.87>
- Yuniarta, D. V., Alfianto, A. G., & Kusbandiyah, J. (2023b). Self-care of mental health generation z Ethnic Arek East Java . *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 3(1 SE-Articles), 1–13. <https://doi.org/10.58545/jkki.v3i1.87>
- Zadeh, S., & Jadv, V. (2024). Child development and family relationships in families following ART. *Early Child Development and Care*, 194(15–16), 1453–1467. <https://doi.org/10.1080/03004430.2024.2419466>

Glosarium

B

Bullying: adalah memiliki arti perundungan/tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, atau merugikan orang lain.

C

Cemas: adalah perasaan takut atau khawatir yang muncul ketika menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut.

Conduct Disorder (CD): adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan perilaku agresif, kasar, dan melanggar hukum. Gangguan ini dapat terjadi pada anak-anak dan remaja.

D

Dukungan sosial: adalah bantuan, perhatian, atau kasih sayang yang diberikan kepada seseorang oleh orang lain.

E

Emosional: adalah menyentuh perasaan.

G

Gangguan mental: adalah gangguan jiwa.

Generasi Alpha: adalah generasi yang lahir antara tahun 2010 dan 2024.

Generasi emas: adalah generasi muda Indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan kompeten. Generasi ini diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

Generasi Z: adalah generasi yang lahir pada 1997-2012.

H

Holistik: adalah cara pandang yang menyeluruh, terintegrasi, dan kompleks.

I

identitas disosiatif: adalah gangguan jiwa yang menyebabkan seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda.

Indonesia emas 2045: adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045.

Intelektual: adalah kemampuan berpikir, belajar, dan menerapkan pengetahuan secara kritis.

Intervensi spesifik: adalah kegiatan yang digunakan langsung dalam penanganan kesehatan.

Isu: adalah masalah atau topik yang sedang menjadi perbincangan atau perhatian masyarakat.

J

Juvenile Delinquency (JD): adalah (Kenakalan Remaja) Sifat remaja pada dasarnya meniru apa yang dilihat dan dirasakan oleh mereka sehingga menimbulkan imitasi terhadap sikap orang lain.

K

Kearifan lokal: adalah pandangan hidup, nilai-nilai, dan ilmu pengetahuan yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

Kesehatan mental: adalah kondisi kesejahteraan jiwa yang berkaitan dengan emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang.

Kondusif: adalah memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung.

Konselor: adalah tenaga profesional yang memberikan bantuan dan bimbingan kepada orang lain yang mengalami masalah.

KKR: adalah Kader kesehatan Remaja.

M

Manajemen krisis: adalah cara sistematis untuk mengatasi situasi yang berpotensi mengancam kehidupan.

Mental: adalah hubungannya antara pikiran, batin dan watak manusia, bukan bersifat fisik dan tenaga.

N

NAPZA: adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain.

O

Obstructive sleep apnea: adalah kondisi ketika pernapasan terganggu saat tidur karena saluran napas menyempit atau tertutup.

P

Pencegahan Primer: adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit atau kejadian buruk pada orang sehat atau kelompok berisiko.

Pencegahan Sekunder: adalah intervensi berbasis populasi atau individu untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan mengobatinya.

Pencegahan Tersier: adalah upaya pencegahan bertujuan untuk mengurangi konsekuensi dari cedera yang telah terjadi.

Perawatan diri kesehatan Jiwa: adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri. Perawatan diri dapat membantu mengatasi stres, meningkatkan energi, dan menurunkan risiko penyakit.

Post-traumatic stress disorder (PTSD): adalah gangguan mental yang dapat terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis.

PMR: adalah Palang merah remaja.

Pramuka: adalah Praja Muda karana.

Psikiatri: adalah Dokter spesialis kesehatan jiwa.

Psikoedukasi: adalah metode edukasi yang memberikan informasi dan pelatihan psikologis untuk mengubah pemahaman mental seseorang.

Psikologi: adalah ahli yang mempelajari perilaku manusia dan memberikan terapi psikologis.

Psikologis: adalah bersifat kejiwaan, berkaitan dengan pikiran, atau fenomena mental.

Psikopat: adalah istilah nonmedis yang merujuk pada gangguan kepribadian antisosial. Psikopat ditandai dengan perilaku yang melanggar norma sosial, tidak memiliki empati, dan tidak bertanggung jawab.

Psikoterapi: adalah metode terapi untuk mengatasi masalah kejiwaan.

Psikosis awal: adalah *early psychosis* (dalam bahasa Inggrisnya) adalah kondisi ketika seseorang pertama kali mengalami gejala psikosis. Gejala tersebut bisa berupa halusinasi, delusi, atau perubahan perilaku.

Psikososial: adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial dan kesehatan mental seseorang. Psikososial meliputi pikiran, emosi, perilaku, dan kemampuan bersosialisasi.

R

Resiliensi: adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi, bertahan, dan pulih dari situasi sulit atau tantangan hidup.

Retardasi mental: adalah gangguan intelektual yang menyebabkan penurunan fungsi otak dan adaptasi sosial.

S

SDM: adalah sumber daya manusia.

Selective mutism: adalah gangguan kecemasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat berbicara dalam situasi tertentu.

Self diagnosis: adalah mendiagnosis diri sendiri terkena suatu penyakit atau gangguan tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis.

SPAB: adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Skizofrenia: adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Penderita skizofrenia mungkin mengalami halusinasi, delusi, dan kekacauan berpikir.

Skrining: adalah pemeriksaan atau serangkaian prosedur untuk mendeteksi dini penyakit atau masalah kesehatan.

Sleepwalking: adalah kondisi ketika seseorang melakukan kegiatan yang tidak diinginkan seperti bangkit atau berjalan dalam keadaan sedang tertidur.

Sosialisasi: adalah upaya seseorang hingga mampu dikenal, dipahami, dihayati oleh orang lain.

T

Terapi Aktivitas Kelompok: adalah disebut TAK, terapi non-farmakologi yang dilakukan secara berkelompok untuk membantu mengatasi masalah keperawatan.

Tren: adalah pola atau arah perkembangan yang terjadi secara berulang pada suatu hal.

U

UKSJ: adalah Usaha Kesehatan Sekolah Jiwa.

UKS: adalah Usaha Kesehatan Sekolah.

V

Verbal: adalah secara lisan bukan tertulis.

W

***World Health Organization (WHO)*:** adalah organisasi kesehatan dunia.

BAB IV

PEMANFAATAN APLIKASI DIGITAL UNTUK LAYANAN KESEHATAN MENTAL

A. Pendahuluan

Remaja merupakan fase yang krusial karena pada fase ini mereka mengalami masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Usia kategori remaja menurut (WHO) yaitu usia 10 tahun – 19 tahun dimana pada masa remaja memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu pencarian identitas diri, ketergantungan teman sebaya, perkembangan kognitif, ingin mandiri. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan, terutama bagi remaja yang sedang mandiri serta eksplorasi nilai dan moralitas. Remaja juga mengalami berbagai perubahan emosional, sosial, dan akademik. Namun, masih banyak remaja yang enggan mencari bantuan profesional karena stigma sosial, keterbatasan akses, atau kurangnya informasi mengenai layanan kesehatan mental (WHO, 2022). Dalam era digital saat ini, aplikasi berbasis teknologi telah menjadi solusi inovatif untuk memberikan layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses, fleksibel, dan sesuai dengan gaya hidup remaja (Nasution & Putri, 2021).

Seiring dengan berkembangnya zaman, terdapat beberapa aplikasi digital untuk kesehatan mental yang menawarkan berbagai fitur seperti konseling online, meditasi terpandu, pelacakan suasana hati (*mood tracking*), serta komunitas pendukung yang dapat membantu remaja mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan akademik (Setiawan, 2020). Dengan memanfaatkan teknologi ini, remaja dapat memperoleh bantuan profesional atau melakukan manajemen kesehatan mental secara mandiri tanpa harus menghadapi hambatan geografis atau finansial (Saputra & Hidayat, 2021).

Di Indonesia, tren menuju solusi kesehatan digital terlihat jelas, dengan sekitar 57% orang Indonesia menggunakan aplikasi kesehatan setelah pandemi COVID-19. Sebuah survei oleh Populix pada September 2022 menunjukkan bahwa 79% responden menggunakan Halodoc untuk konsultasi kesehatan mental. Alasan utama pemilihan layanan ini meliputi kemudahan akses, keterjangkauan biaya, privasi yang terjamin, dan partisipasi dalam tren teknologi. Saat ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam layanan kesehatan mental bagi remaja. Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan mental, seperti stres,

kecemasan, dan depresi. Tekanan akademik, perubahan sosial, dan ekspektasi diri yang tinggi seringkali menjadi pemicu utama. Namun, dengan adanya aplikasi digital, akses terhadap layanan kesehatan mental menjadi lebih mudah dan efisien. Meski memiliki banyak manfaat, pemanfaatan aplikasi kesehatan mental di kalangan remaja juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya literasi digital, keamanan data pribadi, serta efektivitas layanan dibandingkan dengan terapi konvensional (Santoso, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana aplikasi ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental remaja secara optimal.

B. Pentingnya Kesadaran Kesehatan Mental pada Remaja

Kesehatan mental adalah aspek yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik, terutama pada remaja. Masa remaja merupakan periode transisi yang penuh tantangan, baik dari segi biologis, psikologis, maupun sosial. Kesadaran akan kesehatan mental menjadi kunci dalam membantu remaja menghadapi berbagai tekanan hidup serta mencegah gangguan mental yang lebih serius. Dalam kesadaran Kesehatan remaja kita harus mencegah gangguan mental sejak dini, meningkatkan kesejahteraan emosional, meningkatkan tigma terhadap gangguan mental, serta meningkatkan prestasi akademik dan sosial. Dalam hal ini yang kita bahas pertama adalah cara Mencegah Gangguan Mental Sejak Dini, berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO, 2021), setidaknya 10-20% remaja di dunia mengalami gangguan mental. Tanpa kesadaran yang cukup, gejala awal gangguan mental sering kali tidak dikenali dan dibiarkan berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan emosional, Remaja yang memahami pentingnya kesehatan mental cenderung lebih mampu mengelola emosi, mengatasi stres, dan memiliki hubungan sosial yang sehat. Kesadaran ini membantu mereka membangun ketahanan psikologis dalam menghadapi tantangan hidup (UNICEF, 2021). Cara yang kedua yaitu mengurangi stigma terhadap gangguan mental, Salah satu hambatan utama dalam penanganan kesehatan mental adalah stigma sosial. Banyak remaja enggan mencari bantuan karena takut dicap negatif oleh lingkungan sekitar. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan stigma ini dapat berkurang, sehingga remaja lebih berani mencari bantuan ketika mengalami masalah mental (Patel et al., 2018). Cara terakhir yaitu meningkatkan prestasi akademik dan sosial, kesehatan mental yang baik berkontribusi pada peningkatan konsentrasi, motivasi belajar, serta kemampuan dalam bersosialisasi. Remaja yang memiliki kesadaran akan pentingnya

kesehatan mental cenderung lebih produktif dan dapat mencapai potensi maksimal mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Selain itu terdapat beberapa factor yang mempengaruhi Kesehatan mental pada remaja, yaitu : Pendidikan di sekolah, Sekolah memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi tentang kesehatan mental melalui kurikulum, seminar, atau konseling siswa. Program ini dapat membantu remaja mengenali tanda-tanda gangguan mental dan cara mengatasinya (UNICEF, 2021). Media Sosial dan Teknologi, Informasi yang diperoleh dari media sosial dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kesadaran kesehatan mental. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mendapatkan edukasi tentang bagaimana menyaring informasi yang benar mengenai kesehatan mental (Patel et al., 2018). Lingkungan Keluarga, Dukungan dari keluarga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mental remaja. Orang tua yang terbuka terhadap diskusi mengenai kesehatan mental dapat membantu anak-anak mereka memahami dan mengelola emosinya dengan lebih baik (WHO, 2021).

Cara untuk meningkatkan kesadaran Kesehatan mental pada remaja dimulai dari pemberian edukasi tentang Kesehatan mental. Kampanye kesehatan mental melalui media sosial, seminar, dan diskusi di sekolah dapat membantu meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya kesehatan mental. Selanjutnya menyediakan akses ke layanan konseling. Sekolah dan institusi kesehatan perlu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses oleh remaja agar mereka dapat berbicara dengan profesional mengenai masalah yang dihadapi. Tahap selanjutnya yaitu, mendorong komunikasi terbuka dalam keluarga (orang tua dan anggota keluarga) dimana perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan terbuka, sehingga remaja merasa nyaman berbagi perasaan dan masalah mereka tanpa takut dihakimi. Menyediakan ruang aman bagi remaja, komunitas atau organisasi yang fokus pada kesehatan mental dapat membantu menciptakan ruang aman bagi remaja untuk berbicara, belajar, dan mendapatkan dukungan dari sesama.

C. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Remaja

Masa remaja merupakan periode transisi yang penuh dengan tantangan dan perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dalam proses perkembangannya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada peningkatan stres, kecemasan, serta gangguan mental jika tidak ditangani dengan baik. Tuntutan untuk berprestasi di sekolah sering kali menjadi sumber stres bagi remaja. Lingkungan akademik yang kompetitif mendorong siswa untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Selain itu, ekspektasi tinggi dari orang tua dan keluarga dalam hal

pencapaian akademik dapat menambah tekanan yang dirasakan oleh remaja. Sayangnya, dalam banyak kasus, perhatian orang tua lebih terfokus pada hasil akhir dibandingkan dengan proses belajar yang dijalani anak. Kurangnya fasilitas pendukung dan alternatif pembelajaran yang memadai sering kali membuat siswa merasa tertekan, tanpa adanya solusi yang konkret untuk membantu mereka mencapai prestasi akademik yang optimal.

Interaksi sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan remaja. Hubungan dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekitar dapat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan emosional mereka. Stabilitas ekonomi, status sosial, serta prestasi akademik sering kali menentukan kualitas hubungan sosial yang dimiliki seorang remaja, terutama di lingkungan sekolah. Remaja yang merasa tidak diterima atau mengalami tekanan sosial akibat faktor-faktor tersebut bisa mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan sosial atau bahkan depresi. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan sekitar menjadi faktor krusial dalam menjaga kesehatan mental mereka.

Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif pada citra diri dan kepercayaan diri mereka. Banyak remaja yang membandingkan diri mereka dengan standar kecantikan, kesuksesan, atau gaya hidup yang sering ditampilkan di media sosial. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap diri sendiri dan berujung pada masalah seperti kecemasan atau gangguan makan. Sebagai bentuk pelarian dari ketidakpuasan yang mereka alami, remaja cenderung semakin tergantung pada media sosial untuk mencari kenyamanan, meskipun pada akhirnya hal ini justru dapat memperburuk kondisi mental mereka.

Selama masa pubertas, remaja mengalami berbagai perubahan biologis yang dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku mereka. Perubahan hormon ini sering kali menyebabkan remaja menjadi lebih emosional dan sensitif terhadap lingkungan sekitar. Bagi sebagian remaja, terutama perempuan, perubahan hormon juga dapat meningkatkan risiko gangguan mood, seperti perubahan suasana hati yang drastis atau perasaan cemas yang berlebihan. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan hormonal ini dapat berkontribusi pada gangguan mental yang lebih serius, seperti depresi atau gangguan kecemasan.

Masa remaja merupakan periode yang penuh tantangan, di mana berbagai faktor seperti tekanan akademik, hubungan sosial, paparan media sosial, dan perubahan hormonal dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial untuk memberikan dukungan yang cukup agar remaja dapat menghadapi tantangan tersebut dengan lebih baik. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental

remaja, kita dapat membantu mereka mengembangkan strategi coping yang sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan emosional mereka.

D. Upaya Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Mental

Kesadaran akan kesehatan mental di kalangan remaja merupakan aspek penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat secara emosional dan psikologis. Seiring dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi remaja, seperti tekanan akademik, hubungan sosial, serta paparan media digital, diperlukan berbagai langkah konkret untuk membantu mereka memahami pentingnya menjaga kesehatan mental. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental di kalangan remaja.

Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental adalah melalui edukasi dan penyuluhan di sekolah serta komunitas. Program edukasi ini harus dilakukan secara rutin agar remaja dapat memahami pentingnya kesehatan mental dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan emosional mereka. Selain itu, pendekatan yang konsisten dapat membangun kepercayaan (trust) di antara remaja terhadap isu kesehatan mental. Dengan adanya edukasi yang terus-menerus, remaja akan lebih terbuka dalam mencari bantuan ketika menghadapi masalah psikologis.

Pada era digital saat ini, remaja sangat bergantung pada teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital menjadi langkah penting dalam mendukung kesehatan mental mereka. Remaja perlu dibekali pemahaman tentang bagaimana menggunakan teknologi secara positif, seperti mengakses informasi kesehatan mental yang kredibel, mengikuti komunitas yang mendukung kesehatan emosional, serta membatasi konsumsi konten yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis mereka. Dengan literasi digital yang baik, remaja dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi untuk mendukung kesejahteraan mental mereka.

Hubungan sosial yang sehat sangat berperan dalam menjaga kesehatan mental remaja. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk membangun koneksi yang positif dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Dukungan sosial yang kuat dapat menjadi sumber kekuatan emosional bagi remaja ketika menghadapi tekanan hidup. Mendorong komunikasi yang terbuka dan empati dalam keluarga serta menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dapat membantu remaja merasa lebih dihargai dan dipahami, sehingga mengurangi risiko gangguan kesehatan mental.

Selain meningkatkan kesadaran, ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan mental juga harus menjadi perhatian utama. Remaja perlu mendapatkan akses yang mudah ke layanan konseling dan psikologis agar mereka dapat memperoleh bantuan yang dibutuhkan tanpa merasa terhambat oleh stigma atau tabu yang masih melekat dalam masyarakat. Selain itu, penting untuk menanamkan kesadaran kepada remaja bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dengan demikian, mereka tidak akan ragu untuk mencari bantuan profesional ketika diperlukan dan tidak lagi menganggap kesehatan mental sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan.

Meningkatkan kesadaran kesehatan mental di kalangan remaja membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah. Melalui edukasi yang berkelanjutan, literasi digital yang baik, dukungan sosial yang kuat, serta akses layanan kesehatan mental yang lebih luas, remaja dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan mental mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan remaja dapat tumbuh menjadi individu yang lebih sehat secara emosional dan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

E. Terapi Mandiri dan Manajemen Stress pada Remaja

Terapi mandiri dan manajemen stress pada remaja merupakan pendekatan yang penting untuk membantu mereka yang mengalami tekanan emosional dan psikologis yang sering muncul selama masa transisi. Salah satunya adalah terapi mandiri untuk remaja dimana di dalamnya terdapat *Self-Talk* Positif (Teknik yang melibatkan pemikiran negative dan afirmasi positif untuk meningkatkan kepercayaan diri dan dapat mengurangi kecemasan yang dialami), Meditasi dan relaksasi (latihan meditasi pernafasan yang dapat dilakukan adalah yoga, meditasi dan pilates. Latihan olahraga ini dapat membantu menenangkan pikiran dan dapat mengurangi stres) yang terakhir ada Jurnal emosi (dimana para remaja dapat menuliskan jurnal mengenai pola emosi dan pemeliharaan stress serta memberikan refleksi diri pada dirinya).

Terapi manajemen stress pada remaja bertujuan untuk mengurangi dampak negative stress pada Kesehatan mental dan fisik. Beberapa Teknik efektif untuk remaja meliputi *Guided Imagery* (Teknik yang melibatkan visualisasi situasi yang menenangkan untuk merangsang respon relaksasi), *Problem-Focused Coping* (remaja diajarkan untuk menghadapi masalah secara langsung dengan cara mencari Solusi yang praktis), Dukungan sosial (membina hubungan yang baik dengan teman, keluarga, ataupun konselor dapat membuat mengurangi beban emosional. Dan

yang terakhir adalah pendekatan pendekatan holistik, dimana pendekatan ini mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial sangat penting. Aktivitas fisik seperti olahraga, pola makan yang sehat, dan tidur yang cukup juga dapat memberikan kontribusi pada manajemen stress yang efektif.

F. Akses Pelayanan Kesehatan Mental pada Remaja

Masa remaja adalah fase penting dalam perkembangan individu yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Namun, dalam proses ini, banyak remaja menghadapi tantangan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Sayangnya, meskipun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, akses terhadap layanan kesehatan mental bagi remaja masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor seperti stigma sosial, keterbatasan tenaga profesional, serta kendala finansial dan geografis sering kali menghalangi remaja untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kondisi akses layanan kesehatan mental pada remaja serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkannya.

G. Kondisi Akses Pelayanan Kesehatan pada Remaja

Akses terhadap layanan kesehatan mental bagi remaja bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, tingkat kesadaran masyarakat, serta kebijakan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan mental. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10-20% remaja di seluruh dunia mengalami gangguan mental, tetapi sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan perawatan yang memadai (WHO, 2021). Di beberapa negara, layanan kesehatan mental untuk remaja masih terbatas dan lebih berfokus pada penanganan masalah kesehatan fisik. Padahal, kesehatan mental yang buruk dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan remaja, termasuk prestasi akademik, hubungan sosial, serta risiko keterlibatan dalam perilaku berisiko tinggi seperti penyalahgunaan zat dan tindakan melukai diri sendiri (Kessler et al., 2005).

Salah satu manfaat utama konseling online berbasis aplikasi adalah aksesibilitasnya. Banyak individu yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan mental karena keterbatasan geografis, jadwal yang padat, atau hambatan fisik lainnya. Dengan adanya aplikasi konseling, individu dapat berbicara dengan profesional kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke klinik atau rumah sakit (Andersson et al., 2014). Hal ini sangat membantu bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Konseling online juga lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Sesi terapi yang dilakukan melalui aplikasi

menghilangkan kebutuhan untuk bepergian ke lokasi konselor, sehingga menghemat biaya transportasi dan waktu perjalanan. Selain itu, beberapa aplikasi menawarkan layanan dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan sesi terapi tatap muka, sehingga lebih banyak individu dapat memperoleh bantuan psikologis tanpa harus khawatir tentang biaya yang tinggi (Richards & Viganó, 2013).

Bagi banyak orang, membicarakan masalah kesehatan mental secara langsung bisa menjadi hal yang menakutkan atau tidak nyaman. Konseling online berbasis aplikasi memberikan kesempatan bagi individu untuk berkomunikasi dengan konselor dari tempat yang nyaman, seperti rumah mereka sendiri. Selain itu, beberapa aplikasi memungkinkan pengguna untuk tetap anonim, yang dapat mengurangi rasa takut akan stigma sosial dan membuat mereka lebih nyaman dalam berbicara tentang perasaan atau masalah yang mereka alami (Ebert et al., 2018).

Berbeda dengan sesi terapi konvensional yang memiliki keterbatasan waktu, konseling online berbasis aplikasi menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Pengguna dapat memilih jadwal yang sesuai dengan rutinitas mereka, bahkan di luar jam kerja normal. Beberapa platform juga menyediakan layanan chat atau pesan instan, sehingga pengguna bisa mendapatkan dukungan psikologis secara real-time atau sesuai kebutuhan mereka (Baumeister et al., 2014).

Aplikasi konseling online biasanya menawarkan berbagai metode terapi, seperti sesi video call, chat, atau bahkan terapi berbasis teks. Hal ini memungkinkan individu untuk memilih metode yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Beberapa aplikasi juga menyediakan sumber daya tambahan, seperti jurnal refleksi, latihan mindfulness, dan program terapi kognitif berbasis digital yang dapat membantu pengguna mengelola kondisi mereka secara mandiri (Carlbring et al., 2018).

Selain menyediakan layanan konseling, banyak aplikasi juga menawarkan konten edukatif mengenai kesehatan mental. Artikel, video, dan modul pelatihan yang tersedia dapat membantu pengguna memahami kondisi mereka dengan lebih baik serta mengembangkan keterampilan untuk menghadapi tantangan mental dan emosional mereka (Firth et al., 2019). Dengan adanya sumber informasi yang mudah diakses, individu dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mental mereka.

H. Hambatan dalam Akses Layanan Kesehatan Mental pada Remaja

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam tumbuh kembang remaja. Namun, meskipun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, akses terhadap layanan kesehatan mental bagi remaja masih menghadapi berbagai hambatan. Remaja sering kali mengalami tekanan dari

berbagai aspek kehidupan, seperti akademik, sosial, dan keluarga, yang dapat berdampak pada kondisi psikologis mereka. Sayangnya, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental membuat banyak remaja tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Artikel ini akan membahas berbagai hambatan yang menghambat akses layanan kesehatan mental bagi remaja serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka

Akses terhadap layanan kesehatan mental bagi remaja masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat mereka mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Salah satu hambatan utama adalah stigma sosial dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Banyak remaja enggan mencari bantuan profesional karena takut dicap sebagai "lemah" atau "bermasalah." Stigma ini diperkuat oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan teman sebaya, yang sering kali memiliki pemahaman terbatas mengenai kesehatan mental. Akibatnya, remaja yang mengalami gangguan mental lebih memilih untuk menyembunyikan masalah mereka daripada mencari pertolongan yang tepat (Gulliver et al., 2010).

Selain stigma, kurangnya informasi dan edukasi tentang kesehatan mental juga menjadi kendala signifikan. Banyak remaja dan orang tua mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tanda-tanda gangguan mental serta layanan yang tersedia. Hal ini menyebabkan banyak kasus gangguan mental yang tidak terdiagnosis dan tidak mendapatkan penanganan yang sesuai. Kurangnya edukasi ini membuat remaja sulit mengenali kapan mereka memerlukan bantuan dan bagaimana cara mengakses layanan yang tersedia (Rickwood et al., 2007).

Hambatan lainnya adalah terbatasnya tenaga profesional dan fasilitas kesehatan mental, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Jumlah psikolog dan psikiater yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah remaja yang membutuhkan layanan. Selain itu, tidak semua fasilitas kesehatan memiliki layanan khusus untuk kesehatan mental remaja, sehingga mereka harus mencari bantuan di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka (WHO, 2021). Kendala finansial juga menjadi faktor penghambat dalam akses layanan kesehatan mental. Biaya konsultasi dengan psikolog atau psikiater sering kali cukup mahal, dan tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial untuk membayar layanan tersebut. Meskipun ada beberapa program subsidi dari pemerintah atau organisasi sosial, jumlahnya masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh remaja yang membutuhkan (Patel et al., 2007). hambatan geografis dan transportasi menjadi tantangan bagi remaja yang tinggal di daerah terpencil. Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan mental serta keterbatasan transportasi membuat mereka kesulitan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Beberapa remaja bahkan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional, yang pada

akhirnya membuat mereka enggan mencari bantuan (Anderson et al., 2017). Selain faktor eksternal, kurangnya dukungan dari keluarga juga dapat menghambat remaja dalam mencari bantuan profesional. Beberapa orang tua masih menganggap bahwa masalah kesehatan mental hanyalah "fase" yang akan berlalu dengan sendirinya, sehingga mereka tidak memberikan perhatian yang cukup. Padahal, peran keluarga sangat penting dalam mendorong remaja untuk mengakses layanan kesehatan mental dan mendukung mereka dalam proses pemulihan (Reardon et al., 2017).

Akses terhadap layanan kesehatan mental bagi remaja masih menghadapi berbagai hambatan yang dapat berdampak serius pada kesejahteraan mereka. Jika tidak segera ditangani, masalah kesehatan mental dapat memburuk dan berisiko menimbulkan dampak jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan zat, bahkan peningkatan risiko bunuh diri. Selain itu, kesehatan mental yang tidak terjaga juga dapat mempengaruhi prestasi akademik, hubungan sosial, dan perkembangan emosional remaja. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut. Langkah-langkah seperti meningkatkan edukasi kesehatan mental, menyediakan layanan berbasis sekolah, mengembangkan telemedicine, serta memperluas dukungan finansial dan infrastruktur menjadi solusi penting dalam memastikan bahwa remaja mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental. Dengan dukungan yang tepat, remaja dapat menjaga kesejahteraan mental mereka dan berkembang secara optimal dalam kehidupan.

I. Upaya untuk Meningkatkan Akses Layanan Digital untuk Kesehatan Mental

Karena kegelisahan dan beberapa hambatan yang muncul untuk meningkatkan layanan Kesehatan mental dalam era digital, pemanfaatan teknologi telah membuka peluang baru dalam meningkatkan akses layanan kesehatan mental, terutama bagi remaja dan kelompok yang sulit menjangkau layanan konvensional. Layanan digital menawarkan fleksibilitas, anonimitas, dan keterjangkauan yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Untuk memastikan bahwa layanan digital dapat dimanfaatkan secara optimal, berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk pengembangan platform digital, edukasi dan literasi digital, serta peningkatan keterjangkauan layanan bagi masyarakat luas. Pertama akan kita bahas tentang Pengembangan Aplikasi dan Platform Digital. Salah satu upaya utama dalam meningkatkan akses layanan kesehatan mental adalah dengan mengembangkan aplikasi dan platform digital yang menyediakan layanan konseling, terapi, dan dukungan psikologis. Aplikasi seperti *BetterHelp*, *Talkspace*, dan *Woebot* telah

memberikan akses kepada individu untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental melalui telekonsultasi. Selain itu, fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) juga telah diterapkan dalam beberapa aplikasi untuk memberikan rekomendasi awal kepada pengguna berdasarkan kondisi mereka (Firth et al., 2019).

Meskipun layanan digital semakin berkembang, banyak individu masih kurang memahami cara memanfaatkan teknologi untuk mengakses layanan kesehatan mental. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan literasi digital menjadi langkah penting. Program edukasi dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, seminar daring, serta kerja sama dengan sekolah dan institusi pendidikan untuk mengajarkan remaja cara mengenali sumber layanan kesehatan mental yang terpercaya secara daring (Naslund et al., 2017). Agar layanan kesehatan mental digital lebih efektif, integrasi dengan sistem layanan kesehatan tradisional perlu dilakukan. Misalnya, fasilitas kesehatan dan tenaga profesional dapat merekomendasikan penggunaan aplikasi tertentu sebagai bagian dari terapi atau rujukan awal sebelum konsultasi tatap muka. Beberapa negara telah menerapkan model integrasi ini untuk memastikan bahwa layanan digital dapat mendukung, bukan menggantikan, layanan kesehatan mental konvensional (Torous et al., 2018).

Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet, terutama di daerah pedesaan atau komunitas dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan digital sangat penting. Pemerintah dan organisasi sosial dapat bekerja sama untuk menyediakan subsidi atau paket internet yang lebih terjangkau bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, pengembangan aplikasi berbasis offline juga dapat membantu individu yang memiliki keterbatasan akses internet tetap mendapatkan dukungan kesehatan mental (Hollis et al., 2015). Keamanan dan privasi menjadi perhatian utama dalam layanan digital kesehatan mental. Untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, penyedia layanan harus memastikan bahwa data pribadi mereka terlindungi dengan baik. Regulasi terkait perlindungan data, seperti GDPR di Eropa atau kebijakan serupa di berbagai negara, perlu diterapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan data (Lupton, 2020).

Layanan digital untuk kesehatan mental menawarkan solusi inovatif dalam meningkatkan akses bagi individu yang membutuhkan dukungan psikologis. Dengan pengembangan aplikasi, edukasi literasi digital, integrasi dengan layanan konvensional, serta peningkatan keterjangkauan dan keamanan data, layanan ini dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani berbagai tantangan kesehatan mental di era digital. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk

pemerintah, institusi kesehatan, dan masyarakat, sangat diperlukan agar layanan ini dapat diakses oleh lebih banyak orang secara aman dan efektif.

J. Akses Mudah ke Layanan Kesehatan Mental Melalui Konseling Online Berbasis Aplikasi

Dalam beberapa tahun terakhir, akses ke layanan kesehatan mental telah mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya konseling online berbasis aplikasi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan individu untuk mendapatkan bantuan psikologis tanpa harus mengunjungi klinik atau rumah sakit secara langsung. Model layanan ini menjadi solusi efektif bagi banyak orang, terutama mereka yang menghadapi hambatan seperti keterbatasan waktu, biaya, atau stigma sosial terkait kesehatan mental.

Berbagai platform telah dikembangkan untuk memberikan layanan kesehatan mental berbasis aplikasi. Beberapa yang populer di antaranya adalah BetterHelp (Menyediakan layanan terapi online dengan psikolog bersertifikat, serta fleksibilitas dalam memilih metode komunikasi), Talkspace (Memungkinkan pengguna untuk mengakses terapis profesional melalui chat atau video call dengan berbagai paket langganan), Riliv (Aplikasi berbasis di Indonesia yang menawarkan layanan konseling dengan psikolog melalui chat serta meditasi berbasis audio), Wysa (Menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan dukungan emosional dan strategi manajemen stres sebelum terhubung dengan profesional), dan Sanvello (Aplikasi yang menggabungkan terapi berbasis kognitif, meditasi, serta pelacakan suasana hati untuk membantu pengguna mengelola kesehatan mental mereka). Dengan adanya berbagai platform konseling online berbasis aplikasi, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah dan fleksibel untuk mendapatkan bantuan kesehatan mental yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi klinik secara langsung.

K. Penutup

Kesadaran akan kesehatan mental pada remaja sangat penting dalam mencegah gangguan mental, meningkatkan kesejahteraan emosional, mengurangi stigma, serta mendukung prestasi akademik dan sosial mereka. Berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk meningkatkan literasi kesehatan mental dan memberikan akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan remaja dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan mencapai potensi maksimal mereka.

Konseling online berbasis aplikasi telah membuka peluang besar dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental. Dengan kemudahan akses, biaya yang lebih terjangkau, fleksibilitas metode komunikasi, serta jaminan privasi, layanan ini menjadi solusi yang efektif bagi individu yang membutuhkan dukungan psikologis tanpa harus menghadapi hambatan seperti stigma sosial atau keterbatasan geografis. Dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, konseling online akan terus menjadi alat yang berharga dalam mendukung kesejahteraan psikologis masyarakat.

Aplikasi kesehatan mental memiliki potensi besar dalam membantu individu mengelola kesehatan psikologis mereka, tetapi keamanan dan privasi pengguna harus menjadi prioritas utama. Pengembang, pengguna, dan pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data pribadi tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan. Dengan meningkatkan kesadaran dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih baik, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi pengguna aplikasi kesehatan mental.

Referensi

- Anderson, J. K., Howarth, E., Vainre, M., Jones, P. B., & Humphrey, A. (2017). A scoping review of accessibility barriers to mental health services for young people in the UK. *BMJ Open*, 7(6), e012337.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). *From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification"*. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 9-15.
- Fakhriyani, D. (2019). *Kesehatan Mental*. Duta Media Publishing.
- Farika, S. A., Mirza, M. N., & Romas, A. N. (2024). Promosi Kesehatan tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental pada Remaja. *Jurnal Pengabdian dan Kesehatan*, 1(1).
- Fauzi, M. I., Studi, P., Komunikasi, D., & Desain, F. (2022). Tinjauan Visual Storytelling pada Film Pendek sebagai Gerakan Kampanye Kesadaran terhadap Kesehatan Mental pada Remaja. *Jurnal Kebajikan*, 2(1), 6–12.
- Firth, J., Torous, J., Nicholas, J., Carney, R., Pratap, A., Rosenbaum, S., & Sarris, J. (2019). The efficacy of smartphone-based mental health interventions for depressive symptoms: A meta-analysis of randomized controlled trials. *World Psychiatry*, 18(3), 325–336.
- Gulliver, A., Griffiths, K. M., & Christensen, H. (2010). Perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in young people: A systematic review. *BMC Psychiatry*, 10(1), 113.
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). *Does Gamification Work? A Literature Review of Empirical Studies on Gamification*. Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences.
- Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2015). Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems—a systematic and meta-review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(7), 674–703.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Strategi Nasional Kesehatan Jiwa di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the

- National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 593-602.
- Lupton, D. (2020). The digitally engaged patient: Self-monitoring and self-care in the digital health era. *Social Theory & Health*, 18(2), 135–150.
- Naslund, J. A., Aschbrenner, K. A., Marsch, L. A., & Bartels, S. J. (2017). The future of mental health care: Peer-to-peer support and social media. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 26(5), 463–470.
- Nasution, F., & Putri, R. (2021). *Peran teknologi dalam kesehatan mental remaja: Studi tentang penggunaan aplikasi digital*. Jurnal Psikologi Digital, 5(2), 45-58
- Patel, V., Flisher, A. J., Hetrick, S., & McGorry, P. (2007). Mental health of young people: A global public-health challenge. *The Lancet*, 369(9569), 1302-1313.
- Patel, V., Saxena, S., Lund, C., et al. (2018). *The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development*. The Lancet, 392(10157), 1553-1598.
- Reardon, T., Harvey, K., Baranowska, M., O'Brien, D., Smith, L., & Creswell, C. (2017). What do parents perceive are the barriers and facilitators to accessing psychological treatment for mental health problems in children and adolescents? A systematic review of qualitative and quantitative studies. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 26(6), 623-647.
- Rickwood, D., Deane, F. P., Wilson, C. J., & Ciarrochi, J. (2007). Young people's help-seeking for mental health problems. *Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health*, 4(3), 218-251.
- Santoso, D. (2022). *Keamanan data dan efektivitas layanan kesehatan mental berbasis digital bagi remaja*. Jurnal Keamanan Siber, 3(3), 87-99
- Saputra, A., & Hidayat, T. (2021). *Pengaruh aplikasi kesehatan mental terhadap kesejahteraan psikologis remaja di Indonesia*. Jurnal Psikologi Remaja, 8(1), 102-115.
- Setiawan, B. (2020). *Dampak penggunaan aplikasi meditasi dan self-help terhadap kesehatan mental remaja*. Jurnal Teknologi & Psikologi, 7(2), 66-78.
- Sholihah, W., Suswati, E., Budiman, M. E. A., & Yuhbaba, Z. N. (2023). Kesehatan Mental pada Remaja di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Wilayah Urban dan Rural Kabupaten Jember. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 11(3), 537–545.

- Torous, J., Nicholas, J., Larsen, M. E., Firth, J., & Christensen, H. (2018). Clinical review of user engagement with mental health smartphone apps: Evidence, theory and improvements. *Evidence-Based Mental Health*, 21(3), 116–119.
- UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health*. New York: UNICEF.
- WHO. (2021). *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All*. Geneva: World Health Organization
- World Health Organization (WHO). (2022). *Adolescent mental health: A pressing global issue*. Retrieved from www.who.int
- Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

BAB V

STRATEGI BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL REMAJA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Remaja merupakan periode transisi dari anak-anak ke dewasa yang diwarnai dengan berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Periode ini berlangsung sekitar 10-19 tahun dan merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan identitas diri, pengembangan kemampuan kognitif dan emosional, serta pembentukan hubungan sosial (WHO, 2018).

Namun, remaja juga merupakan periode yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan gangguan kepribadian. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10-20% remaja di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental (WHO, 2019).

Pentingnya Kesehatan Mental Remaja

Kesehatan mental remaja sangat penting karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti:

Di Indonesia, masalah kesehatan mental remaja juga merupakan isu yang serius. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 12,3% remaja di Indonesia mengalami depresi, sedangkan 10,3% mengalami kecemasan (Kemenkes RI, 2018).

Kesehatan mental remaja sangat penting karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti:

- Prestasi akademik: Remaja dengan masalah kesehatan mental cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah (Hankin, 2012).
- Hubungan sosial: Remaja dengan masalah kesehatan mental cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih buruk (Hartup, 1999).
- Kesehatan fisik: Remaja dengan masalah kesehatan mental cenderung memiliki kesehatan fisik yang lebih buruk (Kessler, 2003).
- Risiko bunuh diri: Remaja dengan masalah kesehatan mental cenderung memiliki risiko bunuh diri yang lebih tinggi (Nock, 2013).

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan masalah kesehatan mental remaja, serta mengembangkan strategi untuk mendukung kesehatan mental remaja.

2. Statistik Kesehatan Mental Remaja

Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10-20% remaja di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental (WHO, 2019). Di Indonesia, sekitar 12,3% remaja mengalami depresi, sedangkan 10,3% mengalami kecemasan (Kemenkes RI, 2018).

3. Tujuan

- a. 1.Meningkatkan kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental remaja dan strategi berbasis komunitas untuk mendukungnya.
- b. 2.Mengembangkan strategi: Mengembangkan strategi berbasis komunitas yang efektif untuk mendukung kesehatan mental remaja.
- c. 3.Meningkatkan kemampuan: Meningkatkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan masalah kesehatan mental lainnya.
- d. 4.Meningkatkan dukungan sosial: Meningkatkan dukungan sosial untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

4. Ruang Lingkup

- a. Definisi dan konsep kesehatan mental remaja: Definisi dan konsep kesehatan mental remaja, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja.
- b. Strategi berbasis komunitas: Strategi berbasis komunitas untuk mendukung kesehatan mental remaja, termasuk contoh-contoh program yang telah dilaksanakan.
- c. Peran dan fungsi komunitas: Peran dan fungsi komunitas dalam mendukung kesehatan mental remaja, termasuk peran keluarga, sekolah, dan lembaga masyarakat.
- b. Evaluasi dan monitoring: Evaluasi dan monitoring program kesehatan mental remaja berbasis komunitas untuk memastikan keefektifannya.

5. Sasaran

- a. Remaja: Remaja usia 10-19 tahun yang berpotensi mengalami masalah kesehatan mental.

- b. Orang tua: Orang tua yang ingin mendukung kesehatan mental anak-anak mereka.
- c. Pendidik: Pendidik yang ingin mendukung kesehatan mental siswa-siswi mereka.
- d. Pekerja sosial: Pekerja sosial yang ingin mendukung kesehatan mental masyarakat.

B. Konsep dan Teori Kesehatan Mental Remaja

1. Konsep Kesehatan Mental Remaja

Kesehatan mental remaja merujuk pada kondisi mental dan emosional yang sehat dan optimal selama masa remaja (WHO, 2018). Kesehatan mental remaja mencakup aspek-aspek seperti:

- a. Keseimbangan Emosi: Kemampuan untuk mengelola dan mengatur emosi dengan baik.
- b. Kemampuan Menghadapi Stres: Kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi stres dan tekanan.
- c. Kemampuan Berinteraksi Sosial: Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan baik.
- d. Kemampuan Mengambil Keputusan: Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijak.

2. Teori Kesehatan Mental Remaja

Beberapa teori yang relevan dengan kesehatan mental remaja, antara lain:

- a. Teori Perkembangan Remaja (Erikson, 1963): Teori ini menjelaskan bahwa remaja mengalami proses perkembangan yang unik dan penting dalam membentuk identitas diri.
- b. 2. Teori Kesehatan Mental Positif (Seligman, 2011): Teori ini menjelaskan bahwa kesehatan mental positif dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi stres dan tekanan.
- c. 3. Teori Ekologi (Bronfenbrenner, 1979): Teori ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.

3. Model Kesehatan Mental Remaja

- a. Model Kesehatan Mental Berbasis Komunitas (WHO, 2018): Model ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dengan melibatkan komunitas dan lingkungan.

- b. Model Kesehatan Mental Berbasis Sekolah (Hamburg, 1992): Model ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dengan melibatkan sekolah dan pendidik.
- c. Model Kesehatan Mental Berbasis Keluarga (Walsh, 2012): Model ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dengan melibatkan keluarga dan orang tua.

Teori dan Model Kesehatan Mental Remaja yang Lain :

- 1. Teori Kesehatan Mental Resilien (Garmezy, 1991): Teori ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dengan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi stres dan tekanan.
- 2. Model Kesehatan Mental Berbasis Pengembangan (Havighurst, 1972): Model ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dengan melibatkan pengembangan kemampuan dan keterampilan.

penjelasan lebih rinci tentang teori kesehatan mental remaja:

- 1. Teori Perkembangan Remaja (Erikson, 1963)
Teori ini menjelaskan bahwa remaja mengalami proses perkembangan yang unik dan penting dalam membentuk identitas diri. Erikson mengidentifikasi delapan tahap perkembangan, termasuk tahap "identitas vs. kebingungan" yang dialami oleh remaja.
- 2. Teori Kesehatan Mental Positif (Seligman, 2011)
Teori ini menjelaskan bahwa kesehatan mental positif dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi stres dan tekanan. Seligman mengidentifikasi lima komponen kesehatan mental positif, yaitu:
 - a. Kemampuan Menghadapi Stres: Kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi stres dan tekanan.
 - b. Kemampuan Mengembangkan Kemampuan: Kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan.
 - c. Kemampuan Membangun Hubungan: Kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan positif.
 - d. Kemampuan Mengembangkan Makna: Kemampuan untuk mengembangkan makna dan tujuan hidup.
 - e. Kemampuan Mengembangkan Keseimbangan: Kemampuan untuk mengembangkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup.

3. Teori Ekologi (Bronfenbrenner, 1979)

Teori ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bronfenbrenner mengidentifikasi lima sistem lingkungan yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, yaitu:

- a. Sistem Mikro: Sistem lingkungan yang langsung mempengaruhi remaja, seperti keluarga dan sekolah.
- b. Sistem Meso: Sistem lingkungan yang mempengaruhi remaja melalui interaksi dengan sistem mikro, seperti hubungan antara keluarga dan sekolah.
- b. Sistem Makro: Sistem lingkungan yang mempengaruhi remaja melalui kebijakan dan struktur sosial, seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan.
- c. Sistem Krono: Sistem lingkungan yang mempengaruhi remaja melalui perubahan waktu, seperti perubahan dalam kehidupan keluarga dan sekolah.
- d. Sistem Eko: Sistem lingkungan yang mempengaruhi remaja melalui interaksi dengan lingkungan alam, seperti kualitas udara dan air.

Model Kesehatan Mental

1. Model Kesehatan Mental Berbasis Komunitas

Model ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dengan melibatkan komunitas dan lingkungan. Model ini berfokus pada:

- a. Pengembangan Kemampuan: Pengembangan kemampuan dan keterampilan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
- b. Pengembangan Dukungan Sosial: Pengembangan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat.
- c. Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja, seperti sekolah dan komunitas yang aman dan mendukung.

2. Model Kesehatan Mental Berbasis Sekolah

Model ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dengan melibatkan sekolah dan pendidik. Model ini berfokus pada:

- a. Pengembangan Kurikulum: Pengembangan kurikulum yang mendukung kesehatan mental remaja, seperti pelajaran tentang kesehatan mental dan pengembangan kemampuan.
- b. Pengembangan Dukungan dari Pendidik: Pengembangan dukungan dari pendidik untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

- c. Pengembangan Lingkungan Sekolah yang Mendukung: Pengembangan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan mental remaja, seperti sekolah yang aman dan mendukung.
3. Model Kesehatan Mental Berbasis Keluarga
- Model ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dengan melibatkan keluarga dan orang tua. Model ini berfokus pada:
- a. Pengembangan Dukungan dari Keluarga: Pengembangan dukungan dari keluarga untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
 - b. Pengembangan Kemampuan Orang Tua: Pengembangan kemampuan orang tua untuk mendukung kesehatan mental remaja.
 - b. Pengembangan Lingkungan Keluarga yang Mendukung: Pengembangan lingkungan keluarga yang mendukung kesehatan mental remaja, seperti keluarga yang aman dan mendukung.
4. Model Kesehatan Mental Resilien
- Model ini menjelaskan bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dengan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi stres dan tekanan. Model ini berfokus pada:
- a. Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres: Pengembangan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi stres dan tekanan.
 - b. Pengembangan Dukungan Sosial: Pengembangan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat.
 - c. Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja, seperti sekolah dan komunitas yang aman dan mendukung.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Remaja

Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja, antara lain:

- 1. Faktor genetik
- 2. Faktor lingkungan, seperti keluarga yang tidak harmonis atau pengalaman trauma
- 3. Faktor psikologis, seperti rendah diri atau kurangnya kemampuan menghadapi stres
- 4. Faktor sosial, seperti tekanan dari teman sebaya atau kurangnya dukungan sosial (Hankin, 2012)

Kesehatan mental remaja merupakan isu krusial karena masa ini adalah periode perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Berbagai faktor dapat berinteraksi dan memengaruhi kondisi mental seorang remaja. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok utama:

1. **Faktor Biologis:**

- a. **Genetika:** Riwayat keluarga dengan gangguan mental dapat meningkatkan risiko pada remaja. Gen tertentu dapat memengaruhi kerentanan seseorang terhadap kondisi seperti depresi, kecemasan, atau skizofrenia.
- b. **Perkembangan Otak:** Otak remaja masih dalam tahap perkembangan, terutama pada area yang mengatur emosi, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls. Ketidakseimbangan dalam perkembangan ini dapat memengaruhi kesehatan mental.
- c. **Hormon:** Perubahan hormonal signifikan selama pubertas dapat memengaruhi suasana hati dan perilaku remaja, meningkatkan risiko masalah kesehatan mental.
- d. **Kesehatan Fisik:** Kondisi kesehatan fisik kronis, seperti penyakit autoimun atau nyeri kronis, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Selain itu, gaya hidup tidak sehat seperti kurang tidur, pola makan buruk, dan kurang aktivitas fisik juga dapat berkontribusi.
- e. **Zat Kimia Otak (Neurotransmitter):** Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin telah dikaitkan dengan berbagai gangguan mental.

2. **Faktor Psikologis:**

- a. **Harga Diri:** Rendahnya harga diri dapat membuat remaja lebih rentan terhadap stres, kecemasan, dan depresi.
- b. **Pola Pikir:** Pola pikir negatif, perfeksionisme yang tidak sehat, dan kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental.
- c. **Keterampilan Koping:** Kurangnya keterampilan dalam mengatasi stres dan emosi negatif dapat meningkatkan risiko gangguan mental.
- d. **Pengalaman Traumatis:** Pengalaman traumatis seperti pelecehan fisik, emosional, atau seksual, kekerasan, atau kehilangan orang yang dicintai dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental remaja.
- e. **Stres:** Tekanan akademik, masalah dengan teman sebaya, perubahan hidup yang signifikan, dan ekspektasi yang tinggi dapat menyebabkan stres yang berkontribusi pada masalah kesehatan mental.

- f. **Citra Tubuh:** Tekanan sosial dan media sering kali menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis, yang dapat menyebabkan masalah citra tubuh, terutama pada remaja perempuan, dan berkontribusi pada kecemasan dan depresi.

3. **Faktor Sosial:**

a. **Keluarga:**

- 1) **Dinamika Keluarga:** Konflik keluarga yang sering terjadi, kurangnya komunikasi yang sehat, kekerasan dalam rumah tangga, atau perceraian orang tua dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja.
- 2) **Pola Asuh:** Pola asuh yang tidak mendukung, terlalu otoriter, atau abai dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental pada remaja. Pola asuh yang hangat, responsif, dan memberikan dukungan otonomi dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik.
- 3) **Dukungan Orang Tua:** Kurangnya dukungan emosional dan keterlibatan orang tua dapat memperburuk kondisi mental remaja.

b. **Teman Sebaya:**

- 1) **Bullying:** Menjadi korban atau pelaku bullying (baik secara langsung maupun *cyberbullying*) dapat menyebabkan trauma emosional jangka panjang, rendahnya rasa percaya diri, dan kecemasan sosial.
- 2) **Dukungan Teman Sebaya:** Memiliki teman yang suportif dan positif dapat menjadi faktor pelindung bagi kesehatan mental remaja.
- 3) **Tekanan Teman Sebaya:** Tekanan untuk melakukan perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat atau aktivitas seksual yang tidak aman dapat berdampak negatif pada kesehatan mental.

c. **Sekolah:**

- 4) **Tekanan Akademik:** Beban tugas yang berat, tuntutan untuk berprestasi tinggi, dan persaingan akademik dapat menyebabkan stres dan *burnout*.
- 5) **Iklim Sekolah:** Lingkungan sekolah yang tidak aman, kurangnya rasa memiliki, dan hubungan yang buruk dengan guru atau staf sekolah dapat memengaruhi kesehatan mental siswa.

- d. **Media Sosial:** Paparan terhadap standar yang tidak realistis, perbandingan sosial, *cyberbullying*, dan kecanduan media sosial dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental. Namun, media sosial juga dapat menjadi sumber dukungan dan informasi yang positif jika digunakan dengan bijak.

- e. **Sosioekonomi:** Tingkat sosioekonomi keluarga yang rendah sering kali dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah kesehatan mental pada remaja akibat stres finansial dan kurangnya akses ke sumber daya.
- f. **Budaya dan Norma Sosial:** Norma budaya dan sosial terkait peran gender, ekspektasi, dan stigma terhadap masalah kesehatan mental dapat memengaruhi bagaimana remaja merasakan dan mencari bantuan untuk masalah mereka.
- g. **Diskriminasi dan Marginalisasi:** Remaja yang mengalami diskriminasi berdasarkan ras, etnis, orientasi seksual, identitas gender, atau status sosial ekonomi memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental.

4. **Faktor Pelindung:**

Penting untuk dicatat bahwa ada juga faktor-faktor pelindung yang dapat membantu remaja menjaga kesehatan mental mereka atau mengurangi dampak faktor risiko. Faktor-faktor ini meliputi:

- a. **Hubungan yang suportif** dengan keluarga, teman, dan orang dewasa lainnya.
- b. **Keterampilan sosial dan emosional** yang baik, termasuk kemampuan mengatasi stres, memecahkan masalah, dan mengelola emosi.
- c. **Harga diri yang sehat** dan rasa percaya diri.
- d. **Keterlibatan dalam kegiatan positif** seperti olahraga, seni, atau kegiatan ekstrakurikuler.
- e. **Koneksi dengan komunitas** dan rasa memiliki
- f. **Kesehatan fisik yang baik** dan gaya hidup sehat.
- g. **Akses ke layanan kesehatan mental** yang berkualitas.
- h. **Resiliensi** atau kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan.

Memahami kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental remaja sangat penting untuk mengembangkan intervensi dan dukungan yang efektif. Pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, dan sosial, diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mental remaja

1. Gejala Kesehatan Mental Remaja, gejala kesehatan mental remaja dapat bervariasi, tetapi beberapa tanda umum, antara lain:
 - 1) Perubahan mood yang ekstrem

- 2) Kurangnya minat dalam kegiatan yang biasanya disukai
 - 3) Kesulitan tidur atau insomnia
 - 4) Kesulitan konsentrasi atau memori
 - 5) Perilaku agresif atau destruktif
 - 6) Perilaku isolatif atau menghindari interaksi sosial (Nock, 2013)
2. Strategi Pencegahan Kesehatan Mental Remaja, beberapa strategi pencegahan kesehatan mental remaja, antara lain:
- 1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan mental
 - 2) Membangun dukungan sosial yang kuat
 - 3) Mengembangkan kemampuan menghadapi stres dan emosi
 - 4) Meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga
 - 5) Membatasi penggunaan teknologi dan media sosial (Kessler, 2003)
3. Dampak Jangka Pendek, dari kondisi kesehatan mental remaja dapat berdampak dalam jangka pendek adalah :
- 1) Menurunnya Prestasi Akademik: Kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan konsentrasi, sehingga berdampak pada prestasi akademik.
 - 2) Masalah Sosial: Kesehatan mental yang buruk dapat menyebabkan masalah sosial, seperti kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, konflik dengan keluarga, dan isolasi sosial.
 - 3) Perilaku Berisiko: Kesehatan mental yang buruk dapat meningkatkan perilaku berisiko, seperti penggunaan zat-zat terlarang, perilaku seksual yang tidak aman, dan perilaku agresif.
 - 4) Kesehatan Fisik yang Buruk: Kesehatan mental yang buruk dapat berdampak pada kesehatan fisik, seperti penurunan sistem imun, masalah tidur, dan peningkatan risiko penyakit kronis.
4. Dampak Jangka Panjang, dari kondisi kesehatan mental remaja berdampak dalam jangka panjang adalah :
- 1) Gangguan Mental yang Kronis: Kesehatan mental yang buruk pada remaja dapat meningkatkan risiko gangguan mental yang kronis, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar.
 - 2) Masalah Karir dan Pendidikan: Kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan dan memulai karir yang sukses.

- 3) Masalah Hubungan: Kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan untuk membentuk dan memelihara hubungan yang sehat dan positif.
- 4) Risiko Bunuh Diri: Kesehatan mental yang buruk dapat meningkatkan risiko bunuh diri, terutama jika tidak ditangani dengan tepat.

D. Model Kesehatan Mental Remaja Berbasis Komunitas

Model kesehatan mental remaja berbasis komunitas adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pengembangan kesehatan mental remaja melalui partisipasi dan dukungan dari komunitas. Model ini berdasarkan pada prinsip bahwa kesehatan mental remaja dapat dipromosikan dan didukung oleh komunitas. Tujuan model kesehatan mental remaja berbasis komunitas adalah:

1. Meningkatkan kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental remaja.
2. Mengembangkan kemampuan: Mengembangkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
3. Meningkatkan dukungan sosial: Meningkatkan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
4. Mengembangkan lingkungan yang mendukung: Mengembangkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.

Komponen model kesehatan mental remaja berbasis komunitas adalah:

1. Pengembangan Kemampuan: Pengembangan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
2. Pengembangan Dukungan Sosial: Pengembangan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
3. Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.
4. Pengembangan Partisipasi Komunitas: Pengembangan partisipasi komunitas dalam pengembangan kesehatan mental remaja.

Strategi Implementasi Model Kesehatan Mental Remaja Berbasis Komunitas

1. Pengembangan Program: Pengembangan program yang berfokus pada pengembangan kesehatan mental remaja.
2. Pengembangan Partisipasi Komunitas: Pengembangan partisipasi komunitas dalam pengembangan kesehatan mental remaja.

3. Pengembangan Dukungan Sosial: Pengembangan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
4. Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.

Tujuan Pengembangan Program

Tujuan pengembangan program kesehatan mental remaja berbasis komunitas adalah:

1. Meningkatkan kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental remaja.
2. Mengembangkan kemampuan: Mengembangkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
3. Meningkatkan dukungan sosial: Meningkatkan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
4. Mengembangkan lingkungan yang mendukung: Mengembangkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.

Komponen Program

Komponen program kesehatan mental remaja berbasis komunitas adalah:

1. Pengembangan Kemampuan: Pengembangan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
2. Pengembangan Dukungan Sosial: Pengembangan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
3. Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.
4. Pengembangan Partisipasi Komunitas: Pengembangan partisipasi komunitas dalam pengembangan kesehatan mental remaja.

Strategi Implementasi Program

Strategi implementasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas adalah:

1. Pengembangan Program: Pengembangan program yang berfokus pada pengembangan kesehatan mental remaja.
2. Pengembangan Partisipasi Komunitas: Pengembangan partisipasi komunitas dalam pengembangan kesehatan mental remaja.
3. Pengembangan Dukungan Sosial: Pengembangan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

4. Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.

Contoh Program

Contoh program kesehatan mental remaja berbasis komunitas adalah:

1. Program Pengembangan Kemampuan: Program yang berfokus pada pengembangan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
2. Program Dukungan Sosial: Program yang berfokus pada pengembangan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
3. Program Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Program yang berfokus pada pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.

Perencanaan Program

langkah-langkah pengembangan kesehatan mental remaja berbasis komunitas:

Langkah 1: Identifikasi Kebutuhan

1. Identifikasi kebutuhan: Identifikasi kebutuhan kesehatan mental remaja di komunitas.
2. Analisis data: Analisis data tentang kesehatan mental remaja di komunitas.
3. Pengembangan profil: Pengembangan profil kesehatan mental remaja di komunitas.

Langkah 2: Pengembangan Tim

1. Pengembangan tim: Pengembangan tim yang terdiri dari anggota komunitas, profesional kesehatan mental, dan remaja.
2. Pengembangan peran: Pengembangan peran dan tanggung jawab tim.
3. Pengembangan komunikasi: Pengembangan komunikasi yang efektif antara anggota tim.

Langkah 3: Pengembangan Program

1. Pengembangan program: Pengembangan program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.
2. Pengembangan kegiatan: Pengembangan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan remaja.

3. Pengembangan sumber daya: Pengembangan sumber daya yang diperlukan untuk program.

Langkah 4: Implementasi Program

1. Implementasi program: Implementasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.
2. Pengembangan partisipasi: Pengembangan partisipasi remaja dan komunitas dalam program.
3. Pengembangan evaluasi: Pengembangan evaluasi program untuk memastikan efektivitas.

Langkah 5: Evaluasi dan Perbaikan

1. Evaluasi program: Evaluasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.
2. Identifikasi kelemahan: Identifikasi kelemahan program dan pengembangan perbaikan.
3. Pengembangan perbaikan: Pengembangan perbaikan program untuk meningkatkan efektivitas.

Langkah 6: Pengembangan Berkelanjutan

1. Pengembangan berkelanjutan: Pengembangan program kesehatan mental remaja berbasis komunitas secara berkelanjutan.
2. Pengembangan partisipasi: Pengembangan partisipasi remaja dan komunitas dalam pengembangan program.
3. Pengembangan evaluasi: Pengembangan evaluasi program untuk memastikan efektivitas.

Program kesehatan mental remaja berbasis komunitas:

1. Program Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres
 - Nama program: "Kemampuan Menghadapi Stres"
 - Tujuan: Meningkatkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
 - Kegiatan:
 - Pelatihan kemampuan menghadapi stres
 - Diskusi kelompok tentang pengalaman menghadapi stres
 - Aktivitas relaksasi dan meditasi
 - Target: Remaja berusia 13-18 tahun

2. Program Dukungan Sosial untuk Remaja

- Nama program: "Dukungan Sosial untuk Remaja"
- Tujuan: Meningkatkan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- Kegiatan:
 - Pembentukan kelompok dukungan sosial
 - Pelatihan kemampuan mendengarkan dan memberikan dukungan
 - Aktivitas sosial dan rekreasi
- Target: Remaja berusia 13-18 tahun yang mengalami masalah kesehatan mental

3. Program Pengembangan Lingkungan yang Mendukung

- Nama program: "Lingkungan yang Mendukung"
- Tujuan: Meningkatkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.
- Kegiatan:
 - Pembentukan tim lingkungan yang mendukung
 - Pelatihan kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental
 - Aktivitas pengembangan lingkungan yang mendukung
- Target: Remaja berusia 13-18 tahun dan komunitas

4. Program Pengembangan Kemampuan Mengembangkan Kemampuan

- Nama program: "Kemampuan Mengembangkan Kemampuan"
- Tujuan: Meningkatkan kemampuan remaja untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan.
- Kegiatan:
 - Pelatihan kemampuan mengembangkan kemampuan
 - Diskusi kelompok tentang pengalaman mengembangkan kemampuan
 - Aktivitas pengembangan kemampuan dan keterampilan
- Target: Remaja berusia 13-18 tahun

5. Program Pengembangan Partisipasi Remaja

- Nama program: "Partisipasi Remaja"
- Tujuan: Meningkatkan partisipasi remaja dalam pengembangan kesehatan mental remaja.
- Kegiatan:

- Pembentukan tim partisipasi remaja
- Pelatihan kemampuan partisipasi dan pengambilan keputusan
- Aktivitas pengembangan partisipasi remaja
- Target: Remaja berusia 13-18 tahun

E. Peran dan fungsi komunitas dalam mendukung kesehatan mental remaja:

1. Peran Komunitas

- a. Pengembangan Dukungan Sosial: Komunitas dapat memberikan dukungan sosial kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- b. Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Komunitas dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.
- c. Pengembangan Kemampuan: Komunitas dapat mengembangkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
- b. Pengembangan Partisipasi: Komunitas dapat mengembangkan partisipasi remaja dalam pengembangan kesehatan mental remaja.

2. Fungsi Komunitas

- a. Fungsi Dukungan: Komunitas dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- b. Fungsi Edukasi: Komunitas dapat memberikan edukasi tentang kesehatan mental remaja dan cara menghadapi stres dan tekanan.
- c. Fungsi Advokasi: Komunitas dapat menjadi advokat untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental dan memperjuangkan hak-hak mereka.
- b. Fungsi Pengembangan: Komunitas dapat mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung kesehatan mental remaja.

3. Contoh Peran dan Fungsi Komunitas

- a. Pengembangan Kelompok Dukungan: Komunitas dapat mengembangkan kelompok dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- b. Pengembangan Program Edukasi: Komunitas dapat mengembangkan program edukasi tentang kesehatan mental remaja dan cara menghadapi stres dan tekanan.
- c. Pengembangan Kegiatan Rekreasi: Komunitas dapat mengembangkan kegiatan rekreasi yang mendukung kesehatan mental remaja.

- b. Pengembangan Jaringan Dukungan: Komunitas dapat mengembangkan jaringan dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

4. Peran keluarga dan teman sebaya dalam kesehatan mental remaja berbasis komunitas:

a. Peran Keluarga

- 1) Dukungan Emosional: Keluarga dapat memberikan dukungan emosional kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 2) Pengawasan dan Pengasuhan: Keluarga dapat mengawasi dan mengasuh remaja untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang tepat.
- 3) Pengembangan Kemampuan: Keluarga dapat mengembangkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
- 4) Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Keluarga dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.

b. Peran Teman Sebaya

- 1) Dukungan Sosial: Teman sebaya dapat memberikan dukungan sosial kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 2) Pengembangan Kemampuan: Teman sebaya dapat mengembangkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
- 3) Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Teman sebaya dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.
- 4) Pengembangan Partisipasi: Teman sebaya dapat mengembangkan partisipasi remaja dalam pengembangan kesehatan mental remaja.

c. Contoh Peran Keluarga dan Teman Sebaya

- 1) Pengembangan Kelompok Dukungan: Keluarga dan teman sebaya dapat mengembangkan kelompok dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 2) Pengembangan Program Edukasi: Keluarga dan teman sebaya dapat mengembangkan program edukasi tentang kesehatan mental remaja dan cara menghadapi stres dan tekanan.

- 3) Pengembangan Kegiatan Rekreasi: Keluarga dan teman sebaya dapat mengembangkan kegiatan rekreasi yang mendukung kesehatan mental remaja.
- 4) Pengembangan Jaringan Dukungan: Keluarga dan teman sebaya dapat mengembangkan jaringan dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

5. Peran sekolah dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kesehatan mental remaja berbasis masyarakat:

a. Peran Sekolah

- 1) Pengembangan Kurikulum: Sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang mendukung kesehatan mental remaja.
- 2) Pengembangan Program Edukasi: Sekolah dapat mengembangkan program edukasi tentang kesehatan mental remaja dan cara menghadapi stres dan tekanan.
- 3) Pengembangan Dukungan Sosial: Sekolah dapat mengembangkan dukungan sosial dari guru dan teman sebaya untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 4) Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Sekolah dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.

b. Peran Lembaga Masyarakat

- 1) Pengembangan Program Kesehatan Mental: Lembaga masyarakat dapat mengembangkan program kesehatan mental untuk remaja.
- 2) Pengembangan Dukungan Sosial: Lembaga masyarakat dapat mengembangkan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 3) Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Lembaga masyarakat dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.
- 4) Pengembangan Jaringan Dukungan: Lembaga masyarakat dapat mengembangkan jaringan dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

c. Contoh Peran Sekolah dan Lembaga Masyarakat

- 1) Pengembangan Kelompok Dukungan: Sekolah dan lembaga masyarakat dapat mengembangkan kelompok dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 2) Pengembangan Program Edukasi: Sekolah dan lembaga masyarakat dapat mengembangkan program edukasi tentang kesehatan mental remaja dan cara menghadapi stres dan tekanan.
- 3) Pengembangan Kegiatan Rekreasi: Sekolah dan lembaga masyarakat dapat mengembangkan kegiatan rekreasi yang mendukung kesehatan mental remaja.
- 4) Pengembangan Jaringan Dukungan: Sekolah dan lembaga masyarakat dapat mengembangkan jaringan dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

6. Strategi intervensi kesehatan mental remaja berbasis komunitas:

a. Strategi Intervensi Primer

- 1) Pengembangan Kemampuan: Pengembangan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
- 2) Pengembangan Dukungan Sosial: Pengembangan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 3) Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.

b. Strategi Intervensi Sekunder

- 1) Pengembangan Program Edukasi: Pengembangan program edukasi tentang kesehatan mental remaja dan cara menghadapi stres dan tekanan.
- 2) Pengembangan Kelompok Dukungan: Pengembangan kelompok dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 3) Pengembangan Jaringan Dukungan: Pengembangan jaringan dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

c. Strategi Intervensi Tersier

- 1) Pengembangan Program Terapi: Pengembangan program terapi untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 2) Pengembangan Program Rehabilitasi: Pengembangan program rehabilitasi untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

- 3) Pengembangan Program Dukungan Jangka Panjang: Pengembangan program dukungan jangka panjang untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- d. Strategi Intervensi Berbasis Komunitas
- 1) Pengembangan Program Berbasis Komunitas: Pengembangan program berbasis komunitas untuk meningkatkan kesehatan mental remaja.
 - 2) Pengembangan Jaringan Dukungan Berbasis Komunitas: Pengembangan jaringan dukungan berbasis komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
 - 3) Pengembangan Program Edukasi Berbasis Komunitas: Pengembangan program edukasi berbasis komunitas tentang kesehatan mental remaja dan cara menghadapi stres dan tekanan.

7. Strategi pencegahan dan promosi kesehatan mental:

- a. Strategi Pencegahan
- 1) Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres: Pengembangan kemampuan menghadapi stres dan tekanan.
 - 2) Pengembangan Dukungan Sosial: Pengembangan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas.
 - 3) Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental.
 - 4) Pengembangan Program Edukasi: Pengembangan program edukasi tentang kesehatan mental dan cara menghadapi stres dan tekanan.
- b. Strategi Promosi
- 1) Pengembangan Program Promosi Kesehatan Mental: Pengembangan program promosi kesehatan mental untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan mental.
 - 2) Pengembangan Jaringan Dukungan: Pengembangan jaringan dukungan untuk individu yang mengalami masalah kesehatan mental.
 - 3) Pengembangan Program Rekreasi: Pengembangan program rekreasi untuk meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres.
 - 4) Pengembangan Program Dukungan Psikologis: Pengembangan program dukungan psikologis untuk individu yang mengalami masalah kesehatan mental.
- c. Strategi Pencegahan dan Promosi Berbasis Komunitas

- 1) Pengembangan Program Berbasis Komunitas: Pengembangan program berbasis komunitas untuk meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres.
- 2) Pengembangan Jaringan Dukungan Berbasis Komunitas: Pengembangan jaringan dukungan berbasis komunitas untuk individu yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 3) Pengembangan Program Edukasi Berbasis Komunitas: Pengembangan program edukasi berbasis komunitas tentang kesehatan mental dan cara menghadapi stres dan tekanan.

8. Strategi intervensi dan pengobatan kesehatan mental remaja:

a. Strategi Intervensi

- 1) Terapi Kognitif-Behavioral (CBT): Terapi yang berfokus pada mengubah pola pikir dan perilaku negatif.
- 2) Terapi Keluarga: Terapi yang melibatkan keluarga untuk membantu remaja mengatasi masalah kesehatan mental.
- 3) Terapi Kelompok: Terapi yang melibatkan remaja lain yang mengalami masalah kesehatan mental yang sama.
- 4) Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres: Pengembangan kemampuan menghadapi stres dan tekanan.

b. Strategi Pengobatan

- 1) Pengobatan Farmakologi: Pengobatan menggunakan obat-obatan untuk mengatasi gejala kesehatan mental.
- 2) Pengobatan Psikoterapi: Pengobatan menggunakan terapi psikologis untuk mengatasi masalah kesehatan mental.
- 3) Pengobatan Berbasis Komunitas: Pengobatan yang melibatkan komunitas untuk membantu remaja mengatasi masalah kesehatan mental.

c. Strategi Intervensi dan Pengobatan Berbasis Komunitas

- 1) Pengembangan Program Berbasis Komunitas: Pengembangan program berbasis komunitas untuk membantu remaja mengatasi masalah kesehatan mental.
- 2) Pengembangan Jaringan Dukungan Berbasis Komunitas: Pengembangan jaringan dukungan berbasis komunitas untuk membantu remaja mengatasi masalah kesehatan mental.

- 3) Pengembangan Program Edukasi Berbasis Komunitas: Pengembangan program edukasi berbasis komunitas tentang kesehatan mental dan cara menghadapi stres dan tekanan.

9. Implementasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas:

a. Tahap Persiapan

- 1) Identifikasi Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan kesehatan mental remaja di komunitas.
- 2) Pengembangan Tim: Pengembangan tim yang terdiri dari anggota komunitas, profesional kesehatan mental, dan remaja.
- 3) Pengembangan Program: Pengembangan program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.

b. Tahap Implementasi

- 1) Pengembangan Kegiatan: Pengembangan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan remaja.
- 2) Pengembangan Materi: Pengembangan materi yang sesuai dengan kebutuhan remaja.
- 3) Pengembangan Fasilitas: Pengembangan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan remaja.
- 4) Pengembangan Evaluasi: Pengembangan evaluasi program untuk memastikan efektivitas.

c. Tahap Evaluasi

- 1) Evaluasi Program: Evaluasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.
- 2) Identifikasi Kelemahan: Identifikasi kelemahan program dan pengembangan perbaikan.
- 3) Pengembangan Perbaikan: Pengembangan perbaikan program untuk meningkatkan efektivitas.

d. Contoh Implementasi Program

- 1) Program Pengembangan Kemampuan: Program pengembangan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
- 2) Program Dukungan Sosial: Program dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
- 3) Program Edukasi: Program edukasi tentang kesehatan mental remaja dan cara menghadapi stres dan tekanan.

- 4) Program Rekreasi: Program rekreasi yang mendukung kesehatan mental remaja.

10. Langkah-langkah implementasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas:

Langkah 1: Perencanaan Program

1. Identifikasi Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan kesehatan mental remaja di komunitas.
2. Pengembangan Tim: Pengembangan tim yang terdiri dari anggota komunitas, profesional kesehatan mental, dan remaja.
3. Pengembangan Program: Pengembangan program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.

Langkah 2: Pengembangan Kegiatan

1. Pengembangan Kegiatan: Pengembangan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan remaja.
2. Pengembangan Materi: Pengembangan materi yang sesuai dengan kebutuhan remaja.
3. Pengembangan Fasilitas: Pengembangan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan remaja.

Langkah 3: Implementasi Program

1. Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan dan evaluasi program untuk memastikan efektivitas.
3. Pengembangan Partisipasi: Pengembangan partisipasi remaja dan komunitas dalam program.

Langkah 4: Evaluasi dan Perbaikan

1. Evaluasi Program: Evaluasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.
2. Identifikasi Kelemahan: Identifikasi kelemahan program dan pengembangan perbaikan.
3. Pengembangan Perbaikan: Pengembangan perbaikan program untuk meningkatkan efektivitas.

Langkah 5: Pengembangan Berkelanjutan

1. Pengembangan Program Berkelanjutan: Pengembangan program kesehatan mental remaja berbasis komunitas secara berkelanjutan.
2. Pengembangan Partisipasi Berkelanjutan: Pengembangan partisipasi remaja dan komunitas dalam program secara berkelanjutan.
3. Pengembangan Evaluasi Berkelanjutan: Pengembangan evaluasi program secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas.

11. Langkah-langkah implementasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas:

Langkah 1: Perencanaan Program

1. Identifikasi Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan kesehatan mental remaja di komunitas.
2. Pengembangan Tim: Pengembangan tim yang terdiri dari anggota komunitas, profesional kesehatan mental, dan remaja.
3. Pengembangan Program: Pengembangan program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.

Langkah 2: Pengembangan Kegiatan

1. Pengembangan Kegiatan: Pengembangan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan remaja.
2. Pengembangan Materi: Pengembangan materi yang sesuai dengan kebutuhan remaja.
3. Pengembangan Fasilitas: Pengembangan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan remaja.

Langkah 3: Implementasi Program

1. Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan dan evaluasi program untuk memastikan efektivitas.
3. Pengembangan Partisipasi: Pengembangan partisipasi remaja dan komunitas dalam program.

Langkah 4: Evaluasi dan Perbaikan

1. Evaluasi Program: Evaluasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.
2. Identifikasi Kelemahan: Identifikasi kelemahan program dan pengembangan perbaikan.

3. Pengembangan Perbaikan: Pengembangan perbaikan program untuk meningkatkan efektivitas.

Langkah 5: Pengembangan Berkelanjutan

1. Pengembangan Program Berkelanjutan: Pengembangan program kesehatan mental remaja berbasis komunitas secara berkelanjutan.
2. Pengembangan Partisipasi Berkelanjutan: Pengembangan partisipasi remaja dan komunitas dalam program secara berkelanjutan.
3. Pengembangan Evaluasi Berkelanjutan: Pengembangan evaluasi program secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas.

Langkah 6: Pengembangan Jaringan Dukungan

1. Pengembangan Jaringan Dukungan: Pengembangan jaringan dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
2. Pengembangan Partisipasi Jaringan Dukungan: Pengembangan partisipasi remaja dan komunitas dalam jaringan dukungan.
3. Pengembangan Evaluasi Jaringan Dukungan: Pengembangan evaluasi jaringan dukungan untuk memastikan efektivitas.

12. Beberapa contoh implementas program kesehatan mental remaja berbasis komunitas:

Program 1: Program Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres

1. Nama Program: "Kemampuan Menghadapi Stres"
2. Tujuan: Meningkatkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
3. Kegiatan:
 - Pelatihan kemampuan menghadapi stres
 - Diskusi kelompok tentang pengalaman menghadapi stres
 - Aktivitas relaksasi dan meditasi
4. Target: Remaja berusia 13-18 tahun

Program 2: Program Dukungan Sosial untuk Remaja

1. Nama Program: "Dukungan Sosial untuk Remaja"
2. Tujuan: Meningkatkan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
3. Kegiatan:
 - Pembentukan kelompok dukungan sosial

- Pelatihan kemampuan mendengarkan dan memberikan dukungan
 - Aktivitas sosial dan rekreasi
5. Target: Remaja berusia 13-18 tahun yang mengalami masalah kesehatan mental

Program 3: Program Pengembangan Lingkungan yang Mendukung

1. Nama Program: "Lingkungan yang Mendukung"
2. Tujuan: Meningkatkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.
3. Kegiatan:
 - Pembentukan tim lingkungan yang mendukung
 - Pelatihan kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental
 - Aktivitas pengembangan lingkungan yang mendukung
4. Target: Remaja berusia 13-18 tahun dan komunitas

Program 4: Program Pengembangan Partisipasi Remaja

1. Nama Program: "Partisipasi Remaja"
2. Tujuan: Meningkatkan partisipasi remaja dalam pengembangan kesehatan mental remaja.
3. Kegiatan:
 - Pembentukan tim partisipasi remaja
 - Pelatihan kemampuan partisipasi dan pengambilan keputusan
 - Aktivitas pengembangan partisipasi remaja
4. Target: Remaja berusia 13-18 tahun

13. Bentuk Evaluasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas yang dapat dilaksanakan adalah :

- a. Tujuan Evaluasi
 - 1) Menilai Efektivitas: Menilai efektivitas program dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.
 - 2) Menilai Kualitas: Menilai kualitas program dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.
 - 3) Menilai Keterlibatan: Menilai keterlibatan remaja dan komunitas dalam program.
- b. Metode Evaluasi

- 1) Studi Kualitatif: Studi kualitatif untuk menilai efektivitas dan kualitas program.
 - 2) Studi Kuantitatif: Studi kuantitatif untuk menilai efektivitas dan kualitas program.
 - 3) Pengumpulan Data: Pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan observasi.
- c. Indikator Evaluasi
- 1) Pengetahuan: Pengetahuan remaja tentang kesehatan mental.
 - 2) Sikap: Sikap remaja terhadap kesehatan mental.
 - 3) Perilaku: Perilaku remaja dalam meningkatkan kesehatan mental.
 - 4) Keterlibatan: Keterlibatan remaja dan komunitas dalam program.
- d. Hasil Evaluasi
- 1) Peningkatan Pengetahuan: Peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan mental.
 - 2) Peningkatan Sikap: Peningkatan sikap remaja terhadap kesehatan mental.
 - 3) Peningkatan Perilaku: Peningkatan perilaku remaja dalam meningkatkan kesehatan mental.
 - 4) Peningkatan Keterlibatan: Peningkatan keterlibatan remaja dan komunitas dalam program.

14.Rekomendasi

- a. Pengembangan Program: Pengembangan program yang lebih efektif dan berkualitas.
- b. Peningkatan Keterlibatan: Peningkatan keterlibatan remaja dan komunitas dalam program.
- c. Pengembangan Sumber Daya: Pengembangan sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung program.

15.Langkah-langkah evaluasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas:

Langkah 1: Perencanaan Evaluasi

1. Menentukan Tujuan Evaluasi: Menentukan tujuan evaluasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.

2. Menentukan Metode Evaluasi: Menentukan metode evaluasi yang akan digunakan, seperti studi kualitatif atau kuantitatif.
3. Menentukan Indikator Evaluasi: Menentukan indikator evaluasi yang akan digunakan untuk menilai efektivitas program.

Langkah 2: Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer: Pengumpulan data primer melalui survei, wawancara, atau observasi.
2. Pengumpulan Data Sekunder: Pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti laporan atau artikel.
3. Pengumpulan Data dari Berbagai Sumber: Pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti remaja, orang tua, atau petugas kesehatan.

Langkah 3: Analisis Data

1. Analisis Data Kualitatif: Analisis data kualitatif menggunakan metode analisis data kualitatif, seperti analisis tema atau analisis konten.
2. Analisis Data Kuantitatif: Analisis data kuantitatif menggunakan metode analisis data kuantitatif, seperti analisis statistik atau analisis regresi.
3. Analisis Data untuk Menilai Efektivitas Program: Analisis data untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.

Langkah 4: Interpretasi Hasil

1. Interpretasi Hasil Analisis Data: Interpretasi hasil analisis data untuk menentukan efektivitas program.
2. Identifikasi Kelemahan dan Kekuatan Program: Identifikasi kelemahan dan kekuatan program untuk meningkatkan efektivitas program.
3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Program: Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.

Langkah 5: Pelaporan dan Diseminasi Hasil

1. Pelaporan Hasil Evaluasi: Pelaporan hasil evaluasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas.
2. Diseminasi Hasil Evaluasi: Diseminasi hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang terkait, seperti remaja, orang tua, atau petugas kesehatan.
3. Penggunaan Hasil Evaluasi untuk Meningkatkan Efektivitas Program: Penggunaan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.

16. Evaluasi program kesehatan mental remaja berbasis komunitas

Contoh Evaluasi Program 1: Evaluasi Program Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres

1. Tujuan Evaluasi: Menilai efektivitas program pengembangan kemampuan menghadapi stres dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.
2. Metode Evaluasi: Studi kualitatif dengan wawancara dan observasi.
3. Indikator Evaluasi: Pengetahuan remaja tentang stres, sikap remaja terhadap stres, dan perilaku remaja dalam menghadapi stres.
4. Hasil Evaluasi: Program pengembangan kemampuan menghadapi stres efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dalam menghadapi stres.

Contoh Evaluasi Program 2: Evaluasi Program Dukungan Sosial untuk Remaja

1. Tujuan Evaluasi: Menilai efektivitas program dukungan sosial dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.
2. Metode Evaluasi: Studi kuantitatif dengan survei dan analisis statistik.
3. Indikator Evaluasi: Keterlibatan remaja dalam program, peningkatan kesehatan mental remaja, dan kepuasan remaja terhadap program.
4. Hasil Evaluasi: Program dukungan sosial efektif dalam meningkatkan keterlibatan remaja, kesehatan mental remaja, dan kepuasan remaja terhadap program.

Contoh Evaluasi Program 3: Evaluasi Program Pengembangan Lingkungan yang Mendukung

1. Tujuan Evaluasi: Menilai efektivitas program pengembangan lingkungan yang mendukung dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.
2. Metode Evaluasi: Studi kualitatif dengan wawancara dan observasi.
3. Indikator Evaluasi: Pengetahuan remaja tentang lingkungan yang mendukung, sikap remaja terhadap lingkungan yang mendukung, dan perilaku remaja dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.
4. Hasil Evaluasi: Program pengembangan lingkungan yang mendukung efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.

F. Penutup

Kesimpulan dan Rekomendasi kesehatan mental remaja berbasis komunitas

Kesimpulan

1. Kesehatan Mental Remaja: Kesehatan mental remaja adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup remaja.
2. Pentingnya Komunitas: Komunitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan mental remaja melalui dukungan sosial dan lingkungan yang mendukung.
3. Program Kesehatan Mental Remaja Berbasis Komunitas: Program kesehatan mental remaja berbasis komunitas dapat efektif dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.

Rekomendasi

1. Pengembangan Program Kesehatan Mental Remaja Berbasis Komunitas: Pengembangan program kesehatan mental remaja berbasis komunitas yang lebih efektif dan berkualitas.
2. Peningkatan Dukungan Sosial: Peningkatan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
3. Pengembangan Lingkungan yang Mendukung: Pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja.
4. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan: Peningkatan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan mental dan cara menghadapi stres dan tekanan.
5. Pengembangan Jaringan Dukungan: Pengembangan jaringan dukungan untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

Rekomendasi 1: Pengembangan Program Berbasis Komunitas yang Lebih Efektif

1. Pengembangan Program yang Berfokus pada Kebutuhan Remaja: Pengembangan program yang berfokus pada kebutuhan remaja dan melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan.
2. Pengembangan Program yang Berbasis pada Bukti Ilmiah: Pengembangan program yang berbasis pada bukti ilmiah dan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan mental remaja.

Rekomendasi 2: Pengembangan Jaringan Dukungan yang Lebih Kuat

1. Pengembangan Jaringan Dukungan yang Melibatkan Remaja, Keluarga, dan Komunitas: Pengembangan jaringan dukungan yang melibatkan remaja, keluarga, dan komunitas untuk mendukung kesehatan mental remaja.
2. Pengembangan Jaringan Dukungan yang Berbasis pada Teknologi Informasi: Pengembangan jaringan dukungan yang berbasis pada teknologi informasi, seperti aplikasi dan platform online, untuk mendukung kesehatan mental remaja.

Rekomendasi 3: Pengembangan Lingkungan yang Lebih Mendukung

1. Pengembangan Lingkungan yang Aman dan Mendukung: Pengembangan lingkungan yang aman dan mendukung kesehatan mental remaja, seperti sekolah dan komunitas yang aman dan mendukung.
2. Pengembangan Lingkungan yang Berbasis pada Kebutuhan Remaja: Pengembangan lingkungan yang berbasis pada kebutuhan remaja dan melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Rekomendasi 4: Pengembangan Kegiatan yang Lebih Beragam

1. Pengembangan Kegiatan yang Berbasis pada Kebutuhan Remaja: Pengembangan kegiatan yang berbasis pada kebutuhan remaja dan melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan.
2. Pengembangan Kegiatan yang Berbasis pada Teknologi Informasi: Pengembangan kegiatan yang berbasis pada teknologi informasi, seperti aplikasi dan platform online, untuk mendukung kesehatan mental remaja.

Berikut adalah contoh lampiran yang berisi contoh program kesehatan mental remaja berbasis komunitas, instrumen evaluasi, dan lain-lain:

Lampiran 1: Contoh Program Kesehatan Mental Remaja Berbasis Komunitas

Program Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres

1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
2. Kegiatan:
 - Pelatihan kemampuan menghadapi stres
 - Diskusi kelompok tentang pengalaman menghadapi stres
 - Aktivitas relaksasi dan meditasi
3. Target: Remaja berusia 13-18 tahun

Program Dukungan Sosial untuk Remaja

1. Tujuan: Meningkatkan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.
2. Kegiatan:
 - Pembentukan kelompok dukungan sosial
 - Pelatihan kemampuan mendengarkan dan memberikan dukungan
 - Aktivitas sosial dan rekreasi
3. Target: Remaja berusia 13-18 tahun yang mengalami masalah kesehatan mental

Lampiran 2: Instrumen Evaluasi

Instrumen Evaluasi Program Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres

1. Kuesioner: Kuesioner tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dalam menghadapi stres.
2. Skala: Skala tentang kemampuan remaja dalam menghadapi stres.
3. Wawancara: Wawancara dengan remaja tentang pengalaman mereka dalam menghadapi stres.

Instrumen Evaluasi Program Dukungan Sosial untuk Remaja

1. Kuesioner: Kuesioner tentang kepuasan remaja terhadap program dukungan sosial.
2. Skala: Skala tentang kemampuan remaja dalam mendapatkan dukungan sosial.
3. Observasi: Observasi tentang aktivitas remaja dalam program dukungan sosial.

Lampiran 3: Contoh Lembar Kerja untuk Program Kesehatan Mental Remaja Berbasis Komunitas

Lembar Kerja untuk Program Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres

1. Nama Program: Program Pengembangan Kemampuan Menghadapi Stres
2. Tujuan: Meningkatkan kemampuan remaja untuk menghadapi stres dan tekanan.
3. Kegiatan: Pelatihan kemampuan menghadapi stres, diskusi kelompok, aktivitas relaksasi dan meditasi.
4. Target: Remaja berusia 13-18 tahun.

Lembar Kerja untuk Program Dukungan Sosial untuk Remaja

1. Nama Program: Program Dukungan Sosial untuk Remaja
2. Tujuan: Meningkatkan dukungan sosial dari komunitas untuk remaja yang mengalami masalah kesehatan mental.

3. Kegiatan: Pembentukan kelompok dukungan sosial, pelatihan kemampuan mendengarkan dan memberikan dukungan, aktivitas sosial dan rekreasi.
4. Target: Remaja berusia 13-18 tahun yang mengalami masalah kesehatan mental.

Referensi

- American Psychological Association. (2020). Mental health in adolescence.
- Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.
- Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. W.W. Norton & Company.
- Garmezy, N. (1991). Vulnerability and resilience in children at risk. *American Journal of Orthopsychiatry*, 61(2), 159-173.
- Hankin, B. L. (2012). Future directions in vulnerability to depression among youth. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 41(2), 151-163.
- Hartup, W. W. (1999). Friendships and adaptation in the life course. *Psychological Bulletin*, 125(6), 727-753.
- Health Organization's World Mental Health Survey Initiative. *World Psychiatry*, 2(2), 114-125.
- Kemenkes RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018.
- Kemenkes RI. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Mental.
- Kessler, R. C. (2003). The prevalence and correlates of serious mental illness (SMI) in the World
- Kemenkes RI. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Mental.
- National Alliance on Mental Illness. (2020). Mental health in adolescence.
- Nock, M. K. (2013). Suicide and self-injury. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, & L. F. Barrett (Eds.), *Handbook of emotions* (3rd ed., pp. 845-857). New York: Guilford Press.
- UNICEF. (2020). Mental health and well-being
- World Federation for Mental Health. (2020). Mental health in adolescence
- WHO. (2018). Adolescent health.

Profil Penulis



Nina Rizka Rohmawati, S.Kep.Ns., M.Kep

Lahir di Sidoarjo, 22 Februari 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Airlangga pada tahun 2010 lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan sebagai dosen diawali pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia mengampu mata kuliah

Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gerontik, Psikologi, Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nr22099290@gmail.com
Motto: "Living your life well" (**opsional jika ingin ditambahkan**)



Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An

Lahir di Cilacap, 22 April. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners, Universitas Padjadjaran tahun 2010 dan 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan Spesialis Keperawatan Anak pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2016 dan 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sebagai

Perawat Anak di RS Hermina Pasteur. Saat ini penulis bekerja di Universitas Indonesia Maju mengampu mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit serta Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi pada Jurnal Nasional Terindeks SINTA maupun Jurnal Internasional bereputasi SCOPUS. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurenilestari@gmail.com

Motto: Selalu Menebar Kebermanfaatan



Ns. Nuniek Setyo Wardani, S. Kep., M. Kep

Dosen Program Studi Profesi Ners
Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kebidanan
Universitas Binawan

Penulis lahir di Pontianak pada tahun 1980. Penulis pernah bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah (STIKMUH) Pontianak dari tahun 2005-2018 sebagai Dosen program studi Diploma 3, S1 dan Ners. Selama penulis bekerja di STIKMUH Pontianak, penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Diploma 3 Keperawatan, Sekretaris Komite Etik, dan Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan. Penulis merupakan lulusan Akademi Keperawatan Yarsi untuk program Diploma Keperawatan 3 pada tahun 1998-2001. Penulis kemudian melanjutkan ke jenjang S1 dan Ners pada Universitas Indonesia tahun 2002-2005 yang kemudian melanjutkan ke program studi Magister Keperawatan Kekhususan Jiwa di Universitas yang sama pada tahun 2009-2011. Saat ini penulis menjadi Dosen Program Studi Profesi Ners di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sweetnoens@gmail.com



Ahmad Guntur Alfianto, S.Kep., Ns., M. Kep. Lahir di Malang, 15 Mei 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Program Studi Ilmu Keperawatan (Fakultas Keperawatan) Universitas Jember lulus tahun 2013 dan 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran dengan peminatan keperawatan Jiwa di Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2018. Riwat pekerjaan diawali pada tahun 2018 mengembangkan

School Mental health In Rural (SAMAIL) sebagai bentuk intervensi pelayanan keperawatan jiwa pada anak usia sekolah dan remaja di desa. Saat ini penulis bekerja di STIKES Widyagama Husada Malang mengampu mata kuliah Keperawatan kesehatan jiwa dan Psikososial, Keperawatan Gangguan Jiwa, Keperawatan Keluarga, Agregat keperawatan komunitas, keperawatan bencana, dan Keperawatan komplementer. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku sebanyak 19 buah, Jurnal terindeks sinta dan scopus, dan penghargaan bidang kesehatan satu Indonesia Awards (SIA) tahun 2021 bidang kesehatan, serta

dosen berpresetasi 2021 STIKES Widyagama Husada Malang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ahmadguntur@widyagamahusada.ac.id

Motto: "Kerjakan apa yang kamu bisa saat ini"



H. Syahrul, SKM., M.Kes.

Lahir di Pariaman, 03 Oktober 1962. Pendidikan setelah tamat SMA N Solok, mengikuti pendidikan Sekolah Pembantu Paramedis Umum tahun 1982 kemudian melanjutkan sebagai tugas belajar Lulus Akper Depkes Otten Bandung tahun 1988, S1 Kesehatan Masyarakat FKM USU Medan Tahun 1993, dan S2 Kesehatan Masyarakat FKM UI Jakarta Tahun 2004. Mengawali karier sebagai PNS di Puskesmas pada tahun 1982 sampai mengakhiri pengabdian sebagai ASN dengan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman tahun 2022, karena ketertarikan kepada dunia pendidikan diawali sebagai Guru Tidak Tetap di Sekolah Perawat Kesehatan Pemda Kabupaten Pariaman, Dosen dan Ketua Pada Stikes Nantongga Lubuk Alung dan sekarang setelah Purna Bakti mengabdikan waktu sebagai Ketua Stikes Piala Sakti Pariaman. Penulis juga sebagai pengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keselamatan Pasien dan K3 serta Pendidikan dan Promosi Kesehatan.. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Selain itu sebagai insan perawat mengembangkan organisasi PPNI di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman selaku ketua DPD dan terakhir saat ini sebagai Dewan Pertimbangan DPW PPNI Propinsi Sumatera Barat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syahrul.mkes@gmail.com

Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Buku referensi "**Meningkatkan Kesehatan Mental di Kalangan Remaja**" membahas secara komprehensif berbagai faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, baik internal maupun eksternal. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perubahan hormonal, gangguan identitas, isolasi sosial, stres akademik, masalah keluarga, pengaruh teman sebaya, perundungan, hingga pengalaman traumatis dapat mempengaruhi kondisi psikologis remaja.

Selain membahas faktor risiko, buku ini juga mengulas peran pola asuh dalam perkembangan mental remaja. Penjelasan diberikan tentang jenis-jenis pola asuh orang tua, mulai dari pola otoritatif hingga pola tidak terlibat, serta dampaknya terhadap perkembangan emosional, sosial, dan kognitif remaja. Materi ini penting untuk dipahami oleh orang tua maupun tenaga pendidik agar dapat memberikan dukungan yang optimal bagi remaja dalam menghadapi tantangan kehidupannya.

Selanjutnya, buku ini menyoroti peran strategis sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental siswa. Dibahas secara rinci berbagai upaya yang dapat dilakukan sekolah, mulai dari pencegahan primer melalui pendidikan kesehatan, pencegahan sekunder melalui deteksi dini masalah mental, hingga pencegahan tersier yang mencakup intervensi dan manajemen krisis kesehatan mental.

Pemanfaatan aplikasi digital dalam pelayanan kesehatan mental juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam buku ini. Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran vital dalam mendukung remaja mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan mental melalui konseling online berbasis aplikasi. Pembahasan ini dilengkapi dengan analisis hambatan dan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan akses layanan kesehatan mental melalui media digital.

Dengan pendekatan yang sistematis dan holistik, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan penting bagi berbagai kalangan dalam menciptakan generasi remaja yang sehat secara mental, produktif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan resilien dan optimisme tinggi.

Buku referensi "Meningkatkan Kesehatan Mental di Kalangan Remaja" membahas secara komprehensif berbagai faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, baik internal maupun eksternal. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perubahan hormonal, gangguan identitas, isolasi sosial, stres akademik, masalah keluarga, pengaruh teman sebaya, perundungan, hingga pengalaman traumatis dapat mempengaruhi kondisi psikologis remaja.

Selain membahas faktor risiko, buku ini juga mengulas peran pola asuh dalam perkembangan mental remaja. Penjelasan diberikan tentang jenis-jenis pola asuh orang tua, mulai dari pola otoritatif hingga pola tidak terlibat, serta dampaknya terhadap perkembangan emosional, sosial, dan kognitif remaja. Materi ini penting untuk dipahami oleh orang tua maupun tenaga pendidik agar dapat memberikan dukungan yang optimal bagi remaja dalam menghadapi tantangan kehidupannya.

Selanjutnya, buku ini menyoroti peran strategis sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental siswa. Dibahas secara rinci berbagai upaya yang dapat dilakukan sekolah, mulai dari pencegahan primer melalui pendidikan kesehatan, pencegahan sekunder melalui deteksi dini masalah mental, hingga pencegahan tersier yang mencakup intervensi dan manajemen krisis kesehatan mental.

Pemanfaatan aplikasi digital dalam pelayanan kesehatan mental juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam buku ini. Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran vital dalam mendukung remaja mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan mental melalui konseling online berbasis aplikasi. Pembahasan ini dilengkapi dengan analisis hambatan dan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan akses layanan kesehatan mental melalui media digital.

Dengan pendekatan yang sistematis dan holistik, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan penting bagi berbagai kalangan dalam menciptakan generasi remaja yang sehat secara mental, produktif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan resilien dan optimisme tinggi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

